anrs
MALADIES INFECTIEUSES ÉMERGENTES Inserm

CNS
Conseil national du sida et des hépatites virales

RECOMMANDER
LES BONNES PRATIQUES

ARGUMENTAIRE

Prévention et dépistage de l'infection VIH

Nov 2024

Les recommandations de bonne pratique (RBP) sont définies dans le champ de la santé comme des propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données.

Les RBP sont des synthèses rigoureuses de l'état de l'art et des données de la science à un temps donné, décrites dans l'argumentaire scientifique. Elles ne sauraient dispenser le professionnel de santé de faire preuve de discernement dans sa prise en charge du patient, qui doit être celle qu'il estime la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient.

Cette recommandation de bonne pratique a été élaborée selon la méthode résumée dans l'argumentaire scientifique et décrite dans le guide méthodologique de la HAS disponible sur son site : Élaboration de recommandations de bonne pratique – Méthode Recommandations pour la pratique clinique.

Les objectifs de cette recommandation, la population et les professionnels concernés par sa mise en œuvre sont brièvement présentés en dernière page (fiche descriptive) et détaillés dans l'argumentaire scientifique.

Ce dernier ainsi que la synthèse de la recommandation sont téléchargeables sur www.has-sante.fr.

Grade des recommandations

A	**Preuve scientifique établie** Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse d'essais comparatifs randomisés, analyse de décision basée sur des études bien menées.
B	**Présomption scientifique** Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau intermédiaire de preuve (niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs randomisés de faible puissance, des études comparatives non randomisées bien menées, des études de cohorte.
C	**Faible niveau de preuve** Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-témoins (niveau de preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des études comparatives comportant des biais importants (niveau de preuve 4).
AE	**Accord d'experts** En l'absence d'études, les recommandations sont fondées sur un accord entre experts du groupe de travail, après consultation du groupe de lecture. L'absence de gradation ne signifie pas que les recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en revanche, inciter à engager des études complémentaires.

Descriptif de la publication

Titre	Prévention et dépistage de l'infection VIH (argumentaire)
Méthode de travail	Recommandation pour la pratique clinique (RPC)
Objectif(s)	Actualiser les recommandations de prévention et de dépistage de l'infection VIH en France
Cibles concernées	Patients concernés par le thème : personnes exposées au VIH, aux hépatites virales B, C et Delta et aux IST ; personnes vivant avec le VIH (PVVIH) non encore dépistées Professionnels concernés par le thème : médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, travailleurs sociaux impliqués dans la prévention et le dépistage de l'infection VIH, des hépatites virales et des IST Décideurs des politiques publiques Associations de patients
Demandeur	Ministère de la santé et de la prévention
Promoteur(s)	Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS) et Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS) Maladies infectieuses émergentes
Pilotage du projet	Pr Pierre Delobel, infectiologue, CHU de Toulouse
Auteurs	Groupe de travail « Epidémiologie, prévention, dépistage et déterminants sociaux de l'infection VIH en France » sous la direction du Dr Karen Champenois (épidémiologiste, IAME, Inserm UMR1137, Paris) et du Dr Cyrille Delpierre (épidémiologiste, Inserm U1295, Toulouse) : Sous-groupe de travail « Prévention de l'infection VIH » sous la direction du Dr Bruno Spire (médecin, chercheur en santé publique, SeSSTIM, Inserm U1252, Marseille & association AIDES) : Dr Arnaud Blanc, médecin généraliste, Morangis, AP-HP Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; Dr Karen Champenois, épidémiologiste, IAME Inserm UMR1137, Paris ; Dr Lise Cuzin, médecin de santé publique, CHU de la Martinique ; Mr Hugues Fischer, représentant associatif, Act-Up Paris, TRT-5 CHV ; Dr Mojgan Hessamfar, médecin de santé publique, COREVIH Nouvelle Aquitaine, CHU de Bordeaux, Bordeaux ; Mme Diane Leriche, représentante associatif, coordinatrice, TRT-5 CHV ; Dr Romain Palich, infectiologue, AP-HP Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris. Sous-groupe de travail « Dépistage de l'infection VIH » sous la direction du Dr Karen Champenois (épidémiologiste, IAME Inserm UMR1137, Paris) : Dr Arnaud Blanc, médecin généraliste, Morangis, AP-HP Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; Dr Marie-Laure Chaix, virologue, CNR du VIH, AP-HP Hôpital Saint-Louis, Paris ; Dr Lise Cuzin, médecin de santé publique, CHU de la Martinique ; Dr Cyrille Delpierre, épidémiologiste, Inserm U1295, Toulouse ; Dr Annabel Desgrees Du Lou, démographe, de la santé, CEPED, IRD, Paris ; Mr Hugues Fischer, représentant associatif, Act-Up Paris, TRT-5 CHV ; Dr Sophie Grabar, médecin de santé publique, IPLESP Inserm UMR1136 et AP-HP Hôpital Saint-Antoine, Paris ; Dr Mojgan Hessamfar, médecin de santé publique, COREVIH Nouvelle Aquitaine, CHU de Bordeaux, Bordeaux ; Mme Diane Leriche, représentante associatif, coordinatrice, TRT-5 CHV ; Dr Florence Lot, médecin de santé publique, direction des maladies infectieuses, Santé publique France; Dr Romain Palich, infectiologue, AP-HP Hôpital

	Pitié-Salpêtrière, Paris ; Dr Bruno Spire, médecin, chercheur en santé publique, SeSSTIM, Inserm U1252, Marseille & association AIDES. Avec la participation du Dr Delphine Rahib, épidémiologiste, Santé publique France (groupe de travail « Epidémiologie des IST »)
Conflits d'intérêts	Les membres du groupe de travail ont communiqué leurs déclarations publiques d'intérêts à la DGS. Elles sont consultables sur le site https://dpi.sante.gouv.fr. Elles ont été analysées par la direction des affaires juridiques du Ministère de la Santé et de la Prévention. Par ailleurs, la base de données publique « Transparence-Santé » (www.transparence.sante.gouv.fr) rend accessible les informations déclarées par les entreprises concernant les conventions, les rémunérations et les avantages liant ces entreprises et les acteurs du secteur de la santé. Les intérêts déclarés par les membres du groupe de travail et les informations déclarées par les entreprises ont été considérés comme étant compatibles avec la participation des membres du groupe de travail à ce travail.
Validation	Version du [30/10/2024]
Actualisation	
Autres formats	

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.cns.sante.fr et www.anrs.fr

Conseil national du sida et des hépatites virales
39-43 quai André Citroën
75902 Paris cedex 15

Conseil national du sida et des hépatites virales
39-43 quai André Citroën
75902 Paris cedex 15

Sommaire

1. Prévention de l'infection VIH 7

1.1. Préambule 7

1.2. Dépistage 9

1.3. Préservatifs 9

1.4. Circoncision masculine médicalisée 10

1.5. Prévention biomédicale 10

1.5.1. Traitement antirétroviral comme outil de prévention (TasP) 10

1.5.1.1. Efficacité du traitement antirétroviral comme outil de prévention 10

1.5.1.2. Communiquer sur l'efficacité du traitement antirétroviral comme outil de prévention du VIH hautement efficace 11

1.5.1.3. L'impact du traitement antirétroviral sur l'épidémie 11

1.5.2. Prophylaxie pré-exposition (PrEP) 12

1.5.2.1. Place de la PrEP dans la prévention diversifiée 12

1.5.2.2. Accès à la PrEP 13

1.5.3. Traitement post-exposition (TPE) 16

1.6. Utilisation de drogues en contexte sexuel 17

1.7. Vers des politiques de prévention plus volontaristes 19

2. Dépistage de l'infection VIH 21

2.1. Préambule 21

2.2. Introduction 22

2.3. Diagnostic de l'infection VIH 23

2.3.1. Les outils de dépistage du VIH 23

2.3.2. Algorithme de diagnostic de l'infection VIH 24

2.4. Offres de dépistage 28

2.4.1. Le dépistage du VIH dans le système de soin 29

2.4.1.1. Activité de dépistage du VIH en ville et à l'hôpital 29

2.4.1.2. Dépistage du VIH sur prescription par les médecins libéraux 29

2.4.1.3. Dépistage du VIH en consultation prénatale 32

2.4.1.4. Dépistage du VIH aux urgences 33

2.4.1.5. Dépistage du VIH dans les lieux de privation de liberté 34

2.4.1.6. Dépistage en CeGIDD 35

2.4.1.7. Dépistage du VIH dans les laboratoires de biologie médicale (VihTest) 37

2.4.1.8. Dépistage en pharmacie d'officine 39

2.4.1.9. Les structures de prévention ou spécialisées 40

2.4.2. Le dépistage hors système de soin 40

2.4.2.1. Le dépistage du VIH par les associations 40

2.4.2.2. L'autotest VIH 42
2.4.2.3. Dépistage par auto-prélèvements à domicile sans résultat immédiat 44
2.4.3. La notification aux partenaires 46
2.4.4. Promotion du dépistage 48
2.5. Conditions de réalisation du dépistage et accompagnement 49
2.5.1. Information pré-test et consentement 50
2.5.2. Information post-test et accès aux soins des personnes recevant un résultat positif 52
2.5.3. Information post-test et accès à la prévention des personnes recevant un résultat négatif 52
2.5.4. Accompagnement, médiation en santé 53
2.6. Approche populationnelle 54
2.6.1. Population générale 54
2.6.2. Les mineurs 56
2.6.3. HSH 57
2.6.4. Les personnes prenant la PrEP 58
2.6.5. Les personnes pratiquant le chemsex 58
2.6.6. Les personnes usagères de drogues injectables (UDI, hors chemsex) 59
2.6.7. Les personnes migrantes ou en situation de précarité 60
2.6.8. Les personnes transgenres 61
2.6.9. Les travailleurs et travailleuses du sexe 62
2.6.10. Les personnes détenues 64
2.6.11. Les personnes victimes de violences sexuelles 64
2.6.12. Les personnes en situation de handicap 65
Références bibliographiques 67
Participants 79
Table des figures 82
Abréviations et acronymes 83
Annexe 85

1. Prévention de l'infection VIH

1.1. Préambule

La dynamique de l'épidémie a changé en France et ses enjeux également. Le chapitre « Epidémiologie et déterminants sociaux de l'infection VIH en France » de ce rapport présente en détail les indicateurs épidémiologiques et leurs tendances. Sans reprendre toutes ces données, la situation peut se résumer comme suit :

Le chiffre des nouveaux diagnostics reste stable d'une année à l'autre depuis plusieurs années (environ 6 000 diagnostics par an jusqu'en 2019, environ 5 000 en 2020 et 2021 dans le contexte de la pandémie de Covid-19, et 5 500 en 2023). L'épidémie, qualifiée de concentrée, ne régresse plus ou faiblement.

On ne décrit plus une épidémie française mais des épidémies de niveau et d'évolution différents entre les territoires : l'Ile-de-France, les Territoires Français d'Amérique (TFA), et récemment Mayotte sont clairement plus affectées que les autres régions.

Les groupes de population les plus touchés sont plus que jamais les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH), notamment ceux nés à l'étranger et les populations des deux sexes originaires d'Afrique subsaharienne et des TFA. Les comportements et pratiques à risque persistent et se retrouvent à des niveaux variables dans toutes les tranches d'âge.

Le dépistage a augmenté jusqu'en 2019 avec peu d'impact visible sur le nombre de diagnostics. Il a fortement diminué en 2020 en lien avec les mesures de freination de l'épidémie de Covid-19, et ce d'autant plus dans les populations nées à l'étranger. Il est remonté en 2023, le nombre de dépistages réalisés en 2023 dépassant fortement celui de 2019. Le nombre de nouveau diagnostics remonte également, principalement chez les personnes nées à l'étranger.

Les diagnostics à un stade avancé (CD4 < 200/µL ou stade SIDA) ou à un stade tardif (CD4 < 350/µL) restent trop nombreux (environ 30% de diagnostics avec CD4 < 200/µL ou stade SIDA, et 40% avec CD4 < 350/µL, stables au cours des 10 dernières années). Le nombre de personnes non diagnostiquées ne baisse pas suffisamment et a donc un effet d'entraînement sur la dynamique de l'épidémie. Pourtant, l'offre de dépistage s'est diversifiée tant en termes d'outils que de structures.

L'utilisation de la combinaison tenofovir disoproxil fumarate (TDF) / emtricitabine (FTC) pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP), initiée depuis janvier 2016, reste efficace dans la durée comme le montrent les résultats de l'étude PREVENIR [1] mais n'a pas encore formellement démontré un effet populationnel préventif. Cependant, l'introduction de la PrEP a été associée à une baisse de l'incidence du VIH parmi les HSH à Sydney [2] et à Londres [3].

De plus, les données des enquêtes "Rapport au Sexe" montrent qu'environ un quart des répondants rapportent des rapports anaux non protégés, quel que soit l'outil de prévention utilisé [4,5].

Le socle de la prévention du VIH repose aujourd'hui sur un choix d'outils démontrés comme efficaces au sein d'une palette tendant à s'élargir et à se diversifier. L'enjeu principal est de permettre aux personnes exposées au risque d'acquérir le VIH d'adopter au moins un outil efficace, d'où le terme de « prévention diversifiée ». A l'échelle individuelle, les outils et les stratégies de prévention ne sont pas toujours combinés mais leur diversification à l'échelle populationnelle est nécessaire pour impacter la dynamique des infections. Cette prévention associe des mesures structurelles à des interventions biomédicales et comportementales, sachant qu'aucune d'entre elles prise isolément ne peut aboutir à l'effet escompté : faire régresser l'épidémie de façon durable [6].

L'accès à la diversification des outils de prévention semble encore plus difficile pour les personnes migrantes et notamment primo arrivantes. Les résultats de l'enquête PARCOURS montrent d'une part qu'entre 30 et 49% des personnes contractent le VIH après l'arrivée en France [7] et d'autre part souligne l'importance de la période d'instabilité administrative comme moment critique où les personnes sans accès aux droits sont les plus vulnérables et exposées à des relations sexuelles forcées [8]. L'enquête montre également que seuls 55% des femmes et 63% des hommes ont accès aux soins dans l'année d'arrivée en France et que 14% des femmes demeurent sans couverture santé 3 ans après l'arrivée [9]. L'étude Makasi, menée auprès d'hommes et de femmes nées en Afrique Subsaharienne et résidant en Ile de France, recrutés lors d'actions de l'association Afrique Avenir dans les lieux publics, montre une connaissance très faible des outils de prévention biomédicaux (5% pour la PrEP, 6% pour le traitement post-exposition (TPE)) alors que 46% connaissent le caractère protecteur du traitement antirétroviral (ARV) sur la transmission (Treatment as Prevention ou TasP), 84% savent que le traitement ARV est efficace et 70% connaissent les services de santé sexuelle [10].

Aujourd'hui la prévention diversifiée repose sur différents outils : le préservatif, la circoncision masculine médicalisée, le traitement des personnes séropositives comme prévention des transmissions (TasP), la PrEP et le TPE. La pierre angulaire de toute prévention biomédicale reste le dépistage et la connaissance du statut vis-à-vis du VIH. Ce chapitre aborde l'ensemble des outils de prévention diversifiée. Concernant les outils de prévention biomédicale, il aborde les questions d'accès aux outils, les modalités de suivi étant abordées dans un chapitre spécifique du rapport (cf chapitres « Initiation d'un premier traitement ARV chez l'adulte vivant avec le VIH », « Suivi de l'adulte vivant avec le VIH », « Traitement préventif pré-exposition au VIH » et « Traitement préventif post-exposition au VIH »). Après avoir rappelé la nécessité d'une politique globale de réduction des risques pour les usagers de drogues, la question de l'usage des drogues en contexte sexuel (chemsex) terminera cette synthèse.

Méthodologie de travail

Le sous-groupe de travail « Prévention de l'infection VIH » a choisi de travailler à partir des écrits de la version précédente des recommandations françaises en actualisant la bibliographie à partir de travaux publiés depuis 2017 concernant la prévention du VIH en France ou dans d'autres pays industrialisés ayant un contexte relativement similaire. Les publications pouvaient être soit tirées d'articles originaux, soit de communications récentes dans des congrès internationaux ou publiées dans des rapports institutionnels de santé publique en France.

Le sous-groupe de travail « Prévention de l'infection VIH » a travaillé par échange d'e-mails en actualisant le texte du rapport précédent et s'est réuni 6 fois en visioconférence pour s'accorder sur les différentes questions posées par chacun des membres. Les recommandations ont été présentées, discutées, et validées en réunion plénière du groupe de synthèse des recommandations VIH.

Le texte a ensuite fait l'objet d'une relecture par un groupe n'ayant pas participé à la rédaction, dont la composition est détaillée en fin de chapitre.

Le chapitre actualise les connaissances sur les différents outils de prévention et se termine par des recommandations.

1.2. Dépistage

Le dépistage est un élément phare des stratégies de prévention. D'une part, la connaissance du statut permet à la personne dépistée d'accéder aux soins spécialisés (bénéfice individuel et populationnel sur la transmission) en cas de test positif, ou à une prévention adaptée et à de l'information adaptée (counseling) en cas de test négatif. D'autre part, le dépistage répété peut également être utilisé comme stratégie de réduction des risques.

Le dépistage est traité dans la 2e partie de ce chapitre.

1.3. Préservatifs

Le préservatif "externe" a eu un rôle majeur dans la lutte contre l'épidémie de VIH ; il reste aujourd'hui un outil indispensable dans le contexte de la prévention diversifiée en particulier parce qu'il est le seul à réduire aussi le risque d'acquisition des autres infections sexuellement transmissibles (IST). Il est donc nécessaire d'en poursuivre la promotion, d'en faciliter l'offre et d'en permettre l'apprentissage dès l'entrée dans la sexualité. En Angleterre, Phillips et al. ont estimé, par une modélisation, que si l'usage du préservatif s'était arrêté en 2000, l'incidence de l'infection à VIH aurait été multipliée par 5 (+ 424%) entre 2001 et 2006 par rapport à ce qui a été observé [11].

L'efficacité théorique du préservatif externe est élevée (98%) mais son efficacité réelle est variable selon les IST et les pratiques sexuelles. Dans les rapports hétérosexuels, la réduction du risque d'infection par le VIH par un usage systématique du préservatif est estimée à 80% [12]. Elle est de 64% dans la population des homosexuels masculins [13]. Ces niveaux d'efficacité plus faibles s'expliquent par un probable défaut d'observance réelle et par la persistance d'une certaine proportion d'incidents par rupture ou par glissement. Ceci plaide pour poursuivre l'information des usagers à une bonne utilisation avec une attention particulière à la pose et la lubrification. Comme contraceptif, le préservatif a une efficacité moindre que les méthodes basées sur un traitement hormonal ou les dispositifs intra-utérins. Le préservatif n'est pas systématiquement utilisé au-delà des premiers rapports au cours d'une relation pour des raisons de confort sexuel, du fait qu'il est sous le contrôle de l'un des partenaires (de l'homme dans les relations hétérosexuelles) ou de son image trop souvent associée à des relations multiples ou occasionnelles.

La promotion du préservatif externe est particulièrement nécessaire dans la population HSH fortement exposée au VIH et aux autres IST, en particulier pour ceux qui n'ont pas pu ou voulu entrer dans un programme de PrEP. A un moment où l'information sur le VIH est moins présente dans l'espace public, il est nécessaire de s'assurer auprès de tous les publics de leur connaissance du préservatif ainsi que de leur capacité à l'utiliser.

Depuis décembre 2018, les préservatifs externes peuvent être remboursés, et depuis janvier 2023, ils sont disponibles gratuitement pour les jeunes de moins de 25 ans. Prescrits par les médecins et les sages-femmes, plus de 9 millions de préservatifs ont été ainsi remboursés par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), bénéficiant à plus de 541 000 personnes (source CNAM).

Disponible sur le marché européen depuis 1991, le préservatif interne (anciennement dénommé préservatif féminin) reste peu utilisé. L'offre, le prix et sa distribution ne sont pas favorables à sa diffusion. Il est encore peu disponible et peu visible dans les pharmacies et les commerces. Le préservatif interne est surtout distribué gratuitement par les Agences Régionales de Santé (ARS), via les associations, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par le VIH, les hépatites virales et des IST et les centres de santé sexuelle (ex-plannings

familiaux). Cette distribution tend à baisser ces dernières années ; moins de 500 000 préservatifs internes ont été diffusés en 2017 et il ne semble pas exister de données plus récentes.

1.4. Circoncision masculine médicalisée

La circoncision masculine volontaire et médicalisée des adultes a fait la preuve de son efficacité dans le cadre d'une stratégie de prévention diversifiée dans les pays à forte épidémie généralisée d'Afrique australe et de l'Est dans les populations où elle n'était pas pratiquée pour des raisons religieuses ou culturelles [14]. Une méta-analyse a estimé à partir de trois essais randomisés une efficacité de 56% de réduction de l'acquisition du VIH chez les hommes hétérosexuels dans des contextes d'épidémie généralisée [15]. Chez les HSH, l'effet de la circoncision est moindre et non retrouvé dans les études menées dans les pays industrialisés [16]. L'OMS a recommandé la pratique de la circoncision volontaire chez les jeunes adultes dans les pays d'épidémie généralisée [17]. Dans les pays comme la France à épidémie concentrée, cette mesure préventive n'a pas sa place dans les stratégies de santé publique.

1.5. Prévention biomédicale

1.5.1. Traitement antirétroviral comme outil de prévention (TasP)

1.5.1.1. Efficacité du traitement antirétroviral comme outil de prévention

L'objectif principal du traitement ARV est de contrôler l'infection chez la personne vivant avec le VIH (PVVIH), ce qui se traduit par une indétectabilité de l'ARN VIH plasmatique (charge virale). Une charge virale indétectable permet de prévenir la transmission du virus à autrui. Cette stratégie de prévention de la transmission concerne directement les PVVIH et leurs partenaires sexuels. On parle alors du traitement comme outil de prévention, de l'anglais « Treatment as Prevention » ou TasP. Pour le grand public, cette stratégie est déclinée par les campagnes U=U (Undetectable = Untransmittable) parfois traduites par I=I (Indétectable = Intransmissible).

Les données en faveur de la réduction massive du risque de transmission du VIH au partenaire séronégatif sont bien établies, que ce soit par des études observationnelles [18–24] ou interventionnelles [25–27], lors de relations hétérosexuelles et également entre hommes : les études Partners 1 et 2 [23] et Opposites Attract [28,29] menées chez des couples séro-différents. Aucune transmission n'est survenue, et ce malgré une forte incidence des IST et de possibles blips non observés dans les populations d'étude.

Lorsque le partenaire séropositif initie un traitement ARV, quatre périodes de niveau de risque décroissant de transmission du VIH aux partenaires peuvent être identifiées : (i) les 6 mois suivant l'initiation du traitement et avant que la charge virale plasmatique ne soit devenue indétectable ; (ii) au-delà de 6 mois après l'initiation du traitement tant que la charge virale plasmatique n'est pas devenue indétectable ; (iii) après un éventuel échec du traitement ; (iv) en cas d'arrêt de traitement, quelle qu'en soit la raison [18–22,24–27]. L'indétectabilité virale étant le plus souvent obtenue en quelques semaines grâce aux traitements ARV très efficaces (notamment les inhibiteurs de l'intégrase), 0,3 ans en médiane sur la période 2014-2018 [30], des recherches sont nécessaires pour valider une diminution de la période de 6 mois de traitement pour garantir une non-transmissibilité au ou à la partenaire.

Un délai de 6 mois de traitement ARV et l'obtention d'une charge virale plasmatique indétectable restent donc actuellement considérés pour définir la période initiale à risque de transmission du VIH, au cours de laquelle des mesures de prévention de la transmission du VIH sont recommandées lors des rapports sexuels (utilisation du préservatif ou de la PrEP, ou TPE à défaut).

1.5.1.2. Communiquer sur l'efficacité du traitement antirétroviral comme outil de prévention du VIH hautement efficace

Les données montrent bien que lorsque le partenaire séropositif est sous traitement ARV depuis plus de 6 mois et a une charge virale indétectable, le risque de transmission du VIH sous traitement est proche de zéro (cf. ci-dessus). Le message d'information auprès du public doit être simplifié et clarifié : un risque de transmission devenu nul doit être largement diffusé auprès des PVVIH mais également du grand public et de tous les professionnels de santé. Les cliniciens ont un rôle clé pour la diffusion de cette information auprès des patients et de leurs partenaires. Une meilleure connaissance du concept U=U a été démontrée comme associée à des attitudes plus positives notamment en réduisant la stigmatisation et en favorisant le dépistage [31]. La communication autour de ces données est en effet devenue essentielle pour contribuer de manière importante à la qualité de vie des PVVIH (qualité de vie sexuelle, observance au traitement, discussion autour du VIH, peur de transmettre le VIH) mais aussi pour faciliter la procréation (cf. chapitre « Grossesse et VIH : désir d'enfant, soins de la femme enceinte et prévention de la transmission mère-enfant »).

1.5.1.3. L'impact du traitement antirétroviral sur l'épidémie

Une étude utilisant des modèles mathématiques a montré que l'utilisation à large échelle et précoce du traitement ARV pourrait permettre le contrôle de l'épidémie, à condition que les PVVIH aient accès au traitement dans l'année qui suit leur contamination [11]. En France sur la période 2014-2018, le délai médian entre infection par le VIH et diagnostic du VIH était de 3,3 ans. Ce délai médian a diminué à moins de 2 ans en 2023 (données Santé publique France, cf. chapitre « Epidémiologie et déterminants sociaux de l'infection VIH en France »). Une fois le dépistage réalisé, le délai médian entre diagnostic et entrée dans le soin est inférieur à un mois (médiane de 7 jours, IQR [0-20] en 2022 dans la cohorte ANRS CO4 FHDH) et le délai médian entre entrée dans le soin et mise sous traitement ARV est de 20 jours [32,33]. C'est donc le délai entre infection et diagnostic du VIH qui retarde l'initiation du traitement ARV et limite la possibilité de réduire en France le nombre de nouvelles infections. Des résultats de modélisation sur les données de la cohorte Dat'Aids en France ont montré que l'atteinte des 2 "90" de la cascade portant sur les mises sous traitement et le succès virologique a été associée à une réduction plus importante des infections récentes ou de primo-infections au cours de la période 2007-2017 suggérant un impact populationnel du TasP [34]. Par ailleurs, une étude de modélisation dans un autre pays du Nord, le Royaume-Uni, montre que le contrôle de l'épidémie de VIH chez les HSH par le TasP seul nécessiterait que 90% des HSH vivant avec le VIH découvrent leur statut dans l'année qui suit la contamination à cause du risque lié aux relations sexuelles avec des partenaires vivants avec le VIH non diagnostiqués [11]. Ces résultats montrent l'importance de la combinaison des différents moyens de prévention pour tendre vers le contrôle de l'épidémie, notamment au sein des populations fortement exposées.

Diffuser largement le message U=U ou I=I

1. Il est nécessaire de mieux communiquer sur l'efficacité du traitement ARV comme outil de prévention du VIH hautement efficace, quelle que soit la voie de transmission, auprès du personnel soignant et du grand public. Cela pourrait contribuer à lutter contre la sérophobie et à favoriser l'accès au dépistage. (C)
2. Des recherches devraient être menées pour étudier la non-transmissibilité du VIH des PVVIH virologiquement contrôlées aux partenaires dans une période plus courte que celle des 6 mois de traitement ARV initial (période recommandée aujourd'hui) pour favoriser la qualité de vie des personnes récemment diagnostiquées. (AE)

1.5.2. Prophylaxie pré-exposition (PrEP)

1.5.2.1. Place de la PrEP dans la prévention diversifiée

La PrEP consiste en l'utilisation de médicaments ARV en prévention de l'acquisition du VIH chez les personnes séronégatives. Démontrée comme hautement efficace dans les essais cliniques [35–39], la PrEP par voie orale est devenue un pilier de l'arsenal préventif en complémentarité des autres outils et stratégies existantes. Au niveau collectif, la PrEP a été associée à une baisse de l'incidence des nouveaux diagnostics à Sydney [2].

En France, après le succès de l'essai ANRS IPERGAY [37,39], les autorités sanitaires ont rapidement décidé de rendre la PrEP disponible et totalement prise en charge, basée sur la combinaison TDF/FTC à compter de janvier 2016. Les premières données de suivi post-essai pendant 18 mois de la cohorte IPERGAY confirment l'excellente efficacité de la PrEP chez les HSH, estimée à 97%, quelle que soit la manière de la prendre (environ 50% des participants étant en schéma "à la demande" et 50% en schéma continu) [39]. Ces données d'excellente efficacité et de très bonne tolérance ont été confirmées dans la cohorte ANRS PREVENIR, recrutant principalement des HSH en Ile-de-France [1]. Des analyses issues du Système National des Données de Santé (SNDS) tenant compte des données d'interruption suggèrent une efficacité en vie réelle autour de 60%, l'efficacité étant plus basse chez les plus jeunes et les personnes de bas niveau socio-économique [40].

Les médecins généralistes ont été impliqués dans le suivi et le renouvellement de la PrEP en médecine de ville et peuvent initier ce traitement préventif depuis le 1er juin 2021. Cependant, une enquête menée dans les Hauts-de-France entre février et mai 2020 montre que seul un tiers des médecins généralistes connaissait le principe de la PrEP [41]. L'étude sur les opportunités manquées de PrEP menée auprès de 188 PVVIH nouvellement diagnostiquées en France entre 2019 et 2020 indique que 91% d'entre elles étaient éligibles à la PrEP, 90% d'entre elles avaient vu un médecin généraliste mais très peu avaient été informés de la PrEP par leur médecin [42]. Même si ces études ont été menées plus d'un an avant la possibilité pour les médecins généralistes d'initier la PrEP, elles suggèrent un besoin important d'information des médecins et d'outils d'aide à la prescription.

Les bases de données du SNDS permettent de décrire les conditions d'utilisation de la PrEP [43] : de janvier 2016 au 30 juin 2022, l'augmentation des nouvelles prescriptions de PrEP est régulière mais modérée et les caractéristiques des personnes exposées et initiant une PrEP ont peu changé depuis les premiers mois de l'AMM. Cependant, les données du SNDS montrent que pendant le premier confinement de mars à mai 2020 dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, une baisse de 36% des délivrances et de 47% des instaurations de PrEP a été observée en France et cela malgré les réponses

rapides apportées par la HAS après saisine des associations, comme la possibilité de réalisation de suivis de PrEP en téléconsultation, une interprétation souple des critères de mise sous PrEP, etc [44,45]. De plus, l'étude ERAS de Santé publique France montre que deux mois après la fin du premier confinement de mars à mai 2020, 15% des usagers de PrEP ne l'avaient pas reprise [46]. Cependant, 64 821 personnes ont initié la PrEP depuis janvier 2016 et 42 583 dans les 6 derniers mois de cette période. Près de 3 800 primo-prescriptions, soit 41% de l'ensemble des initiations de PrEP ont été effectuées par des prescripteurs libéraux (dont 88% par des médecins généralistes). En comparaison, ce chiffre s'élevait à 1 389 (19% des initiations) au premier semestre 2021.

La PrEP a principalement été adoptée par les HSH : cependant, les résultats de l'étude ANRS PARCOURS montrent qu'entre 30% et 49% des personnes migrantes vivant avec le VIH en Ile-de-France acquièrent le VIH après leur arrivée en France [7] en particulier durant la période d'instabilité administrative [8]. Les personnes migrantes et en particulier primo-arrivantes forment une population particulièrement exposée qui devrait bénéficier davantage de la PrEP. Pourtant, seulement 5% d'entre elles ont déjà entendu parler de la PrEP (étude ANRS Makasi [10]). Différents experts internationaux préconisent que la PrEP soit prescrite, délivrée et suivie selon des modalités différenciées selon les populations clés en intégrant les spécificités respectives des besoins en santé sexuelle [47]. En France, les approches "d'aller vers" semblent particulièrement intéressantes pour mieux cibler la prévention vers les personnes migrantes les plus exposées [48].

1.5.2.2. Accès à la PrEP

La PrEP est devenue aujourd'hui un outil validé sur son efficacité tant au niveau individuel que collectif. Elle est indiquée pour toutes les personnes potentiellement exposées au VIH, ainsi que les personnes qui en font la demande. Les enjeux de santé publique sont aujourd'hui l'information, la promotion, la diffusion, et l'orientation vers des dispositifs de délivrance variés et adaptés aux différents publics dont certains sont à expérimenter. En France, en 2022, l'accès à la PrEP est possible dans les services spécialisés dans le VIH, les CeGIDD et la médecine de ville y compris les médecins au sein d'associations accompagnant les populations les plus concernées. Les détails de l'initiation et du suivi sont indiqués dans le chapitre « Prophylaxie pré-exposition de l'infection VIH ».

Le contrôle potentiel de l'épidémie est associé à la taille de la population exposée bénéficiant de la PrEP tout en renforçant la stratégie de traitement précoce pour les personnes dépistées positives [49]. Les actions de promotion de la PrEP doivent donc être encouragées en menant des campagnes de communication institutionnelles ciblant les populations clés et le grand public, en présentant les dispositifs PrEP au cours des actions de dépistage, en renforçant les actions de prévention de proximité auprès des populations les plus exposées et en informant davantage les pharmaciens d'officine sur les dispositifs PrEP hospitaliers ou en ville, afin d'orienter les publics concernés, notamment en cas de dispensation de la contraception d'urgence, de prescription de préservatifs, et de mieux accompagner les utilisateurs de PrEP.

Par ailleurs, les points d'accès à la PrEP pourraient être renforcés, notamment en augmentant la capacité des CeGIDD à proposer des consultations PrEP, en facilitant la dispensation de la PrEP aux personnes migrantes primo-arrivantes dans les permanences d'accès aux soins de santé (PASS) et en développant des actions de formation en santé sexuelle des médecins généralistes à l'aide d'outils de formation régulièrement actualisés.

L'accès à une initiation de la PrEP en pharmacie a été expérimentée à Atlanta [50] mais se heurte en pratique aux conditions recommandées pour une prescription de PrEP, notamment la réalisation du bilan biologique préalable pour écarter une primo-infection VIH. L'utilisation de TROD pour le

diagnostic de l’infection VIH n’est en effet pas recommandée avant l’initiation de la PrEP du fait de son manque de sensibilité en cas d’infection récente.

Faciliter l'accès à la PrEP

En encourageant les actions de promotion de la PrEP

3. Des campagnes de communication institutionnelles sur la PrEP informant sur son existence, son efficacité, et ses modalités d'obtention doivent être déployées auprès de la population générale. Un ciblage spécifique et un renforcement de cette communication doivent être pensés pour les populations clés, en particulier les migrants d'Afrique subsaharienne et les personnes en situation de prostitution ou de précarité sociale. (AE)

4. Les dispositifs PrEP doivent être présentés parmi les différents outils de prévention au cours des actions de dépistage au sein des différentes offres avec une possibilité d'initiation rapide de la PrEP en cas de demande de l'usager. (AE)

5. Les actions de prévention de proximité qui incluent des entretiens en face à face doivent être renforcées auprès des populations les plus exposées et les plus éloignées des offres de soins. (AE)

6. Les professionnels de santé concernés (médecins et biologistes de ville, pharmaciens d'officine) doivent être davantage formés à la prévention, la santé sexuelle et informés de tous les dispositifs proposant la PrEP (CeGIDD, SMIT, CSSAC, centres de santé), afin (i) d'orienter les publics concernés, (ii) de mieux accompagner les utilisateurs de PrEP. (AE)

En augmentant les points d'accès et de suivi à la PrEP

7. Il est nécessaire d'augmenter la capacité des CeGIDD à proposer des consultations PrEP, y compris aux mineurs. (AE)

8. La mise en place de protocoles de coopération simplifiée de délégation de tâches pour le suivi de la PrEP en CeGIDD, en CSSAC et dans les services hospitaliers doit être facilitée. (AE)

9. Il est nécessaire de financer la dispensation de la PrEP aux personnes migrantes primo-arrivantes et aux personnes en situation de précarité dans les permanences d'accès aux soins de santé (PASS) et en CSSAC, en tenant compte du coût du traitement et des ressources humaines, notamment pour la visite médicale et la médiation en santé. (AE)

10. La prescription de la PrEP devrait être ouverte aux sages-femmes. (AE)

11. Des actions de formation en santé sexuelle (incluant la PrEP) doivent être développées auprès des médecins généralistes, à l'aide d'outils de formation régulièrement actualisés. (AE)

12. En cas de prescription d'un TPE chez une personne qui n'est pas encore sous PrEP, il est recommandé d'envisager une prescription de PrEP du VIH à l'issue du traitement de l'exposition. La PrEP peut être administrée dès la fin du TPE, avec un contrôle de l'ARN VIH plasmatique en cas de doute sur une primo-infection. (AE)

13. Tous les soignants en contact avec les personnes pratiquant le chemsex doivent leurs proposer la PrEP (CAARUD, centre de santé sexuelle, CeGIDD, …). (B)

En expérimentant d'autres modalités de prescription ou de délivrance de la PrEP

14. Il est proposé de mener des expérimentations de prescription et de suivi de PrEP adaptées aux besoins de santé sexuelle des différentes populations clés en particulier pour les usagers les plus éloignés du système hospitalier. (AE)

15. Il est nécessaire de renforcer les recherches pour adapter l'offre de PrEP aux besoins des populations clés, notamment les femmes migrantes et les travailleur-ses du sexe dont les conditions de vie impactent le rapport à la santé. (AE)

1.5.3. Traitement post-exposition (TPE)

Le TPE fait partie intégrante de la stratégie de prévention diversifiée promue par le groupe d'experts et reste un outil important de prévention au niveau individuel. Un chapitre lui est consacré dans ce rapport (Cf. chapitre « Traitement post-exposition au VIH »).

Lors de sa mise en place en 1998, le TPE était initié uniquement dans les services d'urgences ou dans les services de maladies infectieuses. La centralisation de l'initiation du TPE aux urgences pose un problème d'accès dans un contexte de saturation de ces services la nuit et le week-end [51,52]. De plus, le contexte des urgences est peu propice au counseling. Depuis juillet 2019, il est également possible d'initier le TPE dans les CeGIDD.

Un appel à témoignages lancé par le collectif TRT-5 CHV en juin 2021 confirme les résultats déjà publiés [53]. Les principaux freins à l'accès au TPE sont le délai de prise en charge malgré l'urgence de démarrer le traitement, une attitude jugeante de la part du personnel soignant, une maîtrise aléatoire des protocoles, des pratiques hétérogènes des professionnels et une méconnaissance du dispositif. On peut ajouter que la distance géographique du lieu de prise en charge est un frein à l'accès. Des facilitateurs d'accès y sont soulignés, notamment le fait d'être soutenu et accompagné par une association.

Les difficultés rapportées sont donc diverses et peuvent transformer l'accès au TPE en un réel «parcours du combattant». Ces difficultés touchent les femmes autant que les hommes, et les territoires dans lesquels l'offre de santé est riche comme dans ceux où elle est réduite.

La synthèse de la littérature et des remontées de terrain suggèrent de :

- Faire connaître le TPE par une communication plus large et adaptée aux différents publics, notamment les populations les plus exposées.
- Diversifier les lieux et modalités de délivrance des kits d'initiation d'un TPE : en médecine de ville, dans les pharmacies et les associations. Ce point fait l'objet de l'action n°15 de la feuille de route n°2 de la stratégie nationale de santé sexuelle [54,55].
- Mettre en place des protocoles simplifiés pour délivrer les kits d'initiation de TPE.
- S'appuyer sur l'accompagnement communautaire pour faciliter l'accès au TPE. En tant qu'acteur de première ligne, les associations devraient pouvoir jouer leur rôle de facilitation au-delà de l'accompagnement dans le parcours à l'hôpital.

Faciliter l'accès au TPE

En encourageant les actions de promotion du TPE

16. Il est nécessaire d'organiser des campagnes de communication généralistes et ciblées pour faire connaître le TPE. (AE)

17. Le rôle des associations communautaires pour promouvoir l'accès au TPE doit être renforcé. (AE)

En augmentant les points d'accès et de suivi du TPE

18. Les lieux et les modalités de délivrance du kit initial de TPE (3 à 5 jours) doivent être diversifiés : en médecine de ville, dans les pharmacies d'officine, par les sages-femmes, et les associations habilitées au dépistage. (AE)

19. La prescription et le suivi du TPE dans les services hospitaliers et les CeGIDD doivent être facilités, en mettant en place des protocoles de coopération simplifiés de délégation de tâches pour la prescription du TPE, l'organisation de l'accueil et la délivrance du traitement (AE).

20. Le rôle des associations communautaires doit être soutenu pour mieux accompagner les personnes prenant un TPE. (AE)

En améliorant la surveillance du recours au TPE

21. Il est proposé de mettre en place un système de surveillance minimal de dispensation du TPE permettant de comptabiliser et décrire les initiations de TPE et le suivi sérologique des usagers (collecte de données minimales, enquêtes flash un mois donné répétées, analyse du SNDS, …). (AE)

1.6. Utilisation de drogues en contexte sexuel

Le dispositif « Tendances récentes et nouvelles drogues » (TREND) de l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie (OFDT) confirme, dans son rapport 2015-2016, une extension et une diffusion de l'usage de produits psychoactifs dans un cadre sexuel (chemsex) depuis la fin des années 2000 et plus particulièrement depuis 2010 chez les HSH, bien qu'il soit difficile d'en mesurer l'ampleur [56]. Dans l'enquête PREVAGAY 2015 menée dans les lieux de convivialité gay de cinq villes françaises, 36,4% des HSH vivant avec le VIH et 18,2% des HSH séronégatifs déclaraient avoir consommé au moins un produit psychoactif avant ou pendant les rapports sexuels au cours des 12 mois précédant l'enquête [57]. L'enquête ERAS conduite en 2020 auprès de 7195 HSH montrait que 5% d'entre eux déclarent avoir pratiqué le chemsex au cours du dernier rapport sexuel [58]. L'enquête ERAS reconduite en 2021 montre que 12% des HSH déclarent avoir pratiqué le chemsex au cours des 6 derniers mois [59]. L'utilisation des nouveaux produits de synthèse (NPS), induisant un « craving » important (impulsion vécue sur un instant donné, véhiculant une envie de consommation d'un produit psychoactif et sa recherche compulsive) est particulièrement développée, les NPS étant consommés seuls ou

combinés avec d'autres drogues appartenant à la classe des stimulants (MDMA, cocaïne), des dépresseurs (GHB) ou des hallucinogènes. Leur accès a été rendu facile ces dernières années par des prix attractifs, un approvisionnement directement sur internet ou par des usagers-revendeurs rencontrés sur les applications géolocalisées de rencontre. Ces produits peuvent aussi être utilisés avec d'autres drogues comme les produits érectiles, les dérivés du cannabis, ou des produits psychédéliques.

Produits les plus utilisés pour le chemsex :

- Cathinones (3MMC, 3CMC, 4MEC, méphédrone, alpha-PvP ou alpha-PhP, MDPV) ;
- GHB/GBL ;
- MDMA, MDA ;
- Cocaïne, crack ;
- Crystal meth (méthamphétamine) ;
- Kétamine ;
- Amphétamines.

Les professionnels de santé observent un nombre significatif de conséquences psychosociales et somatiques caractérisées par une dépendance rapide aux produits et à leur usage dans un cadre sexuel, des complications physiques pouvant aller jusqu'à des atteintes veineuses et cardiovasculaires, l'overdose et au décès [60]. La prévalence du VIH, du VHC et de certaines IST est élevée chez ces HSH qui pratiquent le chemsex. L'enquête ERAS de 2020 montre que parmi les 7 195 HSH enquêtés, alors que 5% des personnes qui ne pratiquent pas le chemsex déclarent être séropositifs pour le VIH, 21% des personnes qui pratiquent le chemsex déclarent l'être [59]. Parmi les pratiques du chemsex, le « slam », terme utilisé par les usagers pour décrire l'injection intraveineuse de stimulants, fait l'objet de témoignages, ou de cas rapportés par les praticiens, de conséquences sanitaires aggravées [61]. Les données de l'essai ANRS IPERGAY, auprès de HSH séronégatifs éligibles pour la PrEP, montrent que 8% des participants déclarent avoir pratiqué le slam au moins une fois au cours du suivi. Cet essai a permis de mettre en évidence que les HSH pratiquant le chemsex avaient adopté la PrEP de manière efficace comme outil de prévention du VIH [62]. La cohorte ANRS PREVENIR qui inclut essentiellement des HSH sous PrEP indique un taux d'environ 15% de participants rapportant au moins un épisode de chemsex à chaque suivi trimestriel (données non publiées).

La Stratégie nationale de santé sexuelle (SNSS [55]) fixe l'objectif, dans sa mesure 58, de « travailler à réduire les risques et les dommages liés aux pratiques qui consistent à consommer des produits psychoactifs dans le cadre sexuel (chemsex) en ce qu'elles participent au maintien de la dynamique de l'épidémie de VIH et à l'augmentation des infections par le VHC dans la population HSH ». Les résultats de l'enquête PaacX, décrivant l'hétérogénéité des rapports au chemsex, montrent la nécessité d'une prise en charge holistique et individualisée spécifique [63].

Nous recommandons la mise en place rapide d'un groupe de travail pluridisciplinaire associant les professionnels de santé, les pouvoirs publics et les associations de réduction des risques afin de renforcer leur coordination sur le chemsex et promouvoir l'émergence d'une réponse adaptée aux besoins de santé des personnes le pratiquant.

Prévenir les risques liés à la pratique du chemsex

22. Il est proposé de mettre en place rapidement un groupe de travail pluridisciplinaire associant les professionnels de santé, les pouvoirs publics et les associations de réduction des risques afin de renforcer leur coordination sur le chemsex et promouvoir l'émergence d'une réponse adaptée aux besoins de santé des personnes pratiquant le chemsex. (AE)

23. Les actions de réduction des risques et de promotion de la santé auprès des personnes utilisant des drogues doivent être favorisées sans qu'il y soit fait obstacle par une politique répressive des usagers. (C)

24. Il est nécessaire de faire connaître aux personnes pratiquant le chemsex les moyens de réduction des risques utilisés avec succès auprès des usagers de drogues injectables, en plus de la PrEP. (AE)

1.7. Vers des politiques de prévention plus volontaristes

Aucune des approches préventives présentées dans ce chapitre n'est susceptible à elle seule de faire régresser l'épidémie de manière durable et significative en réduisant l'incidence des nouvelles infections. Mais leur combinaison est très synergique, et probablement suffisante si leur utilisation se fait à des niveaux élevés et en l'adaptant aux différents contextes géographiques, populationnels et épidémiologiques. Leur déploiement ne pourra probablement pas se faire en France avec la rapidité exigée sans moyens supplémentaires. Chaque méthode doit trouver sa place dans les choix individuels.

Si les politiques de santé associent les outils de dépistage et de prévention diversifiée, il est possible de démontrer un impact sur l'épidémie. Le déploiement d'une telle politique volontariste à San Francisco associant un accroissement du dépistage et du traitement universel, une offre de PrEP et la lutte contre la stigmatisation a permis d'atteindre une réduction significative des nouveaux diagnostics du VIH [64,65]. Des données plus parcellaires collectées à Londres indiquent un déclin des nouveaux diagnostics VIH entre 2015 et 2017 parmi les HSH alors même que la PrEP n'avait pas encore été introduite en tant que mesure de santé publique [66].

Les différentes initiatives associatives, dont les « villes sans sida » et les programmes de recherche qui leur sont associés sont des contextes privilégiés pour mesurer les changements escomptés en France. L'utilisation régulière et rapide des données de surveillance épidémiologique ainsi qu'une surveillance renforcée des comportements notamment dans les populations clés sont des paramètres essentiels à prendre en compte parmi les multiples indicateurs de suivi de la stratégie nationale de santé sexuelle.

Amplifier la prévention dans les zones prioritaires

25. Les moyens alloués à la prévention du VIH doivent être augmentés dans les zones où l'incidence reste forte, comme l'Ile-de-France (notamment le département de Seine-Saint-Denis), les Territoires Français d'Amérique, en particulier la Guyane, et Mayotte. (AE)

Faciliter l'accès aux soins des personne migrantes ou précaires

26. Il est recommandé de maintenir et faciliter l'accès aux soins des personnes migrantes ou précaires pour permettre un dépistage et une prise en charge précoce de l'infection VIH et éviter des ruptures de soins ultérieures. (C)

27. Il est nécessaire de favoriser l'accès aux droits (travail, logement, santé) qui est un prérequis pour que les personnes migrantes ou précaires évitent de se trouver en situation d'exposition au VIH. (C)

2. Dépistage de l'infection VIH

2.1. Préambule

La pierre angulaire de toute politique de prévention des maladies transmissibles reste le dépistage et la connaissance du statut. Nous avons actualisé l'algorithme de diagnostic du VIH pour faciliter une prise en charge rapide en lien avec le groupe de travail Virologie (Cf. chapitre « Diagnostic, suivi virologique de l'infection VIH et analyse de la résistance aux antirétroviraux »). Nous avons également réalisé un état des lieux de l'offre de dépistage du VIH en prenant en compte au maximum le dépistage conjoint du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (IST). Les recommandations ont été formulées par offre de dépistage et par population clé.

Alors qu'à Londres [67], Amsterdam [68] ou Sydney [69] le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a diminué de plus de 50% depuis 2012, en France, la diminution est moins marquée, de l'ordre de 10% sur la période 2012-2023 [70]). Le nombre de nouveaux diagnostics diminue notamment chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) nés en France (-36% sur la même période), mais augmente chez les HSH nés à l'étranger (+105%) avec une part importante d'entre eux (62%) qui contracte le VIH après la migration [71]. Les messages contradictoires autour de l'effet préventif du traitement ARV sur les transmissions (TasP) dans la première moitié des années 2010 en France et la recommandation tardive d'un dépistage répété du VIH dans les populations clés (2017 contre 2012 au Royaume-Uni) contribuent sans doute à ces différences épidémiologiques entre les pays. Une modélisation récente a montré l'effet des stratégies de prévention du VIH sur l'incidence du VIH chez les HSH au Royaume-Uni [6]. L'incidence du VIH a diminué de 77% entre 2014 et 2022. Sans la PrEP, l'incidence aurait été 2 fois plus élevée. Sans l'augmentation du dépistage et le traitement ARV précoce, l'incidence aurait été 2 fois plus élevée également. Toutefois, même dans ces conditions apparemment favorables, sans augmentation supplémentaire du dépistage et de la PrEP, le Royaume-Uni n'atteindra pas les objectifs d'élimination pour 2030. L'étude met également en avant la nécessité de diminuer le coût du dépistage et de la PrEP pour que l'expansion des actions reste coût-efficace.

En France, les efforts réalisés pour améliorer la couverture de dépistage en diversifiant les offres et pour augmenter la fréquence des dépistages des populations cibles permettront-ils de voir une diminution franche des nouveaux diagnostics dans les mois/années à venir ?

Le chapitre « Epidémiologie et déterminants sociaux de l'infection VIH en France » de ce rapport présente en détail les indicateurs épidémiologiques et leurs tendances. Sans reprendre toutes ces données, les points importants pour le dépistage du VIH sont :

- Le nombre de nouveaux diagnostics chez les HSH nés en France diminue (-36% entre 2012 et 2023). La proportion de nouveaux diagnostics chez les HSH nés à l'étranger et les personnes transgenres augmente depuis plusieurs années (+105% et +170% entre 2012 et 2023, respectivement).
- La crise sanitaire liée au COVID-19 a bouleversé l'ensemble de la surveillance, l'offre de dépistage et de prévention, les flux migratoires et par les mesures de distanciation physique, l'exposition au VIH, rendant plus difficile l'interprétation des tendances récentes.
- Plusieurs territoires sont plus affectés par l'épidémie de VIH notamment l'Ile-de-France et plusieurs régions d'outremer.
- Les groupes de population les plus touchés restent les HSH, et les femmes et les hommes originaires d'Afrique subsaharienne et des outremers. La précarité socio-économique (en particulier alimentaire et d'hébergement), les difficultés d'accès aux droits et aux soins,

l'homo/trans-phobie contribuent de façon importante au risque d'acquisition du VIH [72,73] (cf chapitre « Epidémiologie et déterminants sociaux de l'infection VIH en France ».
- Les diagnostics à un stade avancé (CD4 < 200/µL ou stade SIDA) ou à un stade tardif (CD4 < 350/µL) restent trop nombreux quelle que soit la population (28% et 43% en 2022, respectivement). A l'inverse, le nombre de HSH avec un diagnostic au stade d'infection récente ne diminue pas, suggérant une couverture encore insuffisante de la PrEP.

Méthodologie de travail

Le texte de référence pour le dépistage du VIH reste les recommandations de la HAS 2017 [32]. Pour l'actualisation de ce chapitre, nous avons recensé les avis des institutions françaises concernant le dépistage du VIH, notamment ceux du Conseil national du sida (CNS) et la seconde feuille de route de la stratégie nationale de santé sexuelle.

Le chapitre actualise les connaissances sur les différents outils et stratégies de dépistage. Un état des lieux des offres de dépistage du VIH a été réalisé au maximum à partir de données françaises issues des systèmes de surveillance ou d'études ad hoc conduites récemment.

L'élaboration des recommandations spécifiques au dépistage du VIH a été réalisée de façon collégiale par 13 experts pluridisciplinaires à partir de l'analyse critique des connaissances disponibles et de l'expérience des membres.

L'algorithme de diagnostic du VIH a été revu en concertation avec le groupe de travail Virologie.

L'avancée des travaux du groupe a été présentée à deux reprises pour discussion et amendements au groupe de synthèse transversal des recommandations VIH. Les recommandations par population clé ont été émises lors d'un groupe de travail élargi rassemblant les experts des IST bactériennes sur le sujet.

Le texte a ensuite fait l'objet d'une relecture par un groupe n'ayant pas participé à la rédaction, dont la composition est détaillée en fin de chapitre.

2.2. Introduction

Le dépistage du VIH fait l'objet en France d'une politique publique étayée par les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) dont la version de 2008-2009 a été réévaluée en 2017 [32,74,75]. En dehors des cas où la personne présente des symptômes évocateurs d'une primo-infection, d'une infection opportuniste ou d'une maladie évocatrice du VIH, cas où le professionnel de santé doit proposer un dépistage, la HAS recommande une proposition du dépistage du VIH large, s'appuyant sur l'ensemble des offres et basée sur deux piliers: (1) un dépistage ciblé des populations clés avec une fréquence de dépistage renforcée guidée par l'épidémiologie du VIH en France ; (2) une proposition généralisée de dépistage, au moins une fois dans la vie, à toute personne de 15 à 70 ans, hors notion d'exposition, précisant que cette proposition doit être intensifiée dans les régions dans lesquelles la prévalence du VIH non diagnostiqué est plus élevée (Ile-de-France, Outre-mer) ainsi que chez les hommes.

L'organisation actuelle du dépistage du VIH en France repose principalement sur le système de soins et notamment le médecin généraliste. Au cours des 15 dernières années, l'offre de dépistage du VIH s'est diversifiée : les structures associatives habilitées par les Agences Régionales de Santé (ARS) peuvent depuis novembre 2010 réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) [76] ; l'autotest VIH a été mis sur le marché en septembre 2015 ; les centres gratuits d'information, de

dépistage et de diagnostic (CeGIDD, succédant aux CDAG -centres de dépistage anonyme et gratuit- et aux CIDDIST -centres d'Information de dépistage et de diagnostic des IST-) ont été créés le 1er janvier 2016 [77] offrant la possibilité d'un dépistage du VIH anonyme et gratuit dans une offre globale de santé sexuelle ; plus récemment, l'ouverture de centres de santé sexuelle d'approche communautaire en lien avec les préconisations de la première feuille de route de la stratégie nationale de santé sexuelle [78,79] et le déploiement national de l'expérimentation "Au labo sans ordo" proposant un dépistage du VIH sans ordonnance et sans frais dans tous les laboratoires de biologie médicale de ville (VIHtest en janvier 2022 [80]).

Les feuilles de route 1 et 2, déclinaisons opérationnelles de la stratégie nationale de santé sexuelle, abordent globalement le dépistage du VIH et des IST afin d'en améliorer l'accès en facilitant les parcours et créant des opportunités de dépistage [54,55,81].

2.3. Diagnostic de l'infection VIH

> Ces textes figurent également dans le chapitre « Diagnostic, suivi virologique de l'infection VIH et analyse de la résistance aux antirétroviraux »

2.3.1. Les outils de dépistage du VIH

Trois modalités de dépistage de l'infection à VIH sont disponibles en France : les tests sérologiques ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay) et de confirmation qui sont réalisés en laboratoire, les TROD qui peuvent être réalisés par une tierce personne qui n'est pas nécessairement un professionnel de santé et les autotests de dépistage en vente en pharmacie et mis à disposition gratuitement dans des structures habilitées. Chacun de ces outils a des performances suffisantes pour une activité de dépistage et permet un accès large et individualisé au test du VIH. La sérologie est à privilégier en cas d'exposition au VIH récente. Une exposition potentielle récente doit conduire, dans tous les cas, à la réalisation immédiate d'un test, renouvelé 3 à 6 semaines plus tard selon l'ancienneté de l'exposition (6 semaines post-traitement, soit 10 semaines, si traitement post-exposition (TPE)).

ELISA combiné de 4e génération

Le test actuellement réalisé en laboratoire est un test ELISA de 4e génération. Il s'agit d'un test ELISA mixte détectant simultanément les anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2, et combiné, car il détecte également l'antigène p24 du VIH-1. Un résultat positif de l'analyse de dépistage nécessite la réalisation d'analyses de confirmation (Cf. algorithme de diagnostic du VIH). Un résultat négatif signe l'absence d'infection par le VIH, sauf dans le cas d'une exposition potentielle au VIH datant de moins de 6 semaines (6 semaines post-traitement, soit 10 semaines, si TPE).

Test de dépistage rapide à orientation diagnostique (TROD)

Le TROD est défini comme un test unitaire, à lecture visuelle subjective, de réalisation simple et conçu pour donner un résultat dans un délai court (moins de 30 minutes généralement). Ce test est pratiqué sur sang total, sérum, plasma conformément aux instructions du fabricant, au moyen d'un réactif détectant l'infection par les VIH-1 et VIH-2 avec un marquage CE. Les TROD combinant la recherche d'antigène et d'anticorps sont à utiliser de préférence car ils ont une meilleure sensibilité en cas d'infection récente que les TROD à anticorps seuls. En cas de TROD positif, la personne concernée est systématiquement orientée, voire accompagnée si nécessaire, vers un médecin, un CeGIDD ou

un service prenant en charge les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), afin de réaliser les analyses nécessaires (cf. algorithme de diagnostic du VIH). En raison d'une moindre sensibilité de ces tests, un résultat négatif ne peut être interprété en cas d'exposition potentielle au VIH datant de moins de 3 mois.

Des TROD combinant la recherche du VIH, de l'hépatite B ou C, ou de la syphilis sont commercialisés et détaillés dans les chapitres « Epidémiologie, Prévention, Dépistage des hépatites virales B, C et delta » et « Dépistage des IST ».

Autotests de dépistage de l'infection par le VIH (ADVIH)

Les ADVIH sont des tests rapides réalisés sur sang total ou sur liquide craviculaire (gingival) qui utilisent la même technologie que les TROD. Ils sont destinés à être utilisés dans un environnement domestique par des utilisateurs profanes. Le prélèvement et l'interprétation sont effectués directement par l'intéressé.

Le résultat positif d'un ADVIH doit être confirmé par un test ELISA de 4e génération, qui peut être réalisé lors d'une consultation en CeGIDD ou dans un service prenant en charge les PVVIH. Il peut également être prescrit par un médecin ou réalisé directement en laboratoire de biologie médicale (accès direct sans prescription dans le cadre du dispositif VIHTest). Un résultat négatif ne peut être interprété en cas d'exposition potentielle au VIH datant de moins de 3 mois.

2.3.2. Algorithme de diagnostic de l'infection VIH

Le diagnostic biologique de l'infection par le VIH-1 ou VIH-2 est régi par l'arrêté du 28 mai 2010 [82]. Il repose obligatoirement sur un test immunologique ELISA combiné mixte de 4e génération qui détecte :

- les anticorps anti-VIH-1 (des groupes M et O) et les anticorps anti-VIH-2 : anticorps anti-épitopes des glycoprotéines d'enveloppe ;
- l'antigène de capside du VIH-1 : Ag p24 (seuil > 2 UI/mL).

En cas de test ELISA positif, une analyse de confirmation par Western blot VIH-1 ou immunoblot est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin. Il est nécessaire à cette étape de différencier une infection à VIH-1 ou à VIH-2.

Si le résultat du Western blot / immunoblot est négatif ou indéterminé, afin de ne pas méconnaître une primo-infection, il est nécessaire de procéder à un test permettant de mettre en évidence les composants du virus (détection de l'ARN viral plasmatique ou détection de l'Ag p24 avec un seuil de détection au moins équivalent à celui du test ELISA combiné utilisé dans l'analyse de dépistage, confirmée par un test de neutralisation en cas de positivité). En pratique, la quantification de l'ARN VIH plasmatique est l'examen recommandé pour confirmer le diagnostic de primo-infection ou l'infirmer, dans le cadre d'une fausse positivité de l'ELISA.

La séropositivité VIH n'est confirmée qu'après confirmation du diagnostic biologique par un test ELISA de 4e génération sur un second prélèvement pour parer à toute erreur d'étiquetage ou autres sur le premier prélèvement (identitovigilance).

Il existe un bénéfice, tant au niveau individuel pour les PVVIH, qu'au niveau de l'épidémie, à raccourcir le délai entre le premier test positif, sa confirmation et l'instauration du traitement ARV [83,84]. Les recommandations françaises du groupe d'experts sont de débuter le traitement ARV dans les 2

semaines suivant le diagnostic, voire plus tôt à la demande du patient. Deux cas nécessitent de débuter le traitement sans délai : (1) la primo-infection, pour réduire les réservoirs viraux et limiter le risque de transmissions secondaires à une période où la charge virale est le plus souvent très élevée ; (2) un diagnostic au cours du 3e trimestre de la grossesse, pour réduire le risque de transmission à l'enfant au moment de l'accouchement (Cf. chapitre « Initiation d'un premier traitement antirétroviral chez l'adulte vivant avec le VIH »).

Afin d'optimiser le délai de prise en charge initiale, des leviers ont été identifiés au moment du diagnostic :

- Raccourcir le temps entre l'analyse de dépistage et l'analyse de confirmation. Pour cela, il est proposé que le biologiste réalise le Western blot / immunoblot sur le 1er prélèvement positif, d'en rendre le résultat dans un délai maximum de 7 jours, et de réaliser le 2e prélèvement sans délai.
- Réaliser une quantification de l'ARN VIH-1 sur le second prélèvement de confirmation afin que le médecin qui reçoit le patient pour la première fois en consultation spécialisée puisse disposer tout de suite d'un maximum d'éléments permettant d'envisager l'instauration du traitement ARV.
- Mieux intégrer le biologiste dans le processus de diagnostic du VIH, notamment lors de l'annonce au patient du résultat positif du 1er test ELISA et de l'invitation à réaliser le second prélèvement.

Rappelons qu'une information claire et sans équivoque doit être délivrée au cours d'une explication personnalisée en cas de :

- premier test positif, l'information doit détailler notamment le processus de diagnostic et la possibilité de faux positif ;
- faux positif.

28. Le dépistage de l'infection par le VIH-1 repose sur la sérologie qui peut être réalisée :

- Par test ELISA combiné de 4e génération, réalisé en laboratoire sur prélèvement sanguin. Il s'agit du test de référence qui détecte de façon simultanée les anticorps anti-VIH-1, anti-VIH-2 et l'antigène p24. (A)
- Par test rapide d'orientation diagnostique (TROD), ou par autotest, réalisé sur prélèvement sanguin capillaire, qui détecte de façon simultanée les anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2. Ces TROD sont moins sensibles que les tests ELISA combinés de 4e génération pour les infections récentes. (A)

29. Devant une suspicion de primo-infection, il est nécessaire de réaliser d'emblée une quantification de l'ARN VIH-1 plasmatique sur le premier prélèvement dès que possible. Dans ce cas, lorsque l'ARN VIH-1 est positif, il est recommandé au biologiste de prévenir le prescripteur du test et d'adresser très rapidement la personne à un centre spécialisé. (A)

Algorithme de diagnostic du VIH permettant de raccourcir le délai de prise en charge initiale

Cas général : sérologie par test ELISA combiné de 4e génération sur le sérum issu d'un premier prélèvement

30. Si l'ELISA combiné est négatif, il est possible de conclure à l'absence d'infection en l'absence d'exposition au VIH dans les 6 semaines précédentes (à 6 semaines post-traitement soit à 10 semaines de l'exposition dans le cadre d'un traitement post-exposition, TPE). (A)

31. Si l'ELISA combiné est négatif, que le patient a été exposé dans les 6 semaines précédant la sérologie et qu'il présente des symptômes pouvant évoquer une primo-infection, il est nécessaire de réaliser une quantification de l'ARN VIH-1 plasmatique dès que possible. Dans ce cas, si l'ARN VIH-1 est positif, il est recommandé au biologiste de prévenir le prescripteur du test et d'adresser très rapidement la personne à un centre spécialisé. (A)

32. Si l'ELISA combiné est négatif, que le patient a été exposé dans les 6 semaines précédant la sérologie (10 semaines si TPE) mais qu'il est asymptomatique, il est nécessaire de renouveler la sérologie à 6 semaines de la date d'exposition supposée. (A)

33. Si l'ELISA combiné est positif, il est nécessaire de réaliser un Western blot ou immunoblot VIH d'emblée sur le 1er prélèvement ; il est recommandé de rendre le résultat le plus tôt possible et au maximum dans un délai de 7 jours. Un test de différenciation VIH-1 / VIH-2 doit être pratiqué si l'information n'est pas apportée par le Western blot / immunoblot. (A)

34. Si l'ELISA combiné est positif, sans attendre le résultat du Western blot / immunoblot, il est recommandé de réaliser une analyse de confirmation sur un second prélèvement (pour éliminer une erreur d'identité) : une sérologie ELISA de 4e génération de contrôle, et une quantification de l'ARN VIH-1 plasmatique (2 tubes). (A) Ce second prélèvement devrait pouvoir être réalisé sans délai, dès la 1re sérologie positive, par le biologiste (si le dépistage était prescrit, le biologiste informe le médecin prescripteur). Le résultat du 1er test positif doit être expliqué au patient de façon personnalisée. (AE)

35. Si l'ELISA combiné est positif, le médecin prescripteur peut ajouter une mesure des CD4 à réaliser sur le prélèvement de contrôle afin d'anticiper le bilan complémentaire initial en cas de CD4 < 200/µL hors primo-infection (recherche d'infections opportunistes, mise en place de prophylaxies) et de guider le choix du traitement ARV initial et son délai d'initiation (cf chapitre « Initiation d'un premier traitement antirétroviral chez l'adulte vivant avec le VIH ». (AE)

36. Le patient sera adressé sans délai par le prescripteur (ou le biologiste en cas d'absence de prescription), à un centre spécialisé :

- Si l'index ELISA du 1er test est élevé (ce qui rend peu probable un faux positif) ; (AE)
- Dès que le Western blot / immunoblot est positif sur le 1er prélèvement, sans attendre le résultat de la sérologie et de la quantification de l'ARN VIH-1 sur le second prélèvement ; (AE)
- Sinon, lorsque l'ELISA et l'ARN VIH-1 sont positifs. (A)
- En cas de forte suspicion de primo-infection par le prescripteur / le biologiste. Il est de plus recommandé de prescrire d'emblée une quantification de l'ARN VIH-1 plasmatique dès le 1er prélèvement (prévoir un tube pour la sérologie et un tube pour la quantification d'ARN VIH-1). (A)

Dans tous les cas, afin de favoriser un recours rapide à un service spécialisé, il est recommandé que le prescripteur, avec l'accord du patient, contacte lui-même le service ou fasse appel au service de navigation proposé par le COREVIH / CoReSS ou Sida Info Service selon les territoires.

Cas particulier d'un ELISA positif et d'une recherche d'ARN VIH-1 négative

37. Les situations présentées ci-dessous justifient de conserver la réalisation d'une sérologie ELISA sur le second prélèvement en sus de la recherche d'ARN VIH-1. Il peut s'agir de :

- Un faux positif ELISA, et dans ce cas le Western blot / immunoblot et le test de différenciation sont négatifs. Un résultat de faux positif doit être expliqué de façon personnalisée au patient par le biologiste ou le médecin prescripteur. (A)
- Une infection par le VIH traitée par ARV non précisée au médecin / biologiste. Dans ce cas, le Western blot / immunoblot est positif ou incomplet. Un dosage des ARV les plus couramment utilisés peut-être réalisé sur le même prélèvement. (C)
- Selon le contexte (TPE, PrEP), une recherche d'ADN VIH peut aider à conclure sur le statut de l'infection. (AE)
- Une personne contrôlant naturellement l'infection (HIV controller). (A)
- Une infection par un virus VIH-1 de groupe non-M. (A)
- Une infection par le VIH-2 à confirmer par un Western-blot VIH-2 et une recherche d'ARN VIH-2. (A) La négativité de l'ARN VIH-2 n'infirme pas ce diagnostic compte-tenu de la fréquence élevée de charge virale spontanément indétectable en cas d'infection VIH-2.

Pour les cas difficiles à interpréter, le biologiste se rapprochera du CNR VIH, laboratoire associé de Rouen (CNR.VIH@chu-rouen.fr)

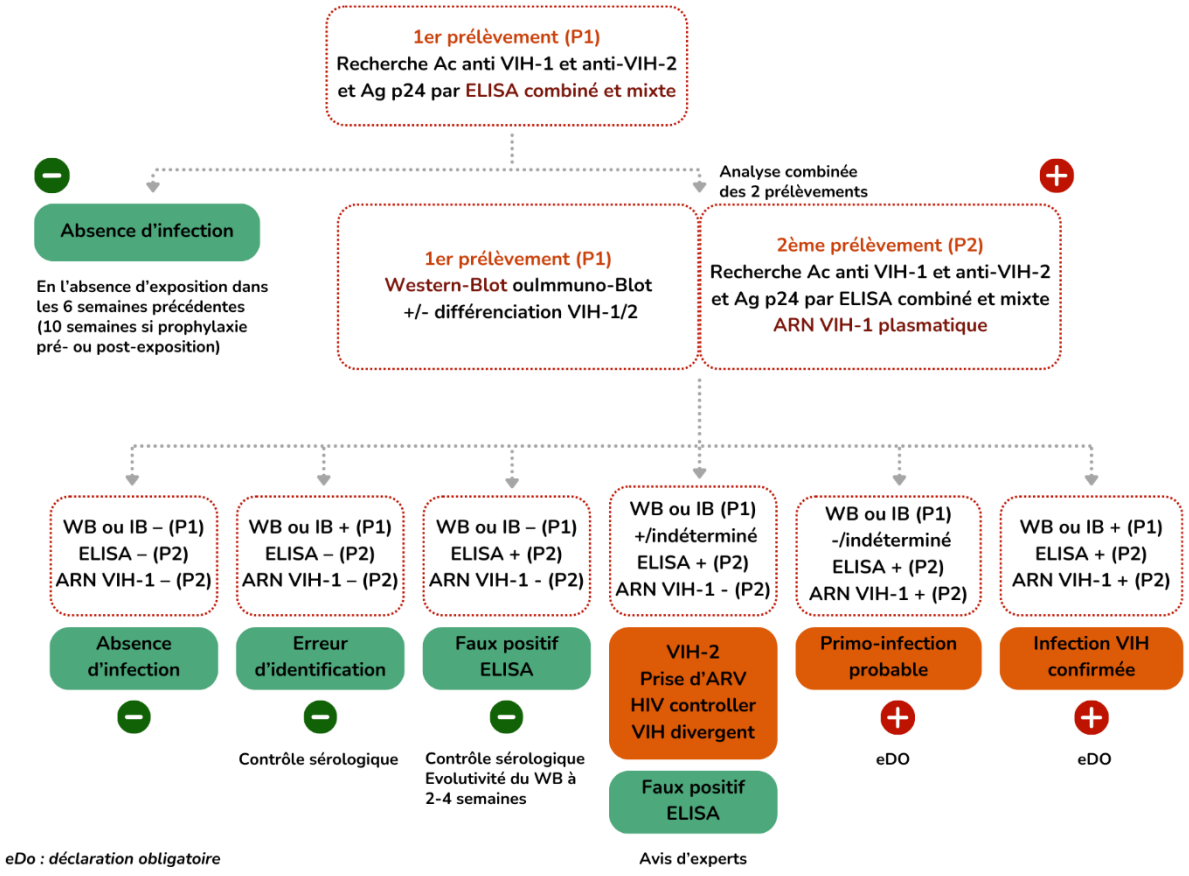


Figure 1: Algorithme de dépistage de l'infection VIH

Ac : anticorps ; ELISA= recherche d'anticorps anti VIH-1 et VIH-2 et Ag p24 par un test combiné de 4e génération ; P1 : premier prélèvement sanguin ; P2 : second prélèvement sanguin ; WB : Western Blot ; IB : Immunoblot ; eDO : déclaration obligatoire

Cas d'un TROD négatif ou d'autotest négatif

38. Un résultat négatif de TROD ou d'autotest ne peut être interprété en cas d'exposition au VIH dans les 3 mois précédents (risque de faux négatifs). Il est conseillé de renouveler le dépistage 6 à 12 semaines après l'exposition selon l'outil de dépistage choisi.

Cas d'un TROD positif ou d'un autotest positif

39. En cas de TROD positif, si le résultat du test est nominatif (le nom de la personne est inscrit sur la feuille de résultat), l'analyse de confirmation est réalisée sur un seul prélèvement sanguin (2 tubes) et comprend :

- Une sérologie ELISA VIH combinée de 4e génération
- Un Western blot / immunoblot VIH
- Une quantification de l'ARN VIH-1 plasmatique. (A)

40. En cas d'autotest positif, ou pour un TROD positif lorsque l'identité de la personne ne peut pas être vérifiée, l'autotest / le TROD ne peut remplacer le premier prélèvement (deux prélèvements distincts sur la même personne sont nécessaires pour affirmer un diagnostic). Dans ce cas, il est recommandé de faire :

- Un 1er prélèvement (2 tubes) avec :
  - Une sérologie ELISA VIH combinée de 4e génération ;
  - Un Western blot / immunoblot VIH ;
  - Une quantification de l'ARN VIH-1 plasmatique.
- Un 2e prélèvement avec le contrôle sérologique. (A)

L'ARN VIH-1 plasmatique est réalisé d'emblée sur le 1er prélèvement afin d'accélérer la prise en charge en cas de confirmation du diagnostic.

41. En cas de TROD ou d'autotest VIH positif, pour réaliser le test de confirmation, la personne doit être orientée préférentiellement en CeGIDD ou dans un service prenant en charge les PVVIH. Cela permettra un lien plus efficace aux soins ou à une prévention adaptée selon le résultat positif ou négatif du test de confirmation. (AE)

2.4. Offres de dépistage

La diversité des offres de dépistage du VIH permet d'augmenter les occasions de proposer un dépistage et de les adapter aux populations cibles. Dans la mesure du possible, le dépistage du VIH doit être proposé en même temps qu'un dépistage des hépatites B et C et des IST bactériennes, ce qui est possible dans la plupart des structures de soins proposant du dépistage. Lorsque le dépistage est proposé hors système de soin, la combinaison des dépistages est limitée par les outils disponibles.

Depuis la dernière actualisation du rapport d'experts en 2018, aucune évaluation du dispositif de dépistage du VIH dans son ensemble n'a été réalisée mais de nouveaux outils et offres ont été expérimentés. Le système de surveillance des données de dépistage et de diagnostic (Santé publique

France), ainsi que la plupart des chiffres repris ici, sont détaillés dans le chapitre « Epidémiologie et déterminants sociaux de l'infection VIH en France ».

2.4.1. Le dépistage du VIH dans le système de soin

2.4.1.1. Activité de dépistage du VIH en ville et à l'hôpital

L'activité de dépistage résulte de situations de prescription diverses. Parmi les 5,7 millions de sérologies réalisées en 2021, 75% étaient réalisées dans les laboratoires de biologie médicale (LBM) de ville. L'activité de dépistage des LBM est essentiellement liée à la prescription médicale, seuls 0,6% des tests réalisés le sont sans ordonnance et payés par le client (en dehors de l'expérimentation Au Labo Sans Ordo (ALSO) traitée plus bas,[85]). Les LBM (ville ou hôpital) rapportent un taux de positivité bas (1,9 tests positifs /1000 tests réalisés jusqu'en 2019 ; 1,6/1000 en 2020 et 2021), variable selon les régions (de 2,7/1000 en Ile-de-France à 0,6/1000 en Bretagne, 1,5/1000 en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou 1,3/1000 en Centre-Val-de-Loire). En 2021, ce taux était de 0,7/1000 dans les LBM de ville et 4,2/1000 à l'hôpital. A l'hôpital, le test VIH est plus souvent réalisé dans un contexte diagnostique, devant des symptômes ou une pathologie évocatrice d'une infection à VIH ou en contrôle d'un test réalisé en ville, d'où un taux de positivité plus élevé. Cependant, malgré le taux de positivité bas en ville, le nombre très élevé de tests réalisés par ces LBM permet d'identifier le plus grand nombre de personnes séropositives. Malgré la faible prévalence du VIH non diagnostiqué, notamment en population générale, il est primordial de maintenir une activité de dépistage soutenue [33,86,87].

En 2023, le nombre de sérologies a augmenté de 25% par rapport à 2021 avec 7,5 millions de sérologies réalisées [70].

2.4.1.2. Dépistage du VIH sur prescription par les médecins libéraux

Les recommandations HAS 2017 [32] désignent les médecins libéraux comme des acteurs clés pour inciter leurs patients à se faire dépister : principalement les médecins généralistes, mais aussi les spécialistes en dermato-vénéréologie, gynécologie, hépatologie, proctologie et cancérologie. Cette proposition de dépistage du VIH doit s'appliquer à : (i) la population générale âgée d'au moins 15 ans quand elle n'a jamais été dépistée, en mettant l'accent sur les hommes et tout particulièrement dans les régions les plus affectées ; (ii) aux consultants appartenant à une population clé.

En 2021, parmi les dépistages réalisés dans le secteur privé et remboursés par l'assurance maladie (donc hors hôpital et sérologies anonymes), 56% des tests chez les hommes et 43% chez les femmes ont été prescrits par un médecin généraliste, cette proportion est restée stable entre 2017 et 2021. Un gynécologue était à l'origine de 19% des prescriptions de test chez les femmes. A noter que dans 26% et 31% des tests réalisés chez les hommes et les femmes respectivement, le prescripteur n'est pas renseigné (source SNDS, extraction Santé publique France).

Le médecin généraliste a un rôle central dans le dépistage du VIH. Des études réalisées en France [88], au Royaume uni [89], ou aux Pays-Bas [90] montrent que plus de 60% des PVVIH sans le savoir consultent un médecin généraliste dans l'année précédant le diagnostic. Aux Pays-Bas, une étude comparant le nombre de dépistages du VIH réalisés et la proportion de tests positifs entre les médecins généralistes et les centres de santé sexuelle, montre que le médecin généraliste a un rôle important pour le dépistage des personnes n'appartenant pas aux populations clés et les plus âgées [91].

Une revue systématique incluant 29 études dont 6 françaises, publiée en 2018 [92], a décrit la proposition de dépistage du VIH en médecine générale en Europe. La revue rapporte que la plupart des dépistages prescrits par un médecin généraliste l'était à la demande du patient. Les principales barrières relevées étaient : (i) les médecins collectent très peu d'information sur la santé sexuelle de

leurs patients et ils disposent de peu d'outils de communication sur la santé sexuelle, (ii) les médecins connaissent mal les recommandations de dépistage du VIH et la liste des conditions évocatrices du VIH, et (iii) les médecins rapportent un manque d'expérience pour proposer le dépistage et rendre le résultat. Une étude qualitative récente, réalisée auprès de 122 médecins généralistes belges, rapporte les mêmes résultats [93]. Des formations et la mise en place d'outils pratiques ainsi que des campagnes de promotion du dépistage permettraient de lever ces freins. Ces résultats sont concordants avec une étude pilote française réalisée en 2012, qui expérimentait, une semaine donnée, la proposition systématique du dépistage conjoint du VIH, VHB et VHC par des médecins généralistes motivés aux personnes qui n'avaient jamais réalisé l'un des trois dépistages ou qui avaient une indication [94]. Les résultats en termes de dépistages prescrits n'étaient pas suffisants pour déployer plus largement cette étude, cependant elle a montré l'intérêt d'une intervention de courte durée avec une promotion dans la salle d'attente (affiche, dépliants). Pour certains médecins, cela a facilité la proposition du dépistage à des patients connus de longue date ("c'est la semaine du dépistage, je vous propose un test VIH"). Il faut noter que, même si l'étude n'avait pas été prévue pour relever cette donnée, moins de la moitié des dépistages prescrits avaient effectivement été réalisés un mois après l'étude. Il n'était pas possible d'observer cette donnée selon que l'ordonnance contenait d'autres analyses biologiques ou non. Les médecins participants avaient reçu une formation de deux heures aux indications de dépistage du VIH et des hépatites B et C. Cette formation avait permis d'augmenter leurs connaissances et de proposer plus de tests à leurs patients un mois après l'intervention.

Bien qu'il ait été montré que les barrières à la proposition d'un dépistage du VIH ou des IST diminuent quand le niveau de connaissances des soignants augmente sur ce sujet [95], les études européennes mesurant l'effet des formations des médecins généralistes pour augmenter la proposition de dépistage du VIH et des IST ou réduire les diagnostics tardifs du VIH rapportent des résultats très modestes (voire une absence d'effet [96] ou un effet transitoire [94,97]). Une seule étude, réalisée à Amsterdam auprès de médecins généralistes, montre un effet durable dans le temps d'une formation sur la proposition de dépistage du VIH et des IST [98,99]. L'intervention se déroule en deux sessions de formation avec la construction, à l'issue de la première session, par chaque petit groupe de médecins formés, d'un plan pour optimiser le dépistage du VIH et des IST dans leur pratique. Des newsletters avec leurs résultats en termes de dépistage et des petites mises à jour des connaissances leur étaient envoyées plusieurs fois par an. La seconde session de formation, plusieurs mois après la première, consistait à évaluer et réorienter le plan. Cette intervention, qui s'est déroulée entre 2015 et 2019 pour la première session de formation auprès d'environ 45% des médecins généralistes d'Amsterdam, a permis d'augmenter légèrement mais régulièrement le nombre de dépistages du VIH (aRR=1,02 [1,01-1,02] tous les trimestres) en maintenant un taux de positivité stable, alors que ces deux indicateurs diminuaient au cours du temps chez les médecins non formés. L'augmentation du nombre de tests a été plus marquée dans les groupes de population mis en avant lors de la formation notamment les femmes, les plus jeunes (< 20 ans) et les plus âgés (> 50 ans).

Plusieurs études mettent en avant le rôle des alertes dans les dossiers informatisés des patients pour rappeler au médecin de proposer un dépistage du VIH lors de la saisie d'une condition évocatrice du VIH [100,101]. Si cela semble efficace pour les conditions cliniques, il a été observé que l'orientation sexuelle ou d'autres situations pouvant exposer le patient au VIH ne sont pas saisies dans les dossiers [102].

Par ailleurs, si les recommandations de dépistage du VIH abordent l'ensemble des symptômes et conditions évocatrices du VIH (primo-infection, maladies classant SIDA, pathologies associées à une prévalence du VIH non diagnostiqué > 0,1%, encadré 1), les recommandations spécifiques des spécialités médicales relatives à ces conditions (en dermatologie, cancérologie, …) ne mentionnent pas systématiquement le dépistage du VIH. Une revue des recommandations médicales a été conduite

dans 15 pays européens dont la France. En France, au moins une recommandation a été identifiée pour 25 des 63 conditions étudiées (dont les évènements classant SIDA). Parmi ces recommandations, 86% mentionnaient le VIH et 57% préconisaient le dépistage du VIH. Ces proportions sont de 69% et 46% au niveau européen respectivement [103,104].

Encadré 1 : Signes, symptômes et pathologies évocatrices pour lesquelles un test de dépistage doit être systématiquement envisagé

Signes compatibles avec une primo-infection :

Signes cliniques compatibles avec un syndrome viral aigu persistant (fièvre, arthralgies, pharyngite, myalgies, asthénie) plus ou moins associé à une polyadénopathie, à des manifestations cutanéo-muqueuses (éruption cutanée maculo-papuleuse, ulcérations buccales et/ou génitales) et/ou neurologiques (céphalées, mononévrite etc.) et/ou troubles digestifs (diarrhées, amaigrissement etc.).

Ou **anomalies biologiques** : hématologiques (thrombopénie, neutropénie, hyperlymphocytose dans le cadre d'un syndrome mononucléosique ou lymphopénie précoce) plus ou moins associées à une cytolyse hépatique.

Découverte de pathologies opportunistes telles que décrites au stade C de la classification CDC **ou dans le cadre d'autres maladies indicatrices*** (source : étude européenne HIDES [105], pathologies associées à une prévalence d'infection à VIH non diagnostiquée > 0,1%).

Pour rappel, les huit pathologies indicatrices de l'étude HIDES sont :

Infections sexuellement transmissibles (IST)

Lymphomes malins quel que soit le type **

Dysplasie / cancer anal ou cervical **

Zona

Infection par le virus de l'hépatite B ou C, aiguë ou chronique, quelle que soit la date du diagnostic

Syndrome mononucléosique

Leucocytopénie ou thrombopénie de plus de 4 semaines non expliquée

Dermite séborrhéique / exanthème

* Une liste des pathologies classant SIDA et des maladies pouvant évoquer le VIH est présentée en Annexes.

** Pathologies pouvant correspondre selon leur type ou extension à des infections opportunistes classant SIDA - stade C de la classification CDC

Source : HAS [32], Rapport d'experts pour la prise en charge du VIH, chapitre Dépistage et prévention, 2018

Des études ont montré l'intérêt pour le médecin généraliste de disposer de TROD VIH afin de proposer un dépistage immédiat aux patients [106–108]. En effet, le patient réalise et reçoit le résultat au cours de la consultation avec une information adaptée. La faisabilité d'un tel dépistage n'est pas optimale

dans la pratique quotidienne du médecin généraliste : consultation trop longue, rémunération insuffisante [109,110].

42. Les médecins libéraux et notamment le médecin généraliste et le gynécologue doivent avoir un rôle central dans la proposition du dépistage du VIH associé à celui des hépatites B et C et des IST bactériennes selon les contextes. (C)

43. Les conditions cliniques évocatrices du VIH (symptômes de primo-infection, maladies classant SIDA, pathologies associées à une prévalence du VIH non diagnostiqué > 0,1%, cf. Encadré 1 et Annexe) devraient être intégrées dans les logiciels de gestion des dossiers médicaux pour émettre des rappels à proposer un dépistage. (C)

44. Une incitation financière des médecins libéraux à prescrire plus de dépistages du VIH, des hépatites B et C et des IST bactériennes aux populations cibles, pourrait être proposée, par exemple en les incluant dans les objectifs de santé publique (rémunération sur objectifs de santé publique, ROSP), ou dans d'autres dispositifs à venir. (AE)

45. Pour aider les médecins libéraux à atteindre ces objectifs, des formations comportant l'élaboration d'un plan individuel pour optimiser le dépistage dans la pratique quotidienne pourraient être développées. (C)

46. Les médecins généralistes et autres professionnels médicaux libéraux concernés (par exemple les sages-femmes) devraient pouvoir disposer facilement et gratuitement de TROD (VIH, VHB, VHC, syphilis ou autres selon leur disponibilité), pour les réaliser lors de la consultation quand il leur semble opportun. (AE)

2.4.1.3. Dépistage du VIH en consultation prénatale

Parmi les 13 210 femmes ayant participé à l'enquête nationale périnatale de 2016, 97% avaient été dépistées pour le VIH lors d'une consultation prénatale ; 0,15% des femmes dépistées avaient appris leur séropositivité à cette occasion [111]. En Europe, 50% des femmes immigrées vivant avec le VIH ont découvert leur séropositivité durant la période prénatale, souvent à un stade avancé de la grossesse [112]. Déjà impactée par les conditions de vie ou le non partage de la séropositivité avec l'entourage proche, l'observance au traitement ARV, initié pour préserver la santé de la mère et limiter les risques de transmission à l'enfant, est moins bonne en cas de diagnostic durant la grossesse [113,114].

En plus du dépistage obligatoire de la syphilis, la proposition d'un dépistage du VIH, des hépatites virales B et C doit être systématisée à l'occasion d'une grossesse. Les mêmes dépistages doivent être proposés lors des consultations pour un projet de grossesse, de contraception ou d'interruption volontaire de grossesse (Cf chapitre : Grossesse et VIH : désir d'enfant, soins de la femme enceinte et prévention de la transmission mère-enfant »). Dans tous ces cas, lorsque c'est possible, le dépistage devra être également proposé au partenaire. En cas d'exposition possible de la femme, il est nécessaire de renouveler le dépistage lors du dernier trimestre de grossesse. Pour rappel, en cas de découverte de séropositivité de la mère au cours d'une grossesse, il est nécessaire de s'assurer qu'elle a eu un test de dépistage du VIH au cours des grossesses précédentes. En cas de doute, un dépistage du VIH doit être proposé à l'ensemble de ses enfants. L'annonce de la séropositivité devra

s'accompagner d'une prise en charge sociale et psychologique pour assurer le bien-être de la mère et faciliter l'initiation et l'observance du traitement.

Des initiatives proposent aux futurs pères une consultation de dépistage et de prévention. C'est le cas par exemple de l'étude ANRS Partage qui proposait un dépistage du VIH par TROD ou un bilan élargi (hépatite B et C, syphilis, chlamydia, gonocoque, bilharziose) selon le contexte [115,116]. L'étude était proposée aux conjoints de femmes suivies pour leur grossesse à l'hôpital de Montreuil. 73% des femmes ont accepté de donner les coordonnées du père et 44% des pères ont accepté de participer. Parmi les 1347 hommes ayant réalisé la consultation de dépistage et de prévention, aucune infection à VIH n'a été détectée, en revanche, 53 hépatites B ont été diagnostiquées. Les auteurs mettent en avant quelques enseignements pour accompagner cette démarche : la nécessité absolue d'aller vers les pères, une unité de lieu et des horaires décalés pour les consultations, et une équipe pluridisciplinaire pour répondre aux nombreuses demandes qui ont dépassé le cadre de la consultation de prévention (soins généraux, vaccination, assistance sociale et juridique).

47. Il est recommandé de proposer un dépistage combiné du VIH, des hépatites B et C et IST bactériennes à l'occasion d'une grossesse, d'un projet de grossesse, d'une contraception ou d'une interruption volontaire de grossesse. (AE)

48. Une proposition systématique du même dépistage combiné du VIH, VHB, VHC et IST bactériennes doit être faite aux futurs pères, a fortiori auprès des populations les plus concernées et dans les territoires de plus forte prévalence. (AE)

49. Des recherches doivent être conduites pour identifier les conditions optimales de proposition et de réalisation de ces consultations aux futurs pères (quels professionnels, quels lieux, quelles formations, quels outils, …). (AE)

2.4.1.4. Dépistage du VIH aux urgences

Les services hospitaliers d'urgence semblent être des lieux privilégiés pour proposer du dépistage puisqu'ils reçoivent un flux important de consultants pour des motifs variés et une proportion importante de personnes éloignées du système de soins pour des raisons économiques ou administratives. Plusieurs études ont été réalisées au niveau international, notamment aux Etats-Unis et en France pour évaluer la pertinence d'une proposition de dépistage du VIH par TROD aux consultants des urgences [117–122]. Qu'il s'agisse d'une proposition généralisée de dépistage ou d'une proposition ciblée à l'aide de quelques questions simples permettant d'apprécier l'appartenance du patient à une population clé, les études s'accordent sur le fait que ce type de dépistage est faisable et bien accepté par les consultants et le personnel des urgences, notamment lorsqu'il est réalisé par les infirmières [123,124]. Toutefois, la proposition de dépistage, ou la remise du questionnaire de ciblage, est fonction du jour de la semaine, de la charge de travail et de la durée de l'expérimentation [125]. Les stratégies de dépistage ciblé semblent privilégiées pour réduire le nombre de tests réalisés [126,127]. Le taux de positivité des tests est faible (entre 0,1 et 6,1/1000 dans les expériences françaises [118,119,121]) et ne diffère pas selon qu'il s'agit d'un dépistage universel, d'un dépistage ciblé ou lorsque le dépistage est couplé avec un autre dépistage comme celui de l'hépatite B ou C [123,128–130]. Les personnes nouvellement diagnostiquées appartiennent le plus souvent à des populations clés et cumulent des vulnérabilités [118,119,121,131]. Elles sont diagnostiquées le plus souvent à un stade tardif de l'infection (entre 60% et 100% ont des CD4 < 350/µL, selon les expérimentations) suggérant que ce type de

dépistage permet de rattraper des PVVIH éloignées des autres offres de dépistage malgré leur appartenance à une population clé. Cet argument est en faveur d'un maintien de cette stratégie malgré les limites en termes de moyens humains et financiers pour proposer les tests et les réaliser. Contrairement à ce qui est rapporté dans les expériences américaines [132], le lien vers le soin des personnes nouvellement diagnostiquées est effectif en France [121].

50. Le groupe d'experts est favorable à la proposition d'un dépistage du VIH et des hépatites B et C aux urgences avec consentement implicite (notification que le test sera réalisé sauf si le patient s'y oppose ou « opt-out »). (B) Toutefois, il est nécessaire de poursuivre les recherches pour mettre en œuvre les interventions les plus efficientes, favoriser la proposition d'un dépistage conjoint du VIH et des hépatites B et C et préciser les populations cibles (affiner les questions de ciblage en fonction des territoires). (AE)

2.4.1.5. Dépistage du VIH dans les lieux de privation de liberté

Les personnes détenues sont considérées comme une population vulnérable pour le VIH, et les hépatites virales B et C, les prévalences de ces virus étant plus importantes qu'en population générale [133,134]. Des recommandations pour la prévention et la prise en charge des personnes sous main de justice ont été actualisées en 2019 [135]. Elles préconisent qu'un dépistage du VIH, du VHB, et du VHC soit systématiquement proposé à l'entrée en détention, renouvelé au cours de la détention et à la sortie si la personne n'a pas bénéficié de ces dépistages récemment. Le dépistage des IST doit être proposé selon l'exposition.

Comme le rappelle le Conseil national du Sida et des hépatites virales (CNS) dans son avis sur la prévention, le dépistage et le traitement de l'hépatite C chez les personnes détenues [136], un manque de données épidémiologiques pour cette population ne permet pas de savoir si les recommandations de dépistage sont suivies ou si les personnes détenues acceptent ces dépistages. D'après le CNS, seule une personne sur deux serait dépistée à l'entrée et une proportion importante de résultats négatifs ne serait pas rendue cumulant les opportunités manquées de dépistage et de prévention. Pour limiter cela, le CNS préconise l'utilisation des TROD comme outil prioritaire de dépistage et la mise en place de partenariats avec d'autres structures comme les CeGIDD ou les CSAPA (centres de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie) pour des interventions de dépistage et de prévention large. Toutefois, le dépistage par TROD est à la charge des équipes de soins. A ces difficultés s'ajoutent des difficultés structurelles pour mettre en place des actions de prévention (peines courtes, sorties sous bracelet, sorties non anticipées avec l'équipe médicale) et un manque de ressources humaines [137]. De plus, comme rappelé dans le chapitre « Epidémiologie et déterminants sociaux de l'infection VIH en France », un certain nombre de données sont recueillies par les équipes médicales mais restent non valorisées. Il est donc difficile dans ce contexte d'évaluer des interventions ou de mesurer une progression d'indicateurs.

51. Il convient de renforcer les stratégies de dépistage combinées de l'infection VIH et des hépatites virales. L'utilisation de TROD combinés (VIH, VHB, VHC, syphilis) faciliterait l'acceptabilité du dépistage par les personnes détenues, permettrait un rendu des résultats

immédiat et pourrait optimiser la prise en soins et/ou la prévention. Ces outils devront être mis à disposition gratuitement des unités de soins pénitentiaires. (AE)

52. Le recueil et l'analyse de données épidémiologiques est nécessaire afin de rendre plus efficientes les stratégies de dépistage et de prévention dans les lieux de privation de liberté. (AE)

2.4.1.6. Dépistage en CeGIDD

La réforme des structures spécialisées dans le dépistage s'est concrétisée dans l'arrêté du 1er juillet 2015 créant les CeGIDD (centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH, des hépatites virales et des autres IST) [77]. Ils sont financés par le fond d'intervention régional du ministère de la santé et pilotés par les ARS. La plupart sont gérés par des établissements publics de santé, d'autres par des collectivités territoriales ou des associations. Leurs missions sont très larges dans le champ de la santé sexuelle et comportent notamment la prévention, le dépistage, le diagnostic du VIH, des hépatites virales et des IST bactériennes, la PrEP et le traitement des IST bactériennes. L'objectif est d'accroître l'accessibilité et la qualité de l'offre de dépistage et de prévention, notamment pour les personnes les plus vulnérables, les plus exposées et les plus éloignées du système de soin.

Les données de surveillance des CeGIDD, pour l'année 2020, basées sur données individuelles d'environ la moitié des CeGIDD transmises à Santé publique France, montrent que l'objectif concernant les publics cibles est atteint : plus de 64% des consultants étaient des jeunes (< 30 ans, les mineurs représentaient 6% des consultants), 24% des personnes étaient nées à l'étranger (dont un tiers étaient en France depuis moins d'un an), et plus de 6% ne bénéficiaient d'aucun type d'assurance maladie. Lorsque l'information était disponible (soit pour 35% des consultations), 45% des consultants étaient des hommes hétérosexuels, 38% des femmes hétérosexuelles, 15% des HSH et 2% des femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes (FSF) [138]. Ces proportions changent peu en 2023 (chapitre « Epidémiologie et déterminants sociaux de l'infection VIH en France »). Dans le cadre de l'expérimentation « Au labo sans ordo » (ALSO), une comparaison des usagers de différentes offres de dépistage du VIH a été réalisée à partir d'enquêtes transversales réalisées une semaine donnée en novembre 2019 et novembre 2020 dans les laboratoires de biologie médicale et 11 CeGIDD de Paris et des Alpes-Maritimes. Elle confirme qu'en comparaison des personnes qui effectuaient un dépistage du VIH en laboratoire, sur ordonnance ou ALSO, les usagers des CeGIDD étaient plus jeunes, plus exposés au VIH, plus éloignés du système de soin et avaient une situation socio-économique moins bonne [139].

En excluant les consultations pour rendu des résultats de dépistages, les motifs de consultation les plus fréquemment rapportés en 2020 étaient une exposition au VIH ou aux IST (60% des consultations), un dépistage systématique (43%), l'initiation ou le suivi de PrEP (10% et 15%) et des signes évocateurs d'IST (10%). A noter que 27% des consultations se font dans le respect de l'anonymat [138].

Plus de 70% des consultants étaient dépistés pour le VIH. Le nombre de sérologies VIH réalisées en CeGIDD représente entre 3% et 6% du total des sérologies selon les années. L'activité des CeGIDD avait augmenté en 2019 (345 238 sérologies et 52 620 TROD) avant de chuter brutalement en 2020 en lien avec les mesures de confinement et les perturbations du système de santé dues à l'épidémie de COVID-19 (baisse de 58% des consultations lors du premier confinement, et de 23% lors du second confinement. Toutefois, en 2020, le taux de positivité a légèrement augmenté : 0,41% (0,80% en Ile-de-France ; 1,50% en Guyane) [138].

Environ 50% des consultants étaient dépistés pour l'hépatite B, le taux de positivité était de 0,93%. Les hommes nés à l'étranger présentaient le taux de positivité le plus élevé (3,4%). De même, environ 50% des consultants ont été testés pour l'hépatite C, plus souvent les HSH et les FSF nées à l'étranger (> 60%). Le taux de positivité des anticorps anti-VHC était de 0,6%. Concernant les IST bactériennes, plus de 60% des consultants étaient dépistés pour une infection à *Chlamydia trachomatis* et/ou à gonocoque (85% des HSH) et environ la moitié pour la syphilis (70% des HSH). Les taux de positivité étaient respectivement de 7%, 4% et 1%.

Ces données sont issues de la moitié des CeGIDD en France, avec une forte hétérogénéité entre les régions et une proportion très importante de données manquantes sur certaines variables, notamment celles permettant d'apprécier l'appartenance des consultants à une population clé. Malgré ces limites importantes, elles donnent un aperçu de leur activité de dépistage et de leurs publics conformes aux objectifs fixés.

Outre la participation insuffisante des CeGIDD à la surveillance SurCeGIDD en 2020, qui a augmenté depuis, des outils harmonisés au moins au niveau régional permettrait d'améliorer la surveillance épidémiologique et le recueil de données de soins et de prévention. Pour valoriser cette collecte, des moyens humains doivent être disponibles notamment pour la saisie, l'analyse statistique et la rédaction des rapports (Cf. chapitre « Epidémiologie et déterminants sociaux de l'infection VIH en France ».

La pérennité des financements (appuyée sur un recueil de données fiables) doit être assurée. Il convient cependant de réfléchir aux modalités de fonctionnement afin que ces structures restent coût-efficaces. La nécessité de maintenir des "antennes" dans tous les départements devrait être évaluée par les ARS, dans un contexte où de multiples possibilités de dépistage, de proximité, sont peut-être disponibles sur les territoires concernés. Les actions de dépistage ou de promotion de la santé sexuelle dites « hors les murs », souvent réalisées avec des acteurs de terrain, allant vers les publics cibles, très exposés et/ou marginalisés, doivent être conservées voire développées.

Des protocoles de délégation de tâches sont possibles, afin que le temps médical soit utilisé à bon escient [140]. S'il est reconnu qu'une remise de résultats négatifs doit se faire en face à face afin de faire de cette consultation un temps de prévention, il est en revanche possible d'envisager des moyens de rendu de résultats dématérialisés pour les personnes faisant des dépistages très réguliers et déjà très au fait des outils de prévention (personnes utilisant la PrEP notamment).

L'accueil des mineurs de plus de 15 ans doit pouvoir se faire et tous les moyens de prévention adaptés à leurs pratiques sexuelles doivent pouvoir leur être proposés. Pour rappel, le dépistage du VIH et l'initiation de la PrEP peuvent être réalisés à des mineurs de plus de 15 ans sans l'autorisation parentale mais en présence d'un adulte de confiance choisi par le mineur. Ce n'est pas le cas pour la vaccination dans le cadre légal actuel. Un rapport de l'IGAS (inspection générale des affaires sociales) de 2023 portant sur les centres de santé sexuelle, semble remettre en cause les modalités de financement des CeGIDD [141]. Il faudra donc porter une attention particulière au maintien de cette offre de soins accessible et gratuite pour tous et notamment les jeunes et les personnes précaires.

Les CeGIDD sont des lieux de dépistage et de prévention en santé sexuelle. Ils sont davantage fréquentés par des personnes exposées au VIH et aux IST, jeunes, nées à l'étranger, avec un niveau socio-économique défavorisé.

53. Le financement des CeGIDD doit être pérennisé et leur fonctionnement optimisé afin d'atteindre les objectifs en termes d'augmentation du dépistage et d'accès à la prévention des populations plus précarisées et/ou éloignées du soin. (AE)

54. Il est primordial d'améliorer le recueil de données épidémiologiques des CeGIDD, de façon uniformisée au niveau national, pour faciliter l'orientation et l'adaptation des actions de dépistage et de prévention dans leurs territoires. Pour cela, des moyens humains et financiers sont nécessaires. (AE)

55. En accord avec les recommandations de l'IGAS (rapport 2022-049R, recommandation 18), des centres rassemblant les missions des CeGIDD et des centres de santé sexuelle (ex-centres de planification ou d'éducation familiale), ciblant les femmes, les personnes migrantes ou en situation de précarité socio-économique et répondant à leurs besoins spécifiques, devront être expérimentés. De même, des structures ou des accueils pour des populations spécifiques comme les personnes transgenres ou les personnes pratiquant le chemesex pourront être expérimentés. L'objectif est de faciliter l'accès de ces populations aux dépistages, à une prévention adaptée et aux soins en santé sexuelle en réduisant les inégalités sociales de santé, de genre et les discriminations. (AE)

56. L'accueil des mineurs de plus de 15 ans et leur accès à l'ensemble des outils de dépistage et de prévention doivent être assurés. (AE)

57. Le groupe d'experts est en faveur d'une exception au consentement parental pour la proposition des vaccinations aux mineurs susceptibles d'être exposés (VHA, VHB, HPV, Mpox, …) ainsi que pour la proposition de la PrEP. Le mineur devra être assisté d'un adulte de confiance choisi par lui et l'information qu'il recevra devra être adaptée pour éclairer sa décision. (AE)

2.4.1.7. Dépistage du VIH dans les laboratoires de biologie médicale (VihTest)

A Paris et dans les Alpes-Maritimes, deux départements de l'initiative « fast-track cities », une étude pilote (Au labo sans ordo - ALSO) a été mise en place de juillet 2019 à décembre 2020 [85]. Tous les laboratoires de biologie médicale de ville accueillaient toute personne demandant un dépistage du VIH, sans ordonnance, sans rendez-vous et sans frais. Le dépistage était basé sur une sérologie et remboursé au laboratoire par l'assurance maladie via un code acte spécifique. Le dépistage était réalisé sans counseling. Seules les quelques informations permettant de respecter le principe de consentement éclairé devaient être fournies. Les résultats négatifs étaient rendus par courrier ou email et contenaient une information écrite promouvant la répétition des dépistages et la PrEP comme moyen de prévention. En cas d'ELISA positif, un Western blot était réalisé et la personne était rappelée pour réaliser le second prélèvement. Les résultats positifs étaient rendus en face à face. Les biologistes ont suivi une formation courte concernant notamment le rendu des résultats positifs. Selon le choix de la personne dépistée, le résultat pouvait être rendu par son médecin traitant. Une communication importante a été déployée pour le lancement de l'étude et le maintien dans le temps.

Cette étude pilote a été évaluée en termes d'activité, de profils des usagers et de coûts [85,139,142,143]. L'étude a été fortement impactée par la pandémie de COVID-19, toutefois 38 945 tests ALSO ont été réalisés dans les deux départements soit 7,2% des dépistages du VIH réalisés en laboratoires. Le taux de positivité des tests n'était pas différent de celui des tests réalisés sur prescription médicale (2,2/1000). Deux études transversales courtes réalisées en novembre 2019 et novembre 2020 ont permis de caractériser les usagers ALSO, les personnes testées sur prescription médicale et celles testées pour le VIH en CeGIDD des mêmes départements. Les personnes qui ont fait un test ALSO

avaient un profil intermédiaire en termes d'exposition au VIH et de précarité entre les personnes testées pour le VIH sur prescription médicale et en CeGIDD. L'offre ALSO attirait davantage les hommes hétérosexuels. Dans l'enquête de 2020, 19% des personnes dépistées dans le programme ALSO avaient un dépistage du VIH en laboratoire sans ordonnance, très probablement un dépistage ALSO. Ces personnes étaient plus souvent des hommes hétérosexuels. Les hommes hétérosexuels vivant avec le VIH ont le délai estimé le plus long entre infection et diagnostic (> 4 ans [33]), il est donc particulièrement intéressant d'attirer cette population au dépistage. Le fait de ne pas aborder la sexualité lors d'un entretien pré-test pourrait être un levier à l'accès au dépistage ALSO pour ces hommes. En termes de coût, basée sur un dispositif de dépistage existant et sans counseling, l'offre ALSO utilise moins de ressources que le test prescrit, le test en CeGIDD ou le dépistage communautaire. Le coût pour identifier un positif est proche de celui du dépistage communautaire, plus faible que ceux du dépistage en CeGIDD ou avec prescription.

L'expérimentation a été étendue à toute la France, sous la dénomination grand public « VIHTest », et inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale 2021 [80]. En 2022, 248 500 VIHTests ont été réalisés pour 246 800 bénéficiaires (données du SNDS [144]). Ils représentent presque 5% des sérologies VIH remboursées. Après une montée en charge progressive au premier semestre 2022, 30 000 VIHTests ont été réalisés chaque mois. L'offre continue de bénéficier aux hommes (49% des personnes testées avec VIHTEST en 2022 étaient des hommes contre 38% de l'ensemble des personnes avec une sérologie remboursées) et aux personnes plus âgées (52% des personnes testées avec VIHTest avaient 40 ans ou plus contre 36% de l'ensemble des personnes avec une sérologie remboursées). En 2023, 841 436 VIHTests ont été remboursés soit une augmentation de 235% par rapport à 2022. Cette fois la part de femmes est plus importante (54%) et 44% des bénéficiaires avaient plus de 50 ans [70].

En région, la mise en place de l'offre VIHTest a été assurée par une collaboration entre l'ARS, le COREVIH, l'union régionale des biologistes et la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie). VIHTest est accompagné par un dispositif d'orientation du patient dont le sérodiagnostic VIH est positif vers des services spécialisés. Ce dispositif est appelé « navigation VIHTest ». Chaque région a fait le choix de la structure assurant la navigation qui est le plus souvent le COREVIH ou Sida Info Service. Le laboratoire a le choix d'utiliser la navigation ou bien d'orienter le patient vers son médecin traitant ou directement vers le service spécialisé.

Il faut rappeler qu'il s'agit d'une modalité de dépistage à la demande du consultant et non une incitation de la part du biologiste.

58. VIHTest est une offre de dépistage du VIH qui doit être développée et promue en complément des autres offres de dépistage. (C) La promotion de cette offre et de ses spécificités doit être poursuivie. Elle doit être présentée comme l'une des possibilités de dépistage auprès du grand public et des populations clés et sa disponibilité doit être explicite dans les laboratoires. (AE)

59. Comme les autres offres de dépistage, le dépistage VIHTest doit pouvoir être réalisé chez les mineurs de plus de 15 ans sans consentement parental, avec l'assistance d'un adulte de confiance choisi par le mineur. (AE)

60. Sur le principe des offres VIHTest et Mon test IST, un dépistage conjoint du VIH, des hépatites B et C et des IST bactériennes (avec un prélèvement sanguin et des auto-prélèvements locaux) devrait pouvoir être proposé à toutes les personnes qui demandent spontanément

l'un de ces dépistages en laboratoire de biologie médicale, dès 15 ans, sans avance de frais et sans limite d'âge. (AE)

2.4.1.8. Dépistage en pharmacie d'officine

Le dépistage du VIH par TROD en pharmacie d'officine a été expérimenté dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis [145–147], au Canada [148,149] et en Espagne [150]. Ces études s'accordent sur le fait que ce dépistage est faisable et acceptable pour le personnel des pharmacies d'officine ainsi que pour les usagers. Il permet de lever des barrières d'accessibilité en proposant le dépistage dans des structures de proximité, même en milieu peu urbanisé, et avec de larges horaires d'ouverture même en fin de semaine [151]. Les usagers du dépistage en pharmacie sont le plus souvent des personnes exposées au VIH, ainsi que des hommes hétérosexuels [151–153]. Ces mêmes avantages ont été mis en évidence en France par l'expérimentation Au Labo Sans Ordo (ALSO) [139,142].

Dans les expérimentations étrangères, les pharmaciens mettaient en avant quelques difficultés : la disponibilité du personnel formé au dépistage pour un service sans rendez-vous (préféré par les usagers), la nécessité d'avoir un lieu de confidentialité pour réaliser les dépistages et le counseling, la prise en charge du test / la rémunération du pharmacien et la charge de travail [148,154–156]. En France, depuis quelques années, le pharmacien d'officine réalise le dépistage du SARS-CoV-2, de l'angine à streptocoque et les vaccinations. Plusieurs de ces barrières organisationnelles ont donc déjà été levées.

Une étude canadienne a comparé le dépistage du VIH par TROD par le pharmacien à la vente d'autotests VIH en termes de coûts et d'efficacité [157]. Les résultats sont en faveur du TROD qui malgré un coût un peu plus élevé permet une meilleure continuité des soins et un nombre de QALYs (année de vie gagnée ajustée sur la qualité de vie) plus élevé. Toutefois, une autre étude menée auprès d'HSH aux Etats-Unis montrent que les usagers les plus exposés au VIH et ceux éloignés du dépistage préféraient l'autotest au dépistage en pharmacie [158].

En France, le dépistage du VIH dans les laboratoires de biologie médicale, sans ordonnance et sans frais (VIHTest) a été pérennisé en 2022 et a été étendu aux IST en 2024 pour les personnes de moins de 26 ans. Toutefois, même si l'accessibilité du dépistage est facilitée par la proximité géographique des laboratoires, l'ensemble de la population ne fréquente pas les laboratoires régulièrement, notamment les jeunes adultes, contrairement aux pharmacies d'officine. De plus, le pharmacien est impliqué dans la délivrance de préservatifs, de la contraception d'urgence, et ces derniers mois, il a rempli d'autres missions (dépistage du COVID-19, vaccination) renforçant ainsi son rôle dans la prévention et le dépistage auprès du grand public.

61. Le pharmacien est un acteur de la santé sexuelle en dispensant des autotests VIH, la contraception d'urgence, les préservatifs et l'ensemble des traitements des IST, et plus récemment en réalisant les vaccinations. Le groupe d'experts recommande d'expérimenter le dépistage du VIH et des hépatites B et C par TROD dans les pharmacies d'officine en complément des autres offres de dépistage. (C)

2.4.1.9. Les structures de prévention ou spécialisées

Les données d'activité de dépistage du VIH, des hépatites B et C et des IST bactériennes réalisées par les autres structures type planification familiale, services de santé universitaires, ne sont ni centralisées ni disponibles. Il est donc difficile d'émettre des recommandations. Toutes les structures œuvrant dans le champ de la santé sexuelle devraient proposer de dépister le VIH, les hépatites B et C et les IST bactériennes à l'ensemble de leurs consultants.

2.4.2. Le dépistage hors système de soin

2.4.2.1. Le dépistage du VIH par les associations

Depuis 2010, les structures associatives habilitées réalisent le dépistage du VIH, depuis 2017 celui de l'hépatite C et depuis 2021 celui de l'hépatite B à l'aide de TROD, le plus souvent lors d'actions « hors les murs » [159]. Dans l'offre de dépistage communautaire, un temps important est consacré, d'une part, à attirer les personnes cibles vers le dépistage, et d'autre part, au counseling pré et post test [143]. C'est cette capacité à aller au-devant des populations clés, de façon personnalisée, qui fait leur valeur ajoutée. A noter que pour garantir la qualité de la démarche diagnostique, il est indispensable pour ces structures, de disposer d'un réseau d'aval pour la confirmation du diagnostic et la prise en charge précoce des personnes recevant un résultat positif.

Entre 2011 et 2019, le nombre de TROD communautaires VIH réalisés chaque année a fluctué entre 55 000 et 70 000. En 2020, le nombre de TROD VIH réalisés a diminué de moitié (30 349), en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. En 2023, environ 51 000 TROD VIH ont été réalisés (source Direction Générale de la Santé). 81% des TROD étaient réalisés lors d'actions hors les murs. Ces TROD communautaires ont concerné les populations clés : 20% d'HSH, 43% de personnes migrantes, 8% d'usagers de drogues, 8% de personnes en situation de précarité, 4% de travailleurs et travailleuses du sexe. Seules 17% de personnes n'appartenaient pas à ces publics cibles. En 2020, plus d'un tiers (38%) des personnes ayant bénéficié d'un TROD n'avaient jamais été dépistées pour le VIH, 32% avaient été dépistées plus d'un an auparavant et 30% dans l'année précédente (Cf. Chapitre « Epidémiologie et déterminants sociaux de l'infection VIH en France ».

Malgré le faible nombre de dépistages réalisés par TROD communautaires comparativement à l'activité globale de dépistage (< 1%), la proportion de tests positifs y est plus élevée. En 2021, cette proportion était de 8,6/1000 TROD communautaires (versus de 2,1/1000 sérologies anonymes et de 1,6/1000 sérologies non anonymes). Parmi les 382 personnes recevant un TROD positif, 12% connaissaient déjà leur séropositivité ; 79% ont été liées aux soins spécialisés dans les 3 mois qui ont suivi. A noter que les HSH (34%) et travailleurs et travailleuses du sexe (14%) étaient surreprésentés parmi les personnes avec un TROD positif (40% migrants, 5% de personnes précaires, 4% d'autres publics non précisés et 3% d'usagers de drogues).

Encadré 2 : Illustrations de l'activité de dépistage des associations auprès de populations spécifiques, souvent peu atteintes par les autres offres de dépistage.

Ces chiffres montrent que quelle que soit la capacité de l'association à réaliser des TROD, les publics atteints sont très spécifiques et les taux de positivité sont très élevés.

- L'association Acceptess-T propose des dépistages du VIH par TROD lors des permanences d'accueil à Paris. Les bénéficiaires sont principalement des femmes transgenres et des hommes cisgenres, le plus souvent migrants et travailleurs du sexe. En 2022, sur 1008 TROD VIH réalisés, 45 étaient positifs (soit un taux de positivité de 4,5%). La moitié des tests positifs correspondaient à des découvertes de séropositivité et l'autre moitié, à des personnes qui connaissaient leur séropositivité mais ne savaient pas comment accéder aux soins en France. Parmi les 45 personnes avec un test positif, 78% étaient travailleurs ou travailleuses du sexe, 84% étaient sans papier, 62% des femmes transgenres, 11% des HSH (travailleurs du sexe). Concernant les autres TROD réalisés, 6 TROD VHC étaient positifs parmi les 489 réalisés, 3 TROD VHB sur 602 et 24 TROD syphilis sur 503. L'association réalise également des actions de prévention « hors les murs » dans lesquelles sont proposées du dépistage ainsi que des actions « d'aller vers » en ligne. Environ 5000 personnes ont été approchées en ligne. En 2022, 657 autotests VIH ont été envoyés. Parmi les 283 résultats connus, 3 étaient positifs.
- L'association Afrique Avenir propose des actions de prévention et de dépistage principalement dans des lieux de vie et de passage de personnes afro-caribéennes en Ile-de-France ou dans le local d'associations partenaires comme Afrique Arc-en-ciel par exemple. En 2022, 3781 TROD VIH ont été réalisés, la plupart (64%) à des hommes. Le taux de positivité était de 1,2%, il était plus élevé lorsque le test était fait au local de l'association qu'en extérieur. 16% des tests positifs concernaient des HSH nés à l'étranger, 23% des usagers de drogues injectables et 6% des travailleuses du sexe. Le TROD VIH était quasi systématiquement accompagné d'un TROD VHC et VHB. Les taux de positivité étaient respectivement de 1,6% et 4,6%.
- L'association Cabiria propose des actions de santé communautaires avec les personnes travailleuses du sexe à Lyon. En 2022, 53 TROD VIH ont été réalisés, 50% au local de l'association (environ une permanence par mois) et 50% lors d'action « hors les murs », 86% auprès de personnes travailleuses du sexe, principalement des femmes et 8% des personnes transgenres. Le taux de positivité VIH était de 5,7%. 28 TROD VHB ont également été réalisés identifiant 2 personnes qui connaissaient leur statut et 47 TROD VHC, avec une découverte (2,1%). L'association fournit également des autotests VIH aux personnes travailleuses du sexe en mobilité [18].

Les données présentées sont issues des rapports d'activité 2022 des associations citées.

Le dépistage conjoint du VIH, du VHB, du VHC et de la syphilis est tout particulièrement important dans ces contextes, aujourd'hui en utilisant les différents types de TROD disponibles, et/ou la remise d'un autotest VIH lorsque cela est possible. Pour augmenter l'acceptabilité du dépistage conjoint, il est indispensable que les associations et les structures sanitaires réalisant le dépistage « hors les murs » puissent disposer de TROD combinés. Une expérimentation de l'association AIDES a montré une forte attractivité du TROD combiné VIH / syphilis permettant d'une part de répéter le test VIH dans une population hautement exposée et de détecter des syphilis actives non diagnostiquées [160] (Cf. chapitre « Dépistage des IST »).

Les associations de santé communautaires sont donc des acteurs incontournables et à privilégier pour atteindre les populations clés. Toutefois, cette offre de dépistage est limitée par les ressources humaines et financières des opérateurs.

Conçus dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle [54,55,81], et expérimentés dans le cadre de l'article 51[1], 4 centres de santé sexuelle d'approche communautaire ont été créés par l'arrêté de novembre 2020 dans 4 grandes villes. Basés sur une approche communautaire, ils apportent une offre globale en santé sexuelle avec un accès facilité au dépistage, aux traitements et à la prévention du VIH et des IST. Les premières données d'activité des Spots à Marseille et Montpellier (pilotés par l'association AIDES) montrent une augmentation importante du nombre de dépistages du VIH par rapport aux dépistages réalisés dans les lieux de mobilisation de l'association (multiplié par 2 à Marseille et par 4 à Montpellier si on compare le nombre de tests réalisés en 2019 avant l'ouverture du Spot et en 2022). L'attractivité de l'offre est expliquée, selon l'association, par des horaires d'ouverture plus larges, une offre élargie de dépistages (et plus uniquement TROD VIH et VHC), la proposition immédiate de traitement des IST et la possibilité d'initier immédiatement la PrEP après un résultat VIH négatif (source : AIDES).

62. Le rôle majeur des associations de santé communautaires dans le dépistage des personnes les plus exposées, dans leurs lieux de vie ou de consommation sexuelle, doit être réaffirmé et soutenu par les autorités de santé territoriales. (C)

63. Pour donner les moyens aux associations réalisant des dépistages de poursuivre voire d'étendre ce type d'interventions, un financement pérenne est nécessaire. Ces financements doivent couvrir l'achat des tests mais aussi le coût des actions de dépistage, de la logistique, de la communication, de la formation des acteurs impliqués et du recueil de données. (AE)

64. Il est important d'améliorer le recueil, uniformisé et centralisé, de données épidémiologiques des associations réalisant du TROD afin de faciliter l'orientation et l'adaptation des actions de dépistage et de prévention dans leurs territoires. Pour cela, des moyens humains et financiers sont nécessaires. (AE)

65. La mise à disposition d'outils de dépistage combinés (VIH / VHC / syphilis par exemple) renforcera leur rôle dans la prévention et le dépistage des populations les plus exposées en limitant, notamment lors des actions « hors les murs », les orientations vers d'autres structures de dépistage et donc le risque de perdre les personnes de vue. (AE)

2.4.2.2. L'autotest VIH

L'autotest VIH a été introduit dans la stratégie de dépistage avec l'objectif de lever les barrières structurelles d'accès au dépistage. Par définition, il met en avant l'autonomie de l'usager et lui procure une plus grande confidentialité. Plusieurs documents ont été produits pour assurer un maximum d'information de l'usager et des professionnels impliqués dans la distribution de l'autotest [161].

Les études réalisées avant la commercialisation ont montré une très bonne maniabilité de l'autotest quelle que soit la population [162–165]. On observe également un apprentissage au fur et à mesure des utilisations. Les notices de chaque autotest commercialisé en France sont très illustrées facilitant la

[1] L'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale permet de déroger aux règles d'organisation et de financement de droit commun du système de santé. Chaque expérimentation a ainsi vocation à tester des nouveaux modèles de financement ayant vocation à se généraliser progressivement.

manipulation de l'outil et la lecture du résultat même si on maîtrise peu le français. L'importance des vidéos de démonstration disponible sur internet a aussi été mise en avant.

En France comme en Europe, les enquêtes montrent une faible proportion de personnes qui ont déjà utilisé l'autotest [166–171]. Les principaux motifs pour ne pas avoir utilisé l'autotest sont : (i) le fait de ne pas le connaître ; (ii) le prix trop élevé ; (iii) un manque de confiance dans l'outil. Depuis son lancement fin 2015 en France, les chiffres de vente d'autotests dans les pharmacies sont relativement stables, entre 60 000 et 75 000 par an. En 2022, seulement 40% des pharmacies avaient des autotests VIH en stock (source : données de vente IQVIA, transmises par Santé publique France). Cette proportion est plus importante en Ile-de-France (entre 57 et 60% selon les mois) et dans les grandes (entre 50 et 55%) et les très grandes (autour de 70%) pharmacies. La disponibilité de cet outil suit donc la répartition des autres modalités de dépistage existantes. Depuis la première mise sur le marché d'un autotest, d'autres références ont obtenu le marquage [172] et peuvent être commercialisées en France avec une variation importante des prix de vente. En 2022, les deux références d'autotest VIH les plus vendus sont au prix unitaire de 12€ pour l'un et de 18€ pour l'autre (prix en France métropolitaine, données de vente IQVIA, transmises par Santé publique France)

Peu d'études décrivent les personnes qui achètent un autotest en pharmacie. Les études décrivent le plus souvent des usagers de l'autotest, fourni gratuitement dans le cadre d'une intervention expérimentale ou lors d'enquêtes en populations [166,169,173,174]. Ces dernières s'accordent sur le fait que les usagers de l'autotest sont plus souvent des personnes aisées socio-économiquement avec un niveau d'étude élevé et qui se soucient de leur santé. Ces personnes, le plus souvent des HSH, ont tendance à réaliser des dépistages du VIH régulièrement. Dans l'expérimentation Mémodépistages, évaluant un système de programmation des dépistages pour favoriser la répétition du test tous les 3 mois chez des HSH exposés, une grande partie des dépistages réalisés entre les bilans annuels l'était avec des autotests [175]. Ces résultats confirment que l'autotest est adapté au dépistage répété. Toutefois, parmi les usagers, on observe une petite part d'entre eux qui utilisent l'autotest comme premier dépistage de leur vie. Ces personnes sont plus souvent jeunes, avec un niveau d'étude plus bas que les autres utilisateurs, et vivent leur homosexualité de façon plus secrète [173,175].

L'autotest est décrit par les usagers comme rapide, pratique et confidentiel [164,165,173,176]. Il permet à des personnes qui ont peur d'être jugées sur leurs pratiques dans un centre de dépistage ou avec un médecin, d'accéder au dépistage ; pour d'autres, de répéter le dépistage [177,178]. Toutefois, en pharmacie d'officine, l'autotest n'est pas en libre-service. Le fait de devoir demander l'autotest au pharmacien est un frein pour certains usagers [170].

Depuis 2016, certaines structures sont autorisées à remettre des autotests VIH à leurs usagers, c'est le cas des CSAPA, CAARUD, CeGIDD et des associations habilitées TROD [179]. En 2021, 32 530 autotests ont été délivrés par 40 associations, 50% lors d'actions « hors les murs », 17% dans les locaux de l'association et 33% par courrier. Cette délivrance par courrier est compliquée par l'obligation de réaliser un entretien pré-test. Certaines associations proposent cet entretien en visio avant l'envoi. La délivrance d'autotests VIH par les associations a bénéficié principalement à des HSH (48%) et des personnes migrantes (19%) (données 2021, source : DGS).

Il faut noter qu'au Royaume-Uni, où le nombre de nouveaux diagnostics et l'incidence du VIH baissent grâce notamment à une politique favorisant la répétition des dépistages dans les populations clés, 50% des tests VIH effectués en 2022 étaient des tests réalisés de façon autonome, commandés via internet (autotests et auto-prélèvements) [67].

Les deux inconnues avec l'autotest sont le nombre d'autotests positifs et le lien effectif aux soins. Les études montrent un lien vers le test de confirmation puis le soin efficace [174,180].

Pour rappel, la sensibilité de l'autotest est plus faible que celle des tests ELISA lors de la primo-infection et lorsque la personne prend des ARV. L'autotest VIH n'est donc pas indiqué pour le suivi de la PrEP ou lors d'exposition au VIH très récente.

66. Le groupe d'experts est en faveur d'un changement de législation pour placer l'autotest VIH en libre-service dans les pharmacies d'officine. (AE)

67. L'accès aux autotests devrait être facilité en améliorant leur disponibilité et leur visibilité dans les pharmacies, notamment en régions et dans les zones moins urbaines où les autres offres de dépistage sont également moins accessibles. (AE)

68. Il est recommandé que, si la personne le souhaite, le pharmacien puisse superviser la réalisation de l'autotest VIH afin d'assurer la personne dans la manipulation du test, l'aider à lire le résultat et lui apporter les informations nécessaires. La réalisation de l'autotest devra pouvoir se faire à l'officine, dans un espace qui garantit la confidentialité. L'identification d'un dispositif d'aval d'orientation médicale, de prévention (PrEP si négatif) et de soutien est recommandée. (AE)

69. Une diminution du prix de l'autotest permettrait de faciliter l'accès à des personnes plus précarisées ou marginalisées. (AE)

70. Il est important d'expérimenter des modalités d'accès facilité à l'autotest comme la commande d'autotest VIH par internet auprès d'un opérateur dédié, un programme de soutien communautaire au dépistage régulier, la remise d'un ou plusieurs autotests lors d'un dépistage en CeGIDD, …, et de valoriser les données des expériences associatives sur ce sujet. (AE)

71. Les autotests devraient pouvoir être dispensés sans condition d'entretien préalable afin de faciliter les dispositifs d'envoi postal. (AE)

2.4.2.3. Dépistage par auto-prélèvements à domicile sans résultat immédiat

Les dispositifs de dépistage par auto-prélèvements à domicile sans résultat immédiat, appelés « home test » ou « self-sampling kit » en anglais existent depuis de nombreuses années aux Etats-Unis et Royaume-Uni notamment [181–183]. En France, la première expérience d'auto-prélèvement avec un résultat rendu aux participants a concerné le dépistage des infections à *Chlamydia trachomatis* chez les jeunes (Chlamyweb [184,185]), puis le dépistage du VIH et des hépatites virales en population générale pour le volet sérologique BaroTest [186,187] couplé au baromètre santé 2016 et plus récemment a été étendu à la recherche des IST bactériennes chez les HSH dans l'étude MemoDépistages [188] ou en population générale dans l'étude PrévIST [https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/etude-previst-2022-2023], études toutes menées par Santé publique France. D'autres expériences récentes ont également eu lieu en Europe [189] ou aux Etats-Unis [190]. Selon les études et les pathogènes recherchés, l'auto-prélèvement se faisait par écouvillonnage (gorge, anus, vagin, pénis), recueil d'urine, prélèvement de sang capillaire sur buvard ou dans un microtainer. Les performances de ces recueils sont documentées dans la littérature, en particulier pour les prélèvements locaux, et font l'objet de développements continus [191–195]. Dans chaque étude, l'acceptabilité de l'auto-prélèvement était bonne, le taux de retour des prélèvements au

laboratoire était autour de 50% lors de l'inclusion, variable selon la population et le niveau d'éducation. Le taux de retour augmente au fur et à mesure des utilisations. La qualité des échantillons prélevés permettait la réalisation des analyses.

Visant à promouvoir le dépistage trimestriel du VIH, le dispositif MémoDépistages s'appuyait sur l'ensemble de l'offre de dépistage existant en France (autotest, TROD, consultation en CeGIDD…), auquel s'ajoutait l'auto-prélèvement pour le bilan initial comprenant le dépistage du VIH, du VHC, de la syphilis, et la recherche de chlamydia et gonocoque aux 3 sites [175]. Une solution internet permettait la programmation dans le temps des dépistages et l'envoi à domicile. Le participant choisissait à l'inclusion dans l'étude la modalité de rendu des résultats selon que ceux-ci étaient tous négatifs ou non, entre un rendu par SMS, par téléphone, ou en face à face avec son médecin traitant ou en consultation au CeGIDD de son secteur. Lors du bilan initial réalisé sur les auto-prélèvements, la prévalence du VIH nouvellement diagnostiqué était de 0,5%, celle de l'hépatite C, de 0,3% [196]. Le taux de positivité était de 1,8% pour la syphilis, 11,2% pour *Neisseria gonorrhoeae* et 9,4 % pour *Chlamydia trachomatis*. Ces deux dernières IST ont été principalement retrouvées sur les auto-prélèvements oropharyngés et anaux. Au cours des 18 mois de suivi, parmi les 3 353 hommes, 1 755 ont réalisé au moins un dépistage du VIH en plus du dépistage initial et 1 040 au moins 2 dépistages. Les modalités choisies par les participants pour le dépistage du VIH étaient l'auto-prélèvement (55% des dépistages de suivi) et l'autotest VIH (35%) [175]. A noter que la proposition du kit complet d'auto-prélèvement IST à M12 a représenté un levier au recours au dépistage du VIH. Parmi les 3 180 hommes qui ne se dépistaient pas de façon trimestrielle avant l'étude, 76% avaient augmenté leur fréquence de dépistage et 30% avaient atteint le dépistage trimestriel [197].

Le déploiement d'outils numériques de programmation et de rappel des dépistages est intéressant pour soutenir le dépistage régulier des populations les plus exposées.

Pour l'instant, l'offre de dépistage du VIH par auto-prélèvements à domicile reste expérimentale en France et incluse dans un dépistage conjoint IST et éventuellement hépatites virales. Une réflexion devrait être menée sur une utilisation en complément des autres offres de dépistage. Il s'inscrit notamment comme un outil compatible avec l'action 11 de la stratégie nationale de santé sexuelle qui est de "renforcer l'accessibilité des CeGIDD grâce au déploiement de la téléconsultation" [54]. Les modalités de diffusion de ces kits pourraient être réfléchies en lien avec d'autres événements de la santé sexuelle et reproductive (par exemple, les pharmaciens pourraient disposer de kits d'auto-prélèvement à domicile pour le dépistage du VIH et des IST et les proposer lors de la délivrance d'une contraception d'urgence, de préservatifs gratuits etc…)

72. Le groupe d'experts est favorable à l'utilisation des kits d'auto-prélèvement à domicile pour un dépistage combiné du VIH, des hépatites B et C et des IST bactériennes, sur le modèle de l'étude Mémo-Dépistages qui a montré l'intérêt de ces kits pour un dépistage très régulier d'un public HSH très au fait de la prévention. (B)

73. Une évaluation de sa mise en œuvre dans différents contextes est recommandée, notamment pour identifier les éléments clés de son acceptabilité et mettre au point des offres qui puissent être déployées. (AE)

2.4.3. La notification aux partenaires

La notification aux partenaires est définie comme l'ensemble des actions visant à informer le ou les partenaires qu'ils ont pu être exposés à un risque de transmission du VIH, des hépatites ou de toute autre IST par voie sexuelle ou par partage de matériel d'injection, à les conseiller et à leur proposer un dépistage et une prise en charge. Il s'agit du processus par lequel les partenaires d'un patient index sont identifiés, informés de leur exposition et incités à consulter pour bénéficier d'un dépistage, d'un accompagnement et, si nécessaire, d'un traitement approprié [198].

Mise en œuvre depuis plusieurs années dans les pays anglo-saxons, et plus récemment aux Pays-Bas, le concept de la notification aux partenaires infuse en France progressivement avec un avis favorable du CNS en 2018 [199], des recherches interventionnelles qui peinent sur le plan réglementaire à se mettre en œuvre, des initiatives associatives, locales et depuis février 2023 des recommandations de la HAS [198].

Dans le cadre du VIH, la notification aux partenaires revient à une incitation au dépistage des partenaires. Elle représente également une opportunité de dépister d'autres IST et de délivrer aux patients index et aux partenaires des messages adaptés de prévention. Le principal avantage est pour le partenaire : bénéficier d'un traitement approprié, peut-être plus précocement s'il a contracté le VIH, ou d'une proposition de PrEP s'il est négatif.

D'un point de vue de santé publique, la notification aux partenaires contribue à limiter les épidémies en cassant les chaînes de transmission. En effet, en identifiant et traitant rapidement les personnes atteintes, elle limite les transmissions secondaires.

Les recommandations de la HAS en matière de notification aux partenaires sont récentes et se basent sur la littérature existante et les recommandations publiées dans les autres pays [83, 200–202]. L'encadré 3 reprend les principales recommandations de la HAS en insistant sur certains points jugés importants par le groupe d'experts.

Encadré 3 : Principales recommandations de la HAS à propos de la notification aux partenaires en cas de diagnostic de VIH, dans le cadre législatif actuel (seule la personne qui reçoit le diagnostic peut notifier à ses partenaires)

La notification aux partenaires doit être systématiquement proposée aux personnes qui reçoivent un diagnostic de VIH.

Elle doit être proposée sans délai lorsqu'un caractère d'urgence est relevé : possibilité de proposer un traitement post exposition au(x) partenaire(s), si le partenaire est une femme enceinte ou allaitante, ou lors du diagnostic du patient index au stade de primo-infection.

Le patient index doit être informé, conseillé, accompagné et encouragé dans sa démarche de notification. En cas de besoin, une consultation tripartite (patient index - partenaire - médecin) peut permettre de réaliser la notification du partenaire par le patient index, assistée par le médecin.

Pour une infection aiguë, la période recommandée pour rechercher les partenaires exposés est de 3 mois. Sinon, il est recommandé de remonter jusqu'à la date du dernier test négatif. Si cette date est inconnue, ou s'il n'y a pas de test antérieur, il est recommandé de prévenir tous les partenaires identifiables.

Le choix de la / des modalité(s) de notification aux partenaires doit tenir compte de la situation entre le patient index et ses partenaires (type de relation, contexte social, inégalités sociales de genre, de santé, ….).

Le groupe d'experts suit les recommandations de la HAS notamment sur le fait que la démarche de notification aux partenaires doit s'inscrire dans une offre globale de santé sexuelle. Elle doit s'accompagner de messages clairs, non équivoques, constants, adaptés aux cultures et niveau de littératie des populations cibles. Comme l'indique également la HAS, il est indispensable que l'ensemble des acteurs de la santé sexuelle reçoive une information claire et des formations. Cela facilitera l'acceptabilité de la démarche de notification aux partenaires par les patients index et les partenaires notifiés. Sans accès au dépistage des partenaires notifiés, l'efficacité de la démarche reste limitée, et la charge demandée aux patients index, démesurée.

Dans le cadre législatif actuel, la notification aux partenaires ne peut être réalisée que par la personne qui reçoit le diagnostic d'IST (le patient index). Un professionnel de santé ou un conseiller œuvrant dans le champ de la santé sexuelle ne peut pas notifier aux partenaires, même à la demande du patient index. Pourtant cette modalité a été montrée efficace dans d'autres pays pour augmenter le nombre de partenaires informés et faciliter l'accès de ces partenaires au dépistage [203, 204].

Les recommandations ci-dessus vont faciliter la notification des partenaires actuels, principalement du partenaire principal. En revanche, pour les personnes qui ont beaucoup de partenaires ou des partenaires exposés anciens, il est indispensable de leur fournir des outils pour faciliter la notification, et de faire évoluer le cadre législatif pour partager la charge de notification avec un professionnel de santé ou un conseiller formé à la notification aux partenaires.

Plusieurs sites ou applications permettant la notification aux partenaires par l'envoi d'un message standardisé anonyme ont été développés ces derniers mois. Ils permettent la notification aux partenaires dont le numéro de téléphone est connu. Ces outils doivent être évalués à moyen termes pour s'assurer qu'ils correspondent aux besoins des usagers. La notification d'une IST ou du VIH aux partenaires doit pouvoir se faire anonymement, afin de limiter les barrières pour le patient index. Cependant, il s'est avéré qu'une notification anonyme génère plus de stress chez les partenaires

notifiés [205] et est moins efficace pour que les partenaires accèdent au dépistage [204]. Le message doit renvoyer le partenaire notifié vers de l'information sur la notification aux partenaires et le dépistage. Il doit aussi indiquer le numéro de Sida Info Service ou d'une autre association où le partenaire pourra obtenir du soutien.

La notification aux partenaires est limitée à la nécessité de voir la personne ou d'avoir ses coordonnées téléphoniques. Des outils, fiables et sécurisés garantissant la confidentialité devraient être développés, puis évalués, pour faciliter la notification aux partenaires rencontrés sur les sites et applications de rencontres.

La démarche, même si elle doit être proposée à tous, rapidement après le diagnostic, doit rester volontaire.

74. Si, dans l'état actuel de la loi, seul le patient index peut notifier à ses partenaires, l'ensemble des acteurs de santé ou communautaires impliqués dans la prise en charge d'un diagnostic ou d'une orientation diagnostique, doivent l'accompagner dans la démarche de notification. (AE)

75. Le groupe d'experts est favorable à la proposition systématique de la notification aux partenaires lors d'un diagnostic d'IST, incluse dans une prise en charge (soins et prévention) globale. Cette proposition doit être accompagnée d'outils pour aider la personne qui reçoit le diagnostic à recenser ses partenaires exposés et les informer. (B)

76. Le groupe d'experts est en faveur de poursuivre les recherches pour identifier des interventions et des outils permettant de faciliter la notification aux partenaires par les patients index et le recours des partenaires au dépistage, adaptés aux modes de vie, aux cultures, aux niveaux de littératie des populations cibles. (AE)

77. Le groupe d'experts est en faveur d'une évolution de la loi sur le secret professionnel afin de permettre la notification des partenaires par un professionnel de santé ou un conseiller formés, à la demande et avec le consentement explicite du patient index. (A)

2.4.4. Promotion du dépistage

Les campagnes institutionnelles d'information et de promotion du dépistage du VIH sont créées et diffusées par Santé publique France. Depuis plusieurs années, il s'agit de campagnes généralistes informant sur la diversité des offres de dépistage, déclinées avec des visuels ciblant certaines populations (HSH, personnes d'origine africaine, jeunes ou couples hétérosexuels d'une cinquante d'années). Malgré cela, beaucoup de personnes ne connaissent pas certaines offres comme l'autotest VIH ou VIHTest.

Cas particulier de la semaine du dépistage :

La première opération type "semaine du dépistage" en France a été l'opération Flash test menée du 2 au 8 avril 2012 en Ile-de-France [206]. L'intérêt de ce type d'opération est la coordination de différents acteurs du soin, du dépistage, de la santé communautaire pour sensibiliser les publics au dépistage du VIH, faire connaître les offres et augmenter l'accessibilité et la couverture de dépistage.

Depuis 2013, le collectif Eurotest met en œuvre une semaine européenne du dépistage du VIH, fin novembre de chaque année. Plus de 700 organisations y participent dans une cinquantaine de pays

chaque année [207]. Toutefois, cet évènement est peu relayé en France. Depuis 2018, les dépistages des hépatites B et C et des IST bactériennes pour certaines populations clés ont été intégrés à la semaine européenne du dépistage [208]. C'est une opportunité de toucher un public plus large, aussi bien au niveau local que national [207–210].

Encouragée par la première feuille de route 2018-2020 de la SNSS [81], la semaine du dépistage a été lancée en 2019 en France : 1048 actions de dépistage, 184 lieux de dépistage et 25 834 personnes ayant réalisé un test de dépistage. Les taux de positivité de ces dépistages étaient de 2,0/1000 pour le VIH, 10,5/1000 pour le VHC, 15,7/1000 pour le VHB, 6,4/1000 pour la syphilis, 16,7/1000 pour les gonococcies, et 53,6/1000 pour les chlamydioses [54].

En France comme en Europe, chaque semaine de dépistage a permis une augmentation, au moins ponctuelle, du nombre de dépistage du VIH réalisés [206–210]. Cependant, il y a peu d'évaluation de l'impact de la campagne d'information associée. Par exemple, il a été montré que la semaine européenne du dépistage mise en œuvre à Amsterdam en 2016 a plus touché les personnes dépistées peu de temps avant ou déjà séropositives [209]. Il est donc important de bien cibler la communication et multiplier les supports de communication et les structures offrant le dépistage pour toucher un public le plus varié possible (structures de soins, hôpitaux, CeGIDD, associations, médecine étudiante …)

La seconde feuille de route (2021-2024) de la SNSS a proposé d'élargir la semaine du dépistage en semaine de santé sexuelle, ce qui a été mis en place dès 2022 [54].

78. La semaine du dépistage pourrait être distinguée de la semaine de la santé sexuelle, afin de pouvoir mettre en avant le dépistage au moins une fois par an en proposant des actions coordonnées de dépistage conjoint du VIH, des hépatites virales et des IST, en facilitant la proposition de dépistage par les médecins libéraux et les médecins hospitaliers et en prévoyant des actions vers des populations moins ciblées par les actions au long de l'année. Ces propositions de dépistage devraient être accompagnées d'une communication adaptée, pour favoriser une meilleure connaissance des outils de dépistage existants par la population. (AE)

79. La semaine du dépistage pourrait être organisée en même temps que la semaine européenne du dépistage (fin novembre) pour profiter de la mobilisation européenne et de l'écho de la journée mondiale du sida dans les médias généralistes et pour homogénéiser les messages notamment à destination des populations exposées qui fréquentent les lieux de convivialité internationaux. (AE)

2.5. Conditions de réalisation du dépistage et accompagnement

L'OMS recommande que tout dépistage du VIH suive la règle des 5C: Consentement de la personne testée, Confidentialité, Counseling pré- et post-test, résultat Correct et Connexion (accès) aux soins [83]. Le dépistage ne doit pas être obligatoire ou réalisé sous la contrainte. Les personnes testées ne doivent subir de discrimination ou de stigmatisation d'aucune sorte, qu'elles soient séropositives ou appartiennent à des populations clés.

Le dépistage du VIH s'accompagne d'un entretien avant le dépistage (pré-test) pour informer la personne de la réalisation du test, et après le test (post-test) pour interpréter le résultat dans la situation

de vie de la personne et l'orienter vers les services appropriés le cas échéant. L'entretien prend souvent la forme d'un counseling (encadré 4).

Encadré 4 : L'approche du counseling

Le counseling est un entretien avec une approche centrée sur la personne. Le conseiller doit avoir un regard positif inconditionnel, de l'empathie et de la congruence, sans aucune forme de jugement. Le counseling doit être mené avec un minimum d'asymétrie entre le conseiller et la personne reçue, afin d'établir un climat de confiance, et améliorer l'estime de soi.

Le counseling pré-dépistage, permet de définir les pré-acquis en matière de santé sexuelle, d'identifier les besoins réels en santé sexuelle et d'obtenir un consentement éclairé. L'écoute active est facilitatrice pour obtenir tout ceci. Il permet ensuite d'améliorer les connaissances de la personne reçue en santé sexuelle.

Le counseling post-dépistage, en cas de test négatif, permet d'assister la personne dans ses choix en santé sexuelle et en prévention.

Le counseling post-dépistage, en cas de test positif, permet d'accompagner la personne dans l'annonce du résultat et d'évaluer la compréhension du diagnostic. Il permet aussi de l'assister dans ses choix pour la prise en soin.

2.5.1. Information pré-test et consentement

Pour la réalisation d'un dépistage du VIH, la personne doit être informée de la réalisation de ce test pour y consentir de façon libre et éclairée [75].

Une littérature abondante, notamment dans les pays anglo-saxons, met en avant les stratégies de dépistage avec consentement implicite (opt-out) pour faciliter l'accès au dépistage du VIH en population générale dans le cadre des soins primaires et notamment dans les services d'urgence [211–213]. Une méta-analyse des études réalisées dans les services d'urgence montrent que le consentement explicite est un frein à la réalisation du test (19% versus 44% dans les études avec consentement opt-out) [214]. L'approche opt-out faciliterait également la proposition du dépistage par les professionnels de santé [215].

Depuis 2006, le CDC américain (Center for Disease Control and Prevention) recommande une approche opt-out pour le dépistage proposé en routine dans le système de soins aux personnes âgées de 13 à 64 ans [216]. Dès 2007, l'OMS recommande que les professionnels de santé proposent un dépistage du VIH en opt-out lorsque : (1) le patient présente une pathologie évocatrice de l'infection à VIH ; (2) à toutes les personnes qui se présentent dans un service de soins dans les zones de forte prévalence ; (3) de façon plus ciblée, à des personnes qui se présentent dans un service de soins dans les zones de faible prévalence [217]. Dans les dernières recommandations de 2019, l'OMS précise simplement que toute personne doit recevoir une information concise sur le dépistage du VIH pour avoir l'opportunité de le refuser [83].

Les recommandations françaises de la HAS en matière de dépistage du VIH (2017 [32]) font mention qu' « une partie des experts du groupe de travail est favorable à une mise en œuvre en opt-out de la proposition de dépistage (notification que le test sera réalisé sauf si le patient s'y oppose), notamment

dans les services hospitaliers, afin de faciliter l'accès au dépistage de l'infection à VIH et de le banaliser comme le dépistage d'autres maladies infectieuses. » Sans consensus sur ce point, aucune recommandation n'avait été émise.

En 2021, le Royaume-Uni propose une approche opt-out pour la proposition du dépistage du VIH et des hépatites virales dans les zones de forte prévalence. Une expérimentation a été menée dans 33 services d'urgence et de premier recours de 4 grandes villes. Une telle approche est efficace en termes de dépistages réalisés, de nouveaux diagnostics et d'identification de personnes qui connaissaient leur statut mais qui n'étaient pas suivies. Ces personnes diagnostiquées ou retestées positives sont le plus souvent à un stade tardif de l'infection à VIH (CD4 < 350/µL). L'éditorial du Lancet dans lequel cette étude est rapportée conclut que la stratégie opt-out est coût-efficace [212].

Un entretien pré-test prolongé est un frein pour les personnes qui réalisent des dépistages du VIH plusieurs fois par an [218]. Ces personnes préfèrent les tests réalisés en autonomie comme l'autotest VIH ou l'auto-prélèvement à domicile [166, 175].

Une des barrières à la proposition du dépistage par le personnel de santé est le fait d'aborder la sexualité [92, 219]. Limiter l'entretien pré-test à une information minimale concise centrée sur le test et le résultat permet de lever cette barrière. Pour certains usagers, exposer leur sexualité est également un frein au dépistage. L'absence de counseling peut donc faciliter l'accès au dépistage des personnes moins à l'aise avec leur sexualité, comme dans l'expérimentation « Au labo sans ordo » qui a attiré plus d'hommes hétérosexuels multipartenaires que d'autres offres de dépistage [139].

Dans les recommandations internationales (OMS, ECDC, IUSTI), toutes s'accordent sur le fait de présenter les conditions du dépistage (caractère volontaire, confidentiel, la procédure, le rendu de résultat, pourquoi se faire dépister). En revanche, préparer la personne au résultat et à ce qu'il implique n'est pas systématiquement retrouvé ou de façon hétérogène [220].

Dans ces recommandations de 2019 [83], l'OMS conseille d'aborder:

- les avantages du dépistage et disponibilité des moyens de prévention et des traitements ;
- la pertinence de réaliser d'autres dépistages ;
- la possibilité de poser des questions.

La variété d'offres de dépistage, allant de l'autotest au dépistage communautaire, permet à la personne qui souhaite réaliser un dépistage de choisir une offre où elle pourra bénéficier ou non d'un counseling pré-test adapté à sa situation et son exposition au VIH. Quoi qu'il en soit, une information minimale concise, orale ou écrite [221], est nécessaire.

80. Avant la réalisation d'un dépistage du VIH, une information minimale concise, orale ou écrite, doit être délivrée à la personne. Elle doit présenter la procédure de dépistage et préparer la personne au résultat en évoquant les moyens de prévention et l'existence des traitements. (AE)

81. Dans les services de soins, primaires ou spécialisés, afin de faciliter la proposition d'un dépistage du VIH - et si cela est adéquat, la proposition d'un dépistage conjoint du VIH, des hépatites B et C et des IST bactériennes - le groupe d'experts est favorable à l'approche opt-out, c'est-à-dire avec consentement implicite. Dans ce cas, une information minimale sur le dépistage doit être fournie à la personne pour qu'elle puisse comprendre l'importance du test et avoir l'opportunité de le refuser. En aucun cas, sa décision ne devra avoir de répercussions sur la qualité des soins qu'elle recevra. (B)

82. Lorsque qu'un dépistage du VIH est réalisé avec cette approche opt-out, le résultat du test, même négatif, devra être rendu oralement par un médecin ou une personne désignée par lui. (AE)

2.5.2. Information post-test et accès aux soins des personnes recevant un résultat positif

Un accès rapide aux soins spécialisés après la découverte d'une infection par le VIH est crucial pour optimiser l'efficacité du traitement (Cf. chapitre « Initiation d'un premier traitement antirétroviral chez l'adulte vivant avec le VIH »). Une méta-analyse d'études européennes publiées entre 2005 et 2017 a estimé que 85% des personnes nouvellement diagnostiquées accédaient aux soins dans les 3 mois suivant le diagnostic [222]. Les facteurs associés à un accès aux soins tardif ou inexistant étaient le fait d'avoir acquis le VIH par voie hétérosexuelle ou par usage de drogues injectables, être plus jeune, avoir un niveau d'éducation plus faible et ne pas se sentir malade au moment du diagnostic. Le fait d'être diagnostiqué dans une clinique IST favorisait le lien aux soins. En France, le délai médian de prise en charge est court, de l'ordre d'une dizaine de jours [33, 223].

Le counseling post-test est un moment clé pour faciliter le lien aux soins des personnes recevant un diagnostic de VIH. L'OMS le recommande court et concis [83]; les messages principaux sont:

- le bénéfice individuel pour la santé du traitement ARV précoce ;
- le fait d'atteindre et de maintenir une charge virale contrôlée permet de pas transmettre le VIH aux partenaires ;
- l'incitation à notifier aux partenaires.

83. L'ensemble des problèmes psychologiques, sociaux et financiers de la personne doivent être pris en compte dans l'orientation de la personne vers le soin. (B)

84. L'orientation vers le service spécialisé doit être facilitée par la prise d'un rendez-vous par le professionnel de dépistage dans un centre choisi par le patient, ou en faisant appel au service de navigation proposé par le COREVIH / CoReSS ou Sida Info Service selon les territoires. Selon les possibilités, un accompagnement physique au premier rendez-vous par un médiateur en santé ou un intervenant communautaire peut être proposé. (AE)

85. Dans tous les cas, pour une bonne adhésion aux soins, les besoins fondamentaux de la personne doivent être pris en compte. La prise en soins doit être expliquée et la compréhension des différentes étapes du suivi doit être vérifiée. Un accompagnement par un médiateur en santé ou un intervenant communautaire peut être proposé. (AE)

2.5.3. Information post-test et accès à la prévention des personnes recevant un résultat négatif

L'entretien post-test pour la remise d'un résultat négatif est également un moment important car il permet l'interprétation du résultat du test au regard de la situation et de l'exposition de la personne. Il

offre l'opportunité aux personnes exposées au VIH d'accéder à une prévention adaptée et notamment à la PrEP, à d'autres dépistages et de leur rappeler l'intérêt de répéter le dépistage du VIH.

Pour ce faire, la remise du résultat doit se faire oralement, en face à face, lors d'une téléconsultation ou au téléphone. Dans ce dernier cas, il faudra s'assurer que la personne est dans de bonnes conditions d'écoute et de confidentialité. Pour des personnes qui réalisent des dépistages très régulièrement, et déjà très au fait des outils de prévention (personnes utilisant la PrEP par exemple), il est possible d'envisager des moyens de rendu de résultats dématérialisés, sur un site internet sécurisé par exemple. Dans tous les cas, une information écrite reprenant les conditions d'interprétation du test, rappelant la fréquence de dépistage recommandée et comment accéder à la prévention doit accompagner le résultat. Un numéro de téléphone accessible sur une large plage horaire doit être indiqué pour que la personne puisse poser des questions.

Dans les centres de soins, les CeGIDD ou les centres de santé sexuelle, la proposition de PrEP peut être immédiate. Dans le cas contraire, une orientation vers un service spécifique peut être proposée. Dans tous les cas, pour une bonne adhésion à la PrEP, les besoins fondamentaux de la personne doivent être pris en compte. La prise en soins doit être expliquée et la compréhension des différentes étapes du suivi doit être vérifiée. Un accompagnement par un pair ou un médiateur en santé peut être proposé.

86. Pour des personnes qui réalisent des dépistages très régulièrement, et qui ont une bonne connaissance des outils de prévention, des moyens dématérialisés pour le rendu des résultats négatifs sont envisageables. Une information écrite reprenant les conditions d'interprétation du test et comment accéder à la prévention doit accompagner le résultat. Un numéro de téléphone accessible sur une large plage horaire doit être indiqué pour que la personne puisse poser des questions. (AE)

2.5.4. Accompagnement, médiation en santé

La capacité à prendre soin de sa santé dépend étroitement des situations sociales, des conditions de logement, de la compréhension du système de santé et des messages qui y sont délivrés. Plusieurs travaux ont montré en particulier que le fait de ne pas avoir de logement stable ou de titre de séjour augmentait le risque d'infection par le VIH, mais aussi l'exposition aux violences sexuelles [8, 72]. Il est donc indispensable d'avoir une approche globale, qui prenne en compte l'ensemble des besoins de la personne, et cela en particulier pour les personnes qui vivent en situation de précarité. Cela implique des liens entre les services de santé et les acteurs sociaux, acteurs publics ou associations. Le rôle des médiateurs de santé est primordial. Leur rôle est justement de créer des interfaces entre les différents acteurs du système de santé et les personnes en difficulté dans leurs parcours de soin et de prévention, en prenant en compte leur environnement de vie [224]. Le métier de médiateur en santé est un nouveau métier, il est de plus en plus reconnu comme indispensable dans les services qui en bénéficient, mais l'enjeu aujourd'hui est que ce métier soit pérennisé, intégré au droit commun, et sorte de son statut « expérimental ».

87. La profession de médiateur de santé doit être pérennisée et intégrée au droit commun. (AE)

2.6. Approche populationnelle

> Cette partie présente, pour la population générale et par population clé, les recommandations de dépistage pour le VIH, les hépatites virales et les IST bactériennes formulées par le groupe d'experts et reprises d'autres instances, notamment de la Haute autorité de santé (HAS 2017[2]) en ce qui concerne les fréquentes de dépistage du VIH. Elle est reprise dans le chapitre « Epidémiologie, diagnostic et prévention des infections sexuellement transmissibles »

L'épidémiologie du VIH et des IST bactériennes est détaillée respectivement dans le chapitre « Epidémiologie et déterminants sociaux de l'infection par le VIH » et « Epidémiologie, diagnostic et prévention des infections sexuellement transmissibles » du présent rapport, pour la population générale et les populations clés. Les paragraphes ci-dessous reprennent les grands points soutenant les recommandations de dépistage pour chaque population. Certaines recommandations sont justifiées dans l'argumentaire concernant les offres de dépistage du VIH ou les conditions de réalisation d'un dépistage du VIH (cf supra) ou dans le chapitre « Epidémiologie, diagnostic et prévention des infections sexuellement transmissibles ».

D'une manière générale,

88. Il convient d'augmenter les connaissances de la population sur le VIH, les hépatites virales et les IST bactériennes, notamment sur les modes de transmission, les moyens de se protéger et les lieux où se faire dépister en adaptant les messages au niveau de littératie des populations cibles. (AE)

89. Chaque contact avec le soin doit pouvoir représenter une opportunité de recevoir une proposition de dépistage. (AE)

90. Quelle que soit la population, chaque diagnostic d'infection à VIH ou d'IST bactérienne doit être expliqué, accompagné d'une prise en soin adaptée et de conseils de prévention. La démarche de notification aux partenaires doit systématiquement être présentée à la personne avec, dans la mesure du possible, une assistance à l'identification des partenaires exposés et à la notification du VIH / de l'IST aux partenaires. (AE)

Rappelons que chacune des populations clés ne constitue pas un groupe homogène, compte-tenu de facteurs comportementaux, sociaux ou autres qui diffèrent au sein de ces populations.

Rappelons également que l'homophobie, la transphobie, la sérophobie, et toutes les formes de stigmatisation limitent les capacités des personnes exposées de prendre soin d'elles et de leur santé.

2.6.1. Population générale

La prévalence du VIH dans la population générale est faible [225]. Toutefois, la proportion de diagnostics de VIH à un stade avancé de la maladie reste élevée (autour de 30% ces dix dernières années, [70, 226])

[2] Haute Autorité de Santé. Réévaluation de la stratégie de dépistage de l'infection à VIH en France. 2017. https://www.has-sante.fr/jcms/c_2024411/fr/reevaluation-de-la-strategie-de-depistage-de-l-infection-a-vih-en-france

et les délais estimés entre infection et diagnostic sont longs, en particulier chez les hommes hétérosexuels (>2,5 ans [33, 70]). Plusieurs études rapportent des taux élevés d'opportunités manquées de dépistage dans le système de soins, quelle que soit la population étudiée [88, 89, 98]. Les symptômes pouvant évoquer le VIH (au moment de la primo-infection, de la phase chronique ou du SIDA) et des maladies associées à une prévalence du VIH non diagnostiqué > 0,1% sont aujourd'hui bien définis (cf. Encadré 1).

Concernant les IST bactériennes, leur prévalence en population générale augmente, en particulier chez les moins de 25 ans en Europe [227], et dans l'ensemble des groupes de population en France, (sous-chapitre « Epidémiologie des IST »).

L'accès aux outils de dépistage a fait l'objet de nouvelles mesures de gratuité : accès sans frais sur simple demande dans les laboratoires de biologie médicale au dépistage du VIH (VIHTest, [80]) en 2022 et des IST pour les personnes de moins de 26 ans (Mon test IST, [228, 229]) en 2024.

91. L'ensemble des offres de dépistage, du VIH et des IST bactériennes doivent être accessibles universellement, et pour Mon test IST, au-delà de 26 ans révolus, afin de positionner cette offre dans une démarche globale de santé sexuelle. Toutefois, des incitations à engager une démarche de dépistage doivent être pensées dans une logique d'universalisme proportionné, ciblant prioritairement les personnes les plus concernées. (AE)

92. Pour le VIH et quand c'est possible et adéquat, pour les hépatites virales B et C et les IST bactériennes, il convient de favoriser toutes les opportunités de dépistage, surtout si la personne :

- n'a jamais réalisé de test ;
- est un homme ;
- réside dans un bassin de population plus concerné par les inégalités sociales de santé ;
- réside dans un territoire ultramarin. (C)

93. Parmi les opportunités de dépistage, tout contact avec le soin primaire ou les urgences doit être une occasion, notamment lorsque la personne présente une indication (clinique ou appartenance à un groupe à risque) ou n'a jamais réalisé de dépistage. Dans ce cas, la proposition de dépistage peut être faite en opt-out (consentement implicite). Le résultat devra alors être rendu oralement. (C)

94. Lorsque la personne présente des symptômes pouvant évoquer une primo-infection VIH, un dépistage du VIH doit systématiquement lui être proposé. Il doit reposer si possible sur un test ELISA de 4e génération ainsi qu'une quantification de l'ARN VIH-1 dès le 1er prélèvement. (A)

95. Lorsque la personne présente des symptômes évocateurs de la phase chronique de l'infection à VIH ou des maladies fréquemment associées au VIH, un dépistage du VIH doit systématiquement lui être proposé. Parmi ces conditions indicatrices : IST, hépatites virales, tuberculose, lymphomes malins, dysplasie / cancer anal ou cervical, zona, syndrome mononucléosique, leucocytopénie ou thrombopénie > 4 semaines non expliquées, dermite séborrhéique / exanthème (cf. Annexe). (C)

96. Aux femmes, il est recommandé de proposer un dépistage combiné du VIH, des hépatites B et C et IST bactériennes à l'occasion d'une grossesse, d'un projet de grossesse, d'une contraception ou d'une interruption volontaire de grossesse. (AE)

97. Une proposition systématique du même dépistage combiné du VIH, VHB, VHC et IST bactériennes doit être faite aux futurs pères, a fortiori auprès des populations et dans les territoires de plus forte prévalence. (AE)

2.6.2. Les mineurs

La moitié des adolescents a eu son premier rapport sexuel avant ses 18 ans. Celui-ci intervient avant 15 ans pour 8% des femmes et 10% des hommes. La proportion de rapports très précoces (avant 13 ans) reste marginale et n'a pas évolué au cours des 10 dernières années [230].

Les données concernant l'épidémiologie des IST auprès des mineurs sont rares et difficiles à produire en raison des restrictions qui s'appliquent à leur accès aux services de dépistage et pour leur inclusion dans des recherches. Les données de prévalence en population générale et les données de surveillance attirent toutefois l'attention sur un portage de *Chlamydia trachomatis* (CT) important parmi les plus jeunes (chapitre « Epidémiologie des IST »). Des études menées à la Réunion en CeGIDD soulignent les taux de positivité des mineurs consultant dans ces centres aux infections urogénitales à CT (de l'ordre de 13,2%) [231].

Les mineurs de moins de 18 ans peuvent consulter seuls et une dérogation à l'autorisation parentale peut être réalisée si le patient en fait la demande pour qu'il reçoive des informations ou des conseils relatifs à la santé sexuelle (articles L.1111-5 et L1111-5-1 du Code de la santé publique). Pour se voir délivrer une ordonnance pour un dépistage ou pour la réalisation d'un examen, ils doivent cependant être accompagnés d'un adulte de confiance, même si ce dernier n'a pas l'autorité parentale. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu de consultation. C'est la qualification du professionnel et non la structure accueillante qui permet cette dérogation à l'autorité parentale. Ainsi, cette disposition n'a pu être appliquée aux dépistages du VIH et des IST sans ordonnance en laboratoire, les biologistes n'étant pas autorisés à déroger à l'autorisation parentale.

Le niveau de connaissance des mesures adoptées au cours de la dernière décennie en termes de dépistage et de prévention du VIH et des autres IST (possibilité d'achat de l'autotest VIH, dépistage du VIH et maintenant des IST en laboratoire sans ordonnance ni avance de frais, gratuité et prescription des préservatifs, …) est toutefois inconnu dans cette population.

98. Les mineurs doivent pouvoir bénéficier de la même qualité de soin que les majeurs. (AE)

99. Le groupe d'expert conseille de faciliter l'accès au dépistage du VIH et des IST bactériennes sans autorisation du tuteur légal aux mineurs de 15 ans et plus, notamment dans le cadre des dispositifs VIHTest et Mon test IST permettant le dépistage sans ordonnance et sans frais du VIH, du VHB et des IST bactériennes en laboratoire de biologie médicale. (AE)

100. A la suite d'un dépistage, le groupe d'experts est en faveur d'une exception au consentement parental pour la proposition des vaccinations aux mineurs susceptibles d'être

exposés (VHA, VHB, HPV, Mpox, …) ainsi que pour la proposition de la PrEP, notamment en CeGIDD. (AE)

Dans le cas de ces deux recommandations, le mineur pourra être assisté d'un adulte de confiance choisi par lui et l'information qu'il recevra devra être adaptée pour éclairer sa décision.

101. Il est indispensable d'intégrer dans les enquêtes menées auprès des mineurs, des items sur les connaissances des dispositions d'accès aux soins et aux services de prévention les concernant (gratuité des préservatifs, recours aux dépistages, …) (AE)

2.6.3. HSH

La population HSH se caractérise par une probabilité importante de multipartenariat, que l'on considère les partenaires successifs ou simultanés. En 2019, plus d'un homme sur deux ayant répondu à l'enquête ERAS déclarait avoir eu deux partenaires ou plus au cours des six derniers mois. Ils étaient 32% à en avoir déclaré 5 ou plus [232].

Bien que l'incidence du VIH et le nombre de diagnostics baissent depuis 10 ans chez les HSH nés en France, ces indicateurs restent à des niveaux élevés (> 1500 cas par an, [226]). Le nombre de diagnostics chez les HSH nés à l'étranger augmente chaque année. D'après les estimations réalisées par Santé publique France à partir des données de surveillance 2023, 55% des HSH nés à l'étranger ont acquis le VIH en France [226]. Parmi les HSH nés à l'étranger primo-arrivants, le risque d'acquisition du VIH est plus élevé la première année sur le territoire français, notamment lorsqu'ils ont des conditions de vie précaires et beaucoup de partenaires sexuels [71].

Les HSH sont particulièrement touchés par les IST. Entre 2000 et 2016, une augmentation du nombre d'infections à *Neisseria gonorrhae* (NG), de syphilis et de lymphogranulomatoses vénériennes (LGV) a été observée plus spécifiquement chez les HSH. Le diagnostic de ces IST concerne le plus souvent les HSH que les hétérosexuels (en particulier les hommes vivant avec le VIH et les hommes sous PrEP, populations qui bénéficient de dépistages réguliers dans leur suivi) [226]. Par ailleurs, cette population a été particulièrement touchée par l'épidémie de Mpox survenue en 2022. L'usage de la PrEP pour prévenir l'infection par le VIH continue de se diffuser dans cette population [5, 233]. Pour ces usagers de la PrEP, le recours au dépistage combiné est important, plus de la moitié d'entre eux déclarant réaliser les quatre dépistages annuels. En revanche, chez les personnes ne prenant pas de PrEP, le nombre de dépistages est moindre, même s'il reste plus important qu'en population générale [5]. L'objectif de dépistage trimestriel du VIH avec un dépistage conjoint du VHC, des infections à NG, CT et de la syphilis, mérite d'être soutenu dans la durée pour les HSH exposés.

102. Un dépistage trimestriel du VIH est recommandé aux HSH multipartenaires. (HAS 2017)

103. Le dépistage trimestriel du VIH et le dépistage régulier des IST doivent être soutenus par des systèmes de rappel ou de programmation des dépistages utilisant l'ensemble de l'offre de dépistage. L'accès aux offres de dépistage en autonomie (autotest VIH, auto-prélèvements à domicile s'ils deviennent disponibles) doit être facilité pour favoriser les dépistages répétés. (B)

104. Les offres de dépistage en autonomie et les offres de dépistage avec un counseling pré-test limité doivent être connues du grand public pour atteindre des personnes éloignées du dépistage, de la communauté gay ou ne se reconnaissant pas comme gay. Ils peuvent être un levier à l'accès au dépistage pour les personnes pour qui la sexualité ou le VIH sont des sujets complexes à aborder. (C)

105. Le groupe d'experts est favorable à l'utilisation des kits d'auto-prélèvement à domicile pour un dépistage combiné du VIH, des hépatites B et C et des IST bactériennes, sur le modèle de l'étude Mémo-Dépistages qui a montré l'intérêt de ces kits pour un dépistage très régulier d'un public HSH très au fait de la prévention. (B)

106. Il est indispensable que le rendu d'un résultat négatif (oralement ou par écrit) s'accompagne d'information sur la prévention et l'accès à la PrEP. (AE)

107. Les HSH nés à l'étranger doivent pourvoir bénéficier très tôt après leur arrivée en France, et de façon renouvelée, d'une proposition de dépistage trimestriel du VIH, des hépatites virales et des IST bactériennes ainsi que d'une offre de prévention adaptée à leur exposition (PrEP, TPE réduction des risques liés au chemsex, etc…). (AE)

108. L'usage des TROD syphilis peut être envisagé auprès de la population HSH ou auprès de populations réticentes à réaliser des dépistages en milieu médical. L'interprétation du résultat du TROD et l'orientation vers les soins sont facilitées lorsque les antécédents d'infection sont connus. (AE)

109. La prescription d'un dépistage du VIH ou d'une IST bactérienne doit être l'occasion d'une vérification du statut vaccinal et d'un éventuel rattrapage vaccinal contre les hépatites B et A, pour les HPV pour les HSH de moins de 26 ans et pour le Mpox selon la situation épidémiologique. (AE)

Rappelons que la population HSH est hétérogène. Certains hommes ne se reconnaissent pas dans les messages ciblant les HSH. Il est nécessaire de diffuser des messages de prévention et d'incitation au dépistage plus largement.

2.6.4. Les personnes prenant la PrEP

Le suivi et les recommandations de dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST bactériennes des personnes prenant la PrEP sont présentés dans le chapitre « Traitement préventif pré-exposition de l'infection par le VIH ».

2.6.5. Les personnes pratiquant le chemsex

Les personnes pratiquant le chemsex consomment des drogues (cathinones, GHB/GBL, MDMA, MDA, Crystal meth, kétamine, …) en contexte sexuel. Parmi elles, certaines s'injectent les produits psychoactifs (« slam »).

Depuis plusieurs années, une extension et une diffusion de ce phénomène ont été observées, touchant très majoritairement les HSH. Dans l'enquête ERAS réalisée auprès des HSH en 2023, la pratique du

chemsex au cours du dernier rapport sexuel s'élève à 6% en 2023 et à 13% au cours des 6 mois précédant l'enquête. Cette pratique concerne plus souvent des hommes âgés de 25-44 ans (15%), urbains (18%), chômeurs (21%), financièrement moins aisés (15%), séropositifs au VIH (33%) ou séronégatifs et usagers de la PrEP (26%). Ils sont également attachés aux sociabilités et aux valeurs de performances sexuelles gay. Ils sont plus souvent multipartenaires et utilisent moins systématiquement le préservatif lors des pénétrations anales avec des partenaires occasionnels [59]. La pratique du chemsex a des conséquences sanitaires en termes de dépendance, notamment aux produits consommés, de complications médicales, mais aussi de transmissions du VIH, du VHC et des autres IST, en raison des pratiques sexuelles et d'une baisse de la vigilance. Il faut donc apporter une prise en charge globale aux personnes engagées dans de telles pratiques et développer une réponse adaptée.

110. Il est recommandé aux personnes pratiquant le chemsex un dépistage au moins trimestriel du VIH, du VHC et des IST bactériennes. Ce dépistage peut être proposé de façon plus rapprochée en fonction de leur exposition. (AE)

111. La démarche de notification du VIH / des IST bactériennes aux partenaires doit être proposée systématiquement en cas de diagnostic. (AE)

112. Tous les soignants en contact avec les personnes pratiquant le chemsex (CAARUD, centre de santé sexuelle, CeGIDD, médecin généraliste, addictologue, …) doivent leur proposer la PrEP et les informer sur les modalités d'initiation, d'arrêt et de reprise de la PrEP. (B)

113. Une prise en charge pluridisciplinaire avec un accompagnement psychosocial doit être proposée à toute personne pratiquant le chemsex en difficulté avec sa consommation de produits. (C)

2.6.6. Les personnes usagères de drogues injectables (UDI, hors chemsex)

Bien que peu nombreuses, les personnes usagères de drogues injectables (UDI) sont touchées de façon disproportionnée par le VIH et surtout par le VHC. Alors que les usagers de drogues représentaient près d'un quart des cas de SIDA avant 1996 [227], leur part dans l'épidémie de VIH s'est réduite au fil du temps. En 2023, ils représentent 1% des découvertes de séropositivité. La moitié d'entre eux étaient des personnes nées en Europe [226]. Néanmoins, certains indicateurs (augmentation du partage du matériel d'injection, diagnostics tardifs de l'infection par le VIH et délais les plus élevés entre le diagnostic et l'accès aux soins retardant la mise sous ARV, etc.) montrent que la situation des UDI vis-à-vis du VIH reste préoccupante et que la vigilance nécessite d'être maintenue [33, 70, 228]. Les données concernant les IST pour cette population sont insuffisantes pour dessiner des conclusions spécifiques.

114. En plus des mesures de réduction des risques, un dépistage du VIH, des hépatites virales et si cela est adéquat, des IST bactériennes doit être proposé au moins une fois par an. (HAS 2017)

115. Les CAARUD et associations communautaires doivent avoir un rôle important dans la promotion du dépistage et de la prévention en santé sexuelle, notamment la PrEP, auprès de cette population. (AE)

116. Les actions de réduction des risques et de promotion de la santé auprès des personnes utilisant des drogues, ainsi que leurs mises à jour en fonction de l'évolution des usages et des populations, doivent être favorisées sans qu'il y soit fait obstacle par une politique répressive des usagers. (C)

2.6.7. Les personnes migrantes ou en situation de précarité

Les personnes en situation de migration, notamment lorsqu'elles sont nées en Afrique subsaharienne sont particulièrement concernées par le VIH [226]. Une partie de ces personnes acquièrent le VIH dans leur pays d'origine ou lors de la migration. Il a été estimé que 50% des hommes et 30% des femmes, séropositifs pour le VIH, nés en Afrique subsaharienne et résidant en Ile-de-France ont contracté le VIH une fois en France [72]. Chez les HSH nés à l'étranger, on estime que 62% d'entre eux ont acquis le VIH en France [71]. Des estimations récentes réalisées par Santé publique France sur les données de surveillance nationale sont concordantes avec ces résultats (42% des personnes nées à l'étranger et 55% des HSH nés à l'étranger ont contracté le VIH après l'arrivée en France [226]. Les conditions de précarité socio-économiques dans lesquelles ces personnes vivent dans les mois qui suivent leur arrivée les exposent particulièrement au VIH, aux IST bactériennes et aux violences [8]. Les actions de rue (gare, marché, …) permettent d'atteindre des populations migrantes, primo-arrivantes ou installées depuis quelques années mais vivant toujours dans des conditions de précarité importante [48]. Les associations communautaires telles que Afrique Avenir en Ile-de-France proposent du dépistage du VIH et des hépatites virales en « aller vers », dans les lieux de passage. L'étude ANRS Makasi, a montré qu'il était également faisable d'atteindre cette population dans des actions de rue pour délivrer une intervention d'empowerment en santé sexuelle. Grâce à cette intervention, des hommes et femmes, nés en Afrique subsaharienne et résidant en Ile de France dans des conditions de précarité, ont augmenté leur niveau de connaissance sur les outils biomédicaux de prévention du VIH et ont pu bénéficier d'une orientation vers des services sociaux ou de santé selon leurs besoins [10, 229]. Ces résultats soulignent le rôle central des acteurs communautaires auprès de cette population et l'importance d'une communication adaptée sur les outils de prévention biomédicale dont la connaissance doit être améliorée. Dans l'étude Makasi, seulement 5% des participants connaissaient la PrEP initialement et 6% le TPE. Ils étaient près de la moitié à ne pas connaitre l'effet du traitement comme moyen de prévention (TasP, U=U) et les bénéfices individuels d'avoir une charge virale indétectable lorsqu'on vit avec le VIH [10].

Les difficultés d'accès aux services de santé et de prévention pour les populations migrantes et déplacées constituent un déterminant de la réémergence des IST bactériennes en Europe [230]. En France, pour la population migrante, les données sur les IST bactériennes sont moins nombreuses que celles sur le VIH et sont principalement issues des centres de soins gratuits, donc d'une population particulièrement sélectionnée par sa précarité. L'analyse des dépistages réalisés au sein du centre d'accueil, de soins et d'orientation des personnes démunies de médecins du monde à Saint-Denis entre 2012 et 2016 mettait en évidence que, dans cette population majoritairement primo arrivante, les taux positivité des dépistages de CT et NG étaient plus élevés chez les hommes que chez les femmes (respectivement 7,3% et 2,0% vs 4,0% et 0,7%) [231]. Dans un CeGIDD hospitalier, au cours des années 2017 et 2018, les personnes migrantes avait un risque plus élevé que les personnes non migrantes de

présenter une infection à CT parmi les patients asymptomatiques. Ce surrisque était présent quelle que soit la durée depuis l'arrivée sur le territoire et concernait principalement les personnes multipartenaires, les HSH, les femmes et les plus jeunes [232]. Une analyse plus large des consultations en CeGIDD en 2020 mettait en évidence que ce surrisque ne se retrouvait pas systématiquement au niveau national : pour CT, la population migrante présentait des taux similaires à ceux de la population née en France. Pour NG et la syphilis, en revanche, les HSH nés à l'étranger étaient plus concernés (respectivement 8,2% et 2,4% contre 4,0% et 1,0% au global) [138].

117. Il est nécessaire de favoriser l'accès aux droits (travail, logement, santé). C'est un prérequis pour que les personnes migrantes ou précaires évitent de se trouver en situation d'exposition au VIH et aux autres IST. (C)

118. Les personnes migrantes hétérosexuelles, exposées au VIH et aux IST bactériennes, doivent pouvoir renouveler les dépistages du VIH et des IST bactériennes au moins tous les ans. (HAS 2017)

119. Les HSH migrants exposés au VIH et aux IST bactériennes, doivent pouvoir renouveler les dépistages du VIH et des IST bactériennes au moins tous les 3 mois. (HAS 2017)

120. Il est recommandé de maintenir et faciliter l'accès aux soins des personnes migrantes ou précaires pour permettre un dépistage et une prise en charge précoce de l'infection par le VIH et éviter des ruptures de soins ultérieures. (C)

121. Les offres de dépistage doivent être proposées en « aller vers », dans les lieux de vie (coiffeurs, foyers, associations, cultes, …) ou de passage (gares, marchés) car ces personnes, le plus souvent en situation de précarité, n'identifient pas la santé comme une priorité. Ces offres doivent assurer des espaces de confidentialité. (B)

122. Il serait utile que des médiateurs/médiatrices en santé, si possible parlant la langue des personnes cibles, soient impliquées dans les actions de prévention et de dépistage du VIH et des IST bactériennes pour faciliter la compréhension et orienter les personnes vers le soin ou la PrEP si nécessaire. (AE)

123. Les communications visant à promouvoir le dépistage, les offres d'accès à la prévention en santé sexuelle et les informations sur les stratégies biomédicales de prévention du VIH doivent être adaptées en termes de niveau de langage, de références culturelles et sociales, et de voies de diffusion à la population. (AE)

2.6.8. Les personnes transgenres

Le nombre de nouveaux diagnostics de VIH chez les personnes transgenres augmente fortement ces dernières années [226]. Cette augmentation pourrait être en partie liée à un meilleur référencement des cas déclarés. Toutefois, via des conditions de vie précaires, des expériences de discrimination, un isolement physique et/ou affectif, les personnes transgenres sont fortement exposées au VIH et aux IST bactériennes. Elles doivent pouvoir bénéficier d'une proposition de dépistage renouvelée et d'une offre de prévention adaptée.

D'une manière générale, les personnes transgenres rapportent des difficultés d'accès aux soins de santé sexuelle et des discriminations dans le système de soins qui impactent leurs recours aux soins [233]. Dans une thèse portant sur la santé des personnes transgenres en 2021 et s'appuyant sur un questionnaire en ligne, une expérience de discrimination en milieu de soin était rapportée par près d'une personne sur deux. La crainte d'une discrimination concernait les trois quarts des répondants et un changement de professionnel de santé avait été nécessaire pour deux tiers d'entre eux [234].

L'absence de prise en charge ou le recours tardif aux soins de santé globale, et en particulier de santé sexuelle, accentue les risques de complications. C'est par exemple le cas du cancer du col chez les hommes transgenres ayant un utérus. D'après Peitzmeier et al., les hommes transgenres ont une probabilité 8,3 fois supérieure à celle des femmes cisgenres de présenter un frottis cervico-vaginal anormal [235]. Ils ne peuvent pas bénéficier des programmes de dépistage organisé des lésions liées aux HPV ; leur recours au dépistage repose donc sur une démarche individuelle pouvant être limitée par des freins d'ordre financier, organisationnel (salle d'attente féminine, inconfort du prélèvement) et intégrant les discriminations vécues et la crainte de leur reproduction [236]. La survenue de lésions causées par HPV a également été documentée chez des femmes transgenres au niveau vaginal (néo-vagin) [237]. A noter, en France, une demande de remboursement d'un prélèvement cervico-utérin peut être réalisée quel que soit le numéro de sécurité sociale (NIR). Les dépistages des autres cancers de la sphère génitale (anus, prostate…) doivent être proposés selon les recommandations en vigueur et l'anatomie des patients.

124. Un dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST bactériennes doit être proposé au moins une fois par an aux personnes transgenres multipartenaires, voire de façon trimestrielle selon leur exposition. (HAS 2017)

125. La proposition d'un dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST bactériennes lors d'actions communautaires, dans les lieux / espaces virtuels de convivialité ou de sexe doit être favorisée. (AE)

126. Dans la mesure du possible, les auto-prélèvements doivent être favorisés pour les dépistages vaginaux afin de réduire les éventuelles douleurs et l'inconfort. (C)

127. Inclure, selon leur exposition, le dépistage régulier du VIH, des hépatites virales et des IST bactériennes, et la PrEP, dans une offre de santé transgenre adaptée aux besoins de ces personnes et aux différents temps de la transition et post-transition. Il sera important de sensibiliser les acteurs impliqués dans la santé des personnes transgenres, notamment les endocrinologues, au dépistage et la prévention. (AE)

2.6.9. Les travailleurs et travailleuses du sexe

Que l'exercice du travail du sexe soit réalisé dans des conditions de traite humaine ou en autogestion, en tant qu'activité principale ou de manière ponctuelle, en ligne ou en activité de rue, plusieurs facteurs augmentent la vulnérabilité des personnes face aux risques infectieux liés à la sexualité :

- une négociation des pratiques et de la protection (préservatif) qui peut être difficile, déséquilibrée voire inexistante ;

- un stigmate lié à l'activité qui rend difficile les échanges avec les professionnels de santé et donc l'adaptation des soins ou des actes de prévention, parfois doublé d'un isolement géographique et/ou social ;
- de nombreux partenaires sexuels.

En 2016, la HAS a dirigé un rapport concernant l'état de santé des personnes en situation de prostitution [238]. Le rapport souligne le peu de sources de données disponibles mais permet de conclure à une surexposition de cette population clé aux infections à CT, NG et aux HPV, ainsi qu'à certains troubles gynécologiques. Il mentionne également l'importance des portages extra-génitaux parmi ces populations. Concernant la syphilis, une surexposition n'est pas observée chez les femmes, mais l'est chez les hommes et les personnes transgenres. A l'issue de ce rapport, un rythme de dépistage de la syphilis et des infections à CT de deux fois par an est préconisé, avec une fréquence plus élevée si la personne en fait la demande. Toutefois le rapport ne conclut pas sur les sites à dépister pour les infections à CT. Un démarrage anticipé du dépistage des HPV est proposé. Les recommandations émises concernant le dépistage des infections à NG rejoignent celles en vigueur pour la population générale soit un dépistage ciblé sur l'exposition. Aucune distinction dans la fréquence de dépistage n'était faite en fonction du sexe.

Deux approches coexistent donc :

- Une démarche visant à proposer un dépistage combiné deux fois par an, qui nécessite une démarche proactive de la part des services de santé. Dans cette approche, les actions de dépistage VIH, des hépatites virales et des IST bactériennes, réfléchies avec des partenaires de cette communauté montrent leur intérêt [239]. Ces actions doivent être l'occasion d'une vérification du statut vaccinal et d'un rattrapage si nécessaire. La PrEP doit être présentée et discutée avec les bénéficiaires.
- Une possibilité de recourir au dépistage à la demande. Toutefois, rendre accessible ces dépistages à la demande nécessite de prendre en compte les facteurs de vulnérabilité spécifiques qui peuvent freiner l'accès aux soins comme l'isolement, la précarité économique et sociale, l'accès à la couverture maladie, à l'information, les discriminations subies en raison de leur activité ou de leur origine [238]. L'ouverture du dépistage des IST bactériennes en laboratoire de ville, sans ordonnance ni avance de frais, pourrait lever certains de ces freins si elle était connue et soutenue par les partenaires en contact avec les travailleurs et travailleuses du sexe et accessible sans condition d'âge ni de couverture sociale.

La progression de l'activité sur internet rapportée par les associations participe à l'isolement géographique et social des personnes concernées [240]. Afin de développer en ligne des modèles qui dépassent la simple information sur les centres de santé et qui proposent des offres de dépistage et de prévention, un investissement dans les solutions à distance est nécessaire. Le développement de téléconsultations de santé sexuelle et de programmes d'envoi d'autotests ou d'auto-prélèvements est à étudier auprès de ces populations, dans leurs diversités. Le développement de telles offres permettrait d'envisager un accompagnement vers un dépistage régulier, et un éventuel rapprochement des fréquences de dépistage pour cette population.

128. Selon l'utilisation de moyens de prévention et les conditions de précarité dans lesquelles vivent la personne, le dépistage du VIH et des IST bactériennes doit être proposé au moins une fois par an, voire de façon trimestrielle. (AE)

129. La proposition d'un dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST bactériennes lors d'actions communautaires sur les lieux de travail du sexe ou lors de maraude sur internet doit être favorisée. (AE)

130. Il est important d'aborder la prévention et notamment de proposer la PrEP aux personnes recevant un résultat négatif lors d'un dépistage du VIH (s'ils/elles ne sont pas déjà dans un programme de PrEP). (AE)

131. Pour cette population notamment, il est indispensable d'offrir des modalités de dépistage accessibles en ligne (commande d'autotests VIH par exemple) et de soutenir les programmes délivrant de la prévention et de l'incitation au dépistage dans l'espace numérique (maraude des associations sur internet). (AE)

132. Dans le cadre du dépistage du VIH et des IST sans ordonnance en laboratoire de biologie médicale (VIHTest, Mon Test IST), assurer la possibilité de réaliser ces dépistages sans avance de frais aux personnes non assurées quel que soit leur âge. (AE)

133. Il est recommandé de développer des liens entre les centres de santé sexuelle et les associations de santé communautaire pour orienter les offres de dépistage et de prévention vers les travailleurs et travailleuses du sexe, notamment ceux isolés ou avec une forte mobilité. Quand cela est possible, des délégations de tâches pourront être établies pour faciliter encore l'accessibilité des soins. (AE)

134. Il est nécessaire de développer des liens entre la recherche et les associations de santé communautaire pour informer sur l'état de santé global et les interventions efficaces auprès de ce public. (AE)

2.6.10. Les personnes détenues

Les recommandations pour la prévention et la prise en charge des personnes sous main de justice préconisent qu'un dépistage du VIH, du VHB, et du VHC soit systématiquement proposé à l'entrée en détention, renouvelé au cours de la détention et à la sortie si la personne n'a pas bénéficié de ces dépistages récemment. Le dépistage des IST bactériennes doit être proposé selon l'exposition [135].

135. Il convient de renforcer les stratégies de dépistage combinées de l'infection par le VIH, des hépatites virales et des IST bactériennes. L'utilisation de TROD combinés (VIH, VHB, VHC, syphilis) pourrait faciliter l'acceptabilité du dépistage par les personnes détenues, permettrait un rendu des résultats immédiat et pourrait optimiser la prise en soins et/ou la prévention. Ces outils devront être mis à disposition gratuitement des unités de soins pénitentiaires. (AE)

2.6.11. Les personnes victimes de violences sexuelles

Une étude menée aux Pays-Bas dans un centre de santé sexuelle a comparé les niveaux de positivité des tests de dépistage des IST bactériennes parmi les patients selon qu'ils consultaient suite à une

agression sexuelle ou non entre janvier 2005 et septembre 2016 [241]. Chez les femmes, les taux de positivité étaient élevés, sans différence entre les deux groupes (11,2% chez les victimes versus 11,6% chez les non-victimes). Les hommes victimes d'agression avaient quant à eux un niveau de positivité inférieur à celui des hommes non victimes d'agression (12,6% versus 17,7%). L'étude conclut que les victimes d'agression sexuelle ne présentent pas un surrisque d'infection par rapport aux autres consultants du centre. Une étude française, menée entre juillet 2012 et juillet 2013 chez des personnes consultant dans un service de médecine légale de l'AP-HP après avoir subi des violences sexuelles, a établi que 14,7% des patients étaient positifs à CT sur au moins l'un des sites (principalement génital, avec 13,8% de positivité) et 4,9% à NG [242]. Ces taux étaient supérieurs à ceux constatés en population générale et ce indépendamment du délai depuis l'agression [243].

136. Un dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST bactériennes doit être proposé après la révélation des violences sexuelles sans attendre et en favorisant les auto-prélèvements locaux pour le dépistage des IST. Si les échanges s'y prêtent, la consultation peut être une opportunité pour vérifier le statut vaccinal pour le HPV et l'hépatite B. (AE)

137. Si la survenue des violences date de moins de 15 jours (6 semaines pour le VIH), un second dépistage devra être proposé 15 jours (6 semaines) plus tard. (AE)

138. Les interventions visant à un maintien dans le soin des victimes sont à développer afin de garantir la prise en soin des infections identifiées et pouvoir reproposer un dépistage à distance de l'agression lorsque cela est nécessaire. Ce suivi peut s'élargir aux conséquences non-infectieuses des violences. (AE)

139. Les services qui reçoivent les victimes dans les suites immédiates de violences sexuelles doivent discuter, avec la personne, de la pertinence de mettre en œuvre un traitement post-exposition du VIH (TPE). (AE) (chapitre « Traitement préventif post-exposition au VIH »)

2.6.12. Les personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap ont droit à une vie privée, intime, affective, sexuelle libre et épanouie, dans le respect de la loi et du consentement de chacun. Ce droit peut s'exercer au sein d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux comme rappelé par la circulaire du 5 juillet 2021.

140. Les offres de dépistage, l'accès aux préservatifs, et si cela est adapté, à la PrEP doivent être proposés aux personnes en situation de handicap dans les mêmes conditions qu'en population générale. Selon la nature du handicap, des adaptations doivent être recherchées pour permettre d'offrir l'auto-prélèvement pour le dépistage des IST bactériennes. (AE)

141. La recherche de violences sexuelles au cours de la vie est à réaliser dans les mêmes conditions que pour la population générale et doit intégrer une recherche spécifique d'éventuelles violences au sein des institutions de résidence. (AE)

Une approche globale des questions de vie affective et sexuelle dans le cadre de l'accompagnement en établissement et services sociaux et médico-sociaux est en cours de rédaction auprès de la HAS.

Références bibliographiques

1 Molina J-M, Ghosn J, Assoumou L, et al. Daily and on-demand HIV pre-exposure prophylaxis with emtricitabine and tenofovir disoproxil (ANRS PREVENIR): a prospective observational cohort study. Lancet HIV. 2022;9:e554–62. doi: 10.1016/S2352-3018(22)00133-3

2 Grulich AE, Jin F, Bavinton BR, et al. Long-term protection from HIV infection with oral HIV pre-exposure prophylaxis in gay and bisexual men: findings from the expanded and extended EPIC-NSW prospective implementation study. Lancet HIV. 2021;8:e486–94. doi: 10.1016/S2352-3018(21)00074-6

3 Hanum N, Cambiano V, Sewell J, et al. Trends in HIV incidence between 2013-2019 and association of baseline factors with subsequent incident HIV among gay, bisexual, and other men who have sex with men attending sexual health clinics in England: A prospective cohort study. PLoS Med. 2021;18:e1003677. doi: 10.1371/journal.pmed.1003677

4 Duchesne L, Lydié N, Velter A. Increase in the overall level of protected anal sex in men who have sex with men in France: results from the repeated cross-sectional survey Rapport au Sexe, France, 2017-2019. AIDS Care. 2020;32:162–9. doi: 10.1080/09540121.2020.1739208

5 Velter A, Ousseine Y, Dupire P, et al. Évolution du niveau de protection contre le VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes séronégatifs pour le VIH – Résultats de l'enquête Rapport au sexe 2017-2019-2021. Bull Epidémiologique Hebd. 2022; 24-25.

6 Cambiano V, Miners A, Lampe FC, et al. The effect of combination prevention strategies on HIV incidence among gay and bisexual men who have sex with men in the UK: a model-based analysis. Lancet HIV. 2023;10:e713–22. doi: 10.1016/S2352-3018(23)00204-7

7 Desgrées-du-Loû A, Pannetier J, Ravalihasy A, et al. Sub-Saharan African migrants living with HIV acquired after migration, France, ANRS PARCOURS study, 2012 to 2013. Eurosurveillance. 2015;20:30065. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2015.20.46.30065

8 Pannetier J, Ravalihasy A, Lydié N, et al. Prevalence and circumstances of forced sex and post-migration HIV acquisition in sub-Saharan African migrant women in France: an analysis of the ANRS-PARCOURS retrospective population-based study. Lancet Public Health. 2018;3:e16–23. doi: 10.1016/S2468-2667(17)30211-6

9 Vignier N, Desgrées du Loû A, Pannetier J, et al. Access to health insurance coverage among sub-Saharan African migrants living in France: Results of the ANRS-PARCOURS study. PloS One. 2018;13:e0192916. doi: 10.1371/journal.pone.0192916

10 Coulibaly K, Bousmah M-A-Q, Ravalihasy A, et al. Bridging the knowledge gap of biomedical HIV prevention tools among sub-saharan african immigrants in France. Results from an empowerment-based intervention. SSM - Popul Health. 2023;23:101468. doi: 10.1016/j.ssmph.2023.101468

11 Phillips AN, Cambiano V, Nakagawa F, et al. Increased HIV incidence in men who have sex with men despite high levels of ART-induced viral suppression: analysis of an extensively documented epidemic. PloS One. 2013;8:e55312. doi: 10.1371/journal.pone.0055312

12 Weller S, Davis K. Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission. Cochrane Database Syst Rev. 2002;CD003255. doi: 10.1002/14651858.CD003255

13 Stromdahl S, Hickson F, Pharris A, et al. A systematic review of evidence to inform HIV prevention interventions among men who have sex with men in Europe. Euro Surveill Bull Eur Sur Mal Transm Eur Commun Dis Bull. 2015;20:21096. doi: 10.2807/1560-7917.es2015.20.15.21096

14 Siegfried N, Muller M, Deeks JJ, et al. Male circumcision for prevention of heterosexual acquisition of HIV in men. Cochrane Database Syst Rev. 2009;CD003362. doi: 10.1002/14651858.CD003362.pub2

15 Mills E, Cooper C, Anema A, et al. Male circumcision for the prevention of heterosexually acquired HIV infection: a meta-analysis of randomized trials involving 11,050 men. HIV Med. 2008;9:332–5. doi: 10.1111/j.1468-1293.2008.00596.x

16 Yuan T, Fitzpatrick T, Ko N-Y, et al. Circumcision to prevent HIV and other sexually transmitted infections in men who have sex with men: a systematic review and meta-analysis of global data. Lancet Glob Health. 2019;7:e436–47. doi: 10.1016/S2214-109X(18)30567-9

17 World Health Organization. Preventing HIV through safe voluntary medical male circumcision for adolescent boys and men in generalized HIV epidemics: recommendations and key considerations. 2020.

18 Melo MG, Santos BR, De Cassia Lira R, et al. Sexual transmission of HIV-1 among serodiscordant couples

in Porto Alegre, southern Brazil. Sex Transm Dis. 2008;35:912–5. doi: 10.1097/OLQ.0b013e31817e2491

19 Del Romero J, Castilla J, Hernando V, et al. Combined antiretroviral treatment and heterosexual transmission of HIV-1: cross sectional and prospective cohort study. BMJ. 2010;340:c2205. doi: 10.1136/bmj.c2205

20 Reynolds SJ, Makumbi F, Nakigozi G, et al. HIV-1 transmission among HIV-1 discordant couples before and after the introduction of antiretroviral therapy. AIDS. 2011;25:473–7. doi: 10.1097/QAD.0b013e3283437c2b

21 Donnell D, Baeten JM, Kiarie J, et al. Heterosexual HIV-1 transmission after initiation of antiretroviral therapy: a prospective cohort analysis. Lancet. 2010;375:2092–8. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60705-2

22 Apondi R, Bunnell R, Ekwaru JP, et al. Sexual behavior and HIV transmission risk of Ugandan adults taking antiretroviral therapy: 3 year follow-up. AIDS. 2011;25:1317–27. doi: 10.1097/QAD.0b013e328347f775

23 Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Sexual Activity Without Condoms and Risk of HIV Transmission in Serodifferent Couples When the HIV-Positive Partner Is Using Suppressive Antiretroviral Therapy. JAMA. 2016;316:171–81. doi: 10.1001/jama.2016.5148

24 Mujugira A, Celum C, Coombs RW, et al. HIV Transmission Risk Persists During the First 6 Months of Antiretroviral Therapy. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016;72:579–84. doi: 10.1097/QAI.0000000000001019

25 Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. N Engl J Med. 2011;365:493–505. doi: 10.1056/NEJMoa1105243

26 Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, et al. Antiretroviral Therapy for the Prevention of HIV-1 Transmission. N Engl J Med. 2016;375:830–9. doi: 10.1056/NEJMoa1600693

27 Eshleman SH, Hudelson SE, Redd AD, et al. Treatment as Prevention: Characterization of Partner Infections in the HIV Prevention Trials Network 052 Trial. J Acquir Immune Defic Syndr. 2017;74:112–6. doi: 10.1097/QAI.0000000000001158

28 Bavinton BR, Jin F, Prestage G, et al. The Opposites Attract Study of viral load, HIV treatment and HIV transmission in serodiscordant homosexual male couples: design and methods. BMC Public Health. 2014;14:917. doi: 10.1186/1471-2458-14-917

29 Bavinton BR, Pinto AN, Phanuphak N, et al. Viral suppression and HIV transmission in serodiscordant male couples: an international, prospective, observational, cohort study. Lancet HIV. 2018;5:e438–47. doi: 10.1016/S2352-3018(18)30132-2

30 Vourli G, Noori T, Pharris A, et al. Human Immunodeficiency Virus Continuum of Care in 11 European Union Countries at the End of 2016 Overall and by Key Population: Have We Made Progress? Clin Infect Dis. 2020;71:2905–16. doi: 10.1093/cid/ciaa696

31 Bor J, Fischer C, Modi M, et al. Changing Knowledge and Attitudes Towards HIV Treatment-as-Prevention and 'Undetectable = Untransmittable': A Systematic Review. AIDS Behav. 2021;25:4209–24. doi: 10.1007/s10461-021-03296-8

32 Haute Autorité de Santé. Réévaluation de la stratégie de dépistage de l'infection à VIH en France. 2017. https://www.has-sante.fr/jcms/c_2024411/fr/reevaluation-de-la-strategie-de-depistage-de-l-infection-a-vih-en-france

33 Marty L, Cazein F, Panjo H, et al. Revealing geographical and population heterogeneity in HIV incidence, undiagnosed HIV prevalence and time to diagnosis to improve prevention and care: estimates for France. J Int AIDS Soc. 2018;21:e25100. doi: 10.1002/jia2.25100

34 Le Guillou A, Cabie A, Delpierre C, et al. Dramatic decline in new HIV diagnoses in persons born in France in a large nationwide HIV cohort. Public Health. 2021;196:129–34. doi: 10.1016/j.puhe.2021.05.027

35 Grant RM, Lama JR, Anderson PL, et al. Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men. N Engl J Med. 2010;363:2587–99. doi: 10.1056/NEJMoa1011205

36 Baeten JM, Donnell D, Mugo NR, et al. Single-agent tenofovir versus combination emtricitabine plus tenofovir for pre-exposure prophylaxis for HIV-1 acquisition: an update of data from a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2014;14:1055–64. doi: 10.1016/S1473-3099(14)70937-5

37 Molina J-M, Capitant C, Spire B, et al. On-Demand Preexposure Prophylaxis in Men at High Risk for HIV-1 Infection. N Engl J Med. 2015;373:2237–46. doi: 10.1056/NEJMoa1506273

38 McCormack S, Dunn DT, Desai M, et al. Pre-exposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomised trial. Lancet. 2016;387:53–60. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00056-2

39 Molina J-M, Charreau I, Spire B, et al. Efficacy, safety, and effect on sexual behaviour of on-demand pre-exposure prophylaxis for HIV in men who have sex

with men: an observational cohort study. Lancet HIV. 2017;4:e402–e410.

40 Jourdain H, de Gage SB, Desplas D, et al. Real-world effectiveness of pre-exposure prophylaxis in men at high risk of HIV infection in France: a nested case-control study. Lancet Public Health. 2022;7:e529–36. doi: 10.1016/S2468-2667(22)00106-2

41 Gilles M, Tetart M, Huleux T, et al. Connaissances des médecins généralistes en matière de prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH en 2020. Médecine Mal Infect. 2022;1:S132. doi: 10.1016/j.mmifmc.2022.03.287

42 Lions C, Laroche H, Mora M, et al. Missed opportunities for HIV pre-exposure prophylaxis among people with recent HIV infection: The French ANRS 95041 OMaPrEP study. HIV Med. 2023;24:191–201. doi: 10.1111/hiv.13367

43 EPIPHARE. Suivi de l'utilisation de la PrEP au VIH. 2023. https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2023/

44 Billioti de Gage, S, Desplas, D, Dray-Spira, R. Suivi de l'utilisation de Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS). Actualisation des données jusqu'au 30 Juin 2021. EPIPHARE 2021.

45 Haute Autorité de Santé. Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 - Prophylaxie (PrEP) du VIH par ténofovir disoproxil / emtricitabine dans le cadre de l'urgence sanitaire. 2021. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3262060/fr/reponses-rapides-dans-le-cadre-de-la-covid-19-prophylaxie-prep-du-vih-par-tenofovir-disoproxil-/-emtricitabine-dans-le-cadre-de-l-urgence-sanitaire

46 Velter A, Champenois K, Rojas Castro D, et al. Impact perçu de l'épidémie de covid-19des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en France. Enquête ERAS Covid-19, 2020. Bull Epidémiologique Hebd. 2020;33–34:666–72.

47 Green K, Ngure K. PrEP-ing for 2030: Why optimization and scale-up of the PrEP service and product mix is critical to addressing unmet PrEP need and supporting effective use towards 2030 HIV prevention goals. International AIDS conference. Montreal, Canada 2022. Satellite session SA004.

48 Gosselin A, Coulibaly K, Ravalihasy A, et al. Finding the missing link: when community-based outreach in public space is key to engage migrants in health prevention programmes in Paris, France. J Epidemiol Community Health. 2020;74:668–75. doi: 10.1136/jech-2019-213394

49 Le Guillou A, Buchbinder S, Scott H, et al. Population Impact and Efficiency of Improvements to HIV PrEP Under Conditions of High ART Coverage Among San Francisco Men Who Have Sex With Men. J Acquir Immune Defic Syndr. 2021;88:340–7. doi: 10.1097/QAI.0000000000002781

50 Crawford ND, Harrington KRV, Alohan DI, et al. Integrating and Disseminating Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) Screening and Dispensing for Black Men Who Have Sex With Men in Atlanta, Georgia: Protocol for Community Pharmacies. JMIR Res Protoc. 2022;11:e35590. doi: 10.2196/35590

51 Charpentier N, Quatremère G, Mabire X, et al. Freins et leviers de la prise en charge du traitement post-exposition au VIH. Santé Publique. 2016;28:791–9. doi: 10.3917/spub.166.0791

52 Palich R, Martin-Blondel G, Cuzin L, et al. Experiences of HIV postexposure prophylaxis (PEP) among highly exposed men who have sex with men (MSM). Sex Transm Infect. 2017;93:493–8. doi: 10.1136/sextrans-2016-052901

53 TrT-5 CHV. Synthèse des réponses de l'appel à témoignanges sur le refus et le renoncement au TPE. 2021. https://www.trt-5.org/appel-a-temoignages/

54 Ministère des solidarités et de la santé. Feuille de route : stratégie nationale de santé sexuelle 2021-2024. https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/article/sante-sexuelle

55 Ministère des affaires sociales et de la santé. Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda 2017-2030. https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/article/sante-sexuelle

56 OFDT. Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes (2015-2016). 2016. https://www.ofdt.fr/publication/2016/substances-psychoactives-usagers-et-marches-les-tendances-recentes-2015-2016-872

57 Velter A, Sauvage C, Saboni L, et al. HIV prevalence estimate among men who have sex with men attending gay venues in five French cities - PREVAGAY 2015. Bull Epidémiologique Hebd. 2017; 18.

58 Roux P, Donadille C, Girard G, et al. Impact of COVID-19 Pandemic on Men Who Have Sex With Men That Practice Chemsex in France: Results From the National ERAS Web Survey. Am J Mens Health. 2022;16:15579883211073224. doi: 10.1177/15579883211073225

59 Velter A, Roux P. La pratique du chemsex dans les enquêtes nationales Rapport au sexe (ERAS) auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes : évolutions entre 2017 et 2023. Psychotropes. 2024;31:53–73.

60 Lafortune D, Blais M, Miller G, et al. Psychological and Interpersonal Factors Associated with Sexualized Drug Use Among Men Who Have Sex with Men: A

Mixed-Methods Systematic Review. Arch Sex Behav. 2021;50:427–60. doi: 10.1007/s10508-020-01741-8

61 Daveluy A, Labadie M, Titier K, et al. Poisoning by synthetic cathinones: Consumption behaviour and clinical description from 11 cases recorded by the Addictovigilance Centre of Bordeaux. Toxicol Anal Clin. 2017;29:34–40. doi: 10.1016/j.toxac.2016.11.005

62 Roux P, Fressard L, Suzan-Monti M, et al. Is on-Demand HIV Pre-exposure Prophylaxis a Suitable Tool for Men Who Have Sex With Men Who Practice Chemsex? Results From a Substudy of the ANRS-IPERGAY Trial. J Acquir Immune Defic Syndr. 2018;79:e69–75. doi: 10.1097/QAI.0000000000001781

63 Protiere C, Sow A, Bladou F, et al. Les cinq principaux rapports au chemsex : de la vision la plus positive à la plus négative (ANRS-PaacX). AfraVIH conference 2022. Marseille, France. doi: 10.13140/RG.2.2.18528.76801

64 Bacon OML, Coffey SC, Hsu LC, et al. Development of a Citywide Rapid Antiretroviral Therapy Initiative in San Francisco. Am J Prev Med. 2021;61:S47–54. doi: 10.1016/j.amepre.2021.06.001

65 Auerbach JD, Dubé K. Editorial: Critical social and behavioral sciences perspectives on ending the HIV epidemic. Curr Opin HIV AIDS. 2022;17:37–9. doi: 10.1097/COH.0000000000000716

66 Nwokolo N, Whitlock G, McOwan A. Not just PrEP: other reasons for London's HIV decline. Lancet HIV. 2017;4:e153. doi: 10.1016/S2352-3018(17)30044-9

67 Shah, Ammi, Mackay, Niel, Ratna, Natasha, et al. HIV testing, PrEP, new HIV diagnoses and care outcomes for people accessing HIV services: 2023 report. The annual official statistics data release (data to end of December 2022). London: UK Health Security Agency 2023. https://www.gov.uk/government/statistics/hiv-annual-data-tables/hiv-testing-prep-new-hiv-diagnoses-and-care-outcomes-for-people-accessing-hiv-services-2023-report#suggested-citation

68 HIV Monitoring. Number of HIV-diagnoses in the Netherlands declines. Netherlands 2023. https://www.hiv-monitoring.nl/en/

69 Grulich A. HIV in Australia: an epidemiological profile. IAS conference 2023. Brisban, Australia

70 Santé publique France. VIH et IST bactériennes en France, Bilan 2023. Bulletin de Santé Publique, édition nationale. 2024. https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/bulletin-national/vih-et-ist-bacteriennes-en-france.-bilan-2023

71 Palich R, Arias-Rodriguez A, Duracinsky M, et al. High proportion of post-migration HIV acquisition in migrant men who have sex with men receiving HIV care in Paris region, in France, and associations with social disadvantage and sexual behaviours: results of the 2022 ANRS-MIE GANYMEDE study. Eurosurveillance. 2024;29(11):pii=2300445. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2024.29.11.2300445.

72 Desgrees-du-Lou A, Pannetier J, Ravalihasy A, et al. Is hardship during migration a determinant of HIV infection? Results from the ANRS PARCOURS study of sub-Saharan African migrants in France. AIDS. 2016;30:645–56. doi: 10.1097/QAD.0000000000000957

73 Jeffries WL, Flores SA, Rooks-Peck CR, et al. Experienced Homophobia and HIV Infection Risk Among U.S. Gay, Bisexual, and Other Men Who Have Sex with Men: A Meta-Analysis. LGBT Health. 2021;8:1–10. doi: 10.1089/lgbt.2020.0274

74 Haute Autorité de Santé. Dépistage de l'infection par le VIH en France - Modalités de réalisation des tests de dépistage. 2008. https://www.has-sante.fr/jcms/c_704257/fr/depistage-de-l-infection-par-le-vih-en-france-modalites-de-realisation-des-tests-de-depistage

75 Haute Autorité de Santé. Dépistage de l'infection par le VIH en France - Stratégies et dispositif de dépistage. 2009. https://www.has-sante.fr/jcms/c_704257/fr/depistage-de-l-infection-par-le-vih-en-france-modalites-de-realisation-des-tests-de-depistage

76 Ministère de la santé et des sports. Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2). JORF n°0266 du 17 novembre 2010 page 20499, texte n° 19. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023093746&dateTexte=&categorieLien=id

77 Ministère des solidarités et de la santé. Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage, de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030824409&dateTexte=20150702

78 Ministère de l'économie, des finances et de la relance, Ministère des solidarités et de la santé. Arrêté du 27 novembre 2020 relatif à l'expérimentation nationale de centres de santé sexuelle d'approche communautaire et fixant la liste des établissements expérimentateurs. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042577044

79 Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Ministère de la santé et de la prévention. Arrêté du 29 septembre 2023 relatif à l'ouverture d'une période transitoire pour l'innovation « Centres de santé sexuelle d'approche communautaire ». https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048139991

80 Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. Généralisation de l'accès au dépistage du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) par sérologie directement sans prescription dans tous les laboratoires de biologie médicale et au rôle des agences régionales de santé. 2021. https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=023a2cdddf6e860907bd8d4733640cbe6b1ee53b

81 Ministère des solidarités et de la santé. Feuille de route : stratégie nationale de santé sexuelle 2018-2020. https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/article/sante-sexuelle

82 Ministère de la santé et des sports. Arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022320859

83 World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV testing services. Geneva 2019. https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-155058-1

84 Saag MS, Benson CA, Gandhi RT, et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018;320:379–96. doi: 10.1001/jama.2018.8431

85 Lert F, Bouvet de la Maisonneuve P, Ngoh P, et al. « Au labo sans ordo » : une expérimentation pour étendre l'offre de dépistage du VIH à Paris et dans les Alpes-Maritimes. Résultats intermédiaires à 6 mois, juillet-décembre 2019. Bull Épidémiologique Hebd. 2020; 33-34.

86 Supervie V, Marty L, Lacombe J-M, et al. Looking Beyond the Cascade of HIV Care to End the AIDS Epidemic: Estimation of the Time Interval From HIV Infection to Viral Suppression. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016;73:348–55. doi: 10.1097/QAI.0000000000001120

87 Supervie V, Ndawinz JDA, Lodi S, et al. The undiagnosed HIV epidemic in France and its implications for HIV screening strategies. AIDS. 2014;28:1797–804. doi: 10.1097/QAD.0000000000000270

88 Champenois K, Cousien A, Cuzin L, et al. Missed opportunities for HIV testing in newly-HIV-diagnosed patients, a cross sectional study. BMC Infect Dis. 2013;13:200. doi: 10.1186/1471-2334-13-200

89 Burns FM, Johnson AM, Nazroo J, et al. Missed opportunities for earlier HIV diagnosis within primary and secondary healthcare settings in the UK. AIDS. 2008;22:115–22. doi: 10.1097/QAD.0b013e3282f1d4b6

90 Joore IK, Arts DL, Kruijer MJP, et al. HIV indicator condition-guided testing to reduce the number of undiagnosed patients and prevent late presentation in a high-prevalence area: a case-control study in primary care. Sex Transm Infect. 2015;91:467–72. doi: 10.1136/sextrans-2015-052073

91 Bogers SJ, Twisk DE, Beckers LM, et al. Who is providing HIV diagnostic testing? Comparing HIV testing by general practitioners and sexual health centres in five regions in the Netherlands, 2011-2018. Sex Transm Infect. 2022;98:262–8. doi: 10.1136/sextrans-2021-055109

92 Deblonde J, Van Beckhoven D, Loos J, et al. HIV testing within general practices in Europe: a mixed-methods systematic review. BMC Public Health. 2018;18:1191. doi: 10.1186/s12889-018-6107-0

93 Apers H, Nöstlinger C, Van Beckhoven D, et al. Identifying key elements to inform HIV-testing interventions for primary care in Belgium. Health Promot Int. 2020;35:301–11. doi: 10.1093/heapro/daz037

94 Fagard C, Champenois K, Joseph J-P, et al. Dépistage conjoint du VIH, du VHB et du VHC par les médecins généralistes: étude de faisabilité en Gironde et dans le Nord en 2012. Bull Épidémiologique Hebd. 2014;21–22:395–400.

95 Martínez Sanz J, Pérez Elías MJ, Muriel A, et al. Outcome of an HIV education program for primary care providers: Screening and late diagnosis rates. PloS One. 2019;14:e0218380. doi: 10.1371/journal.pone.0218380

96 Davies CF, Kesten JM, Gompels M, et al. Evaluation of an educational intervention to increase HIV-testing in high HIV prevalence general practices: a pilot feasibility stepped-wedged randomised controlled trial. BMC Fam Pract. 2018;19:195. doi: 10.1186/s12875-018-0880-9

97 Leber W, Panovska-Griffiths J, Martin P, et al. Evaluating the impact of post-trial implementation of RHIVA nurse-led HIV screening on HIV testing, diagnosis and earlier diagnosis in general practice in London, UK. EClinicalMedicine. 2020;19:100229. doi: 10.1016/j.eclinm.2019.11.022

98 Bogers S, Schim van der Loeff M, Boyd A, et al. Improving provider-initiated testing for HIV and other STI in the primary care setting in Amsterdam, the

Netherlands: Results from a multifaceted, educational intervention programme. PloS One. 2023;18:e0282607. doi: 10.1371/journal.pone.0282607

99 Bogers SJ, Schim van der Loeff MF, van Dijk N, et al. Rationale, design and initial results of an educational intervention to improve provider-initiated HIV testing in primary care. Fam Pract. 2021;38:441–7. doi: 10.1093/fampra/cmaa139

100 Kershaw C, Taylor JL, Horowitz G, et al. Use of an electronic medical record reminder improves HIV screening. BMC Health Serv Res. 2018;18:14. doi: 10.1186/s12913-017-2824-9

101 Agustí C, Cunillera O, Almeda J, et al. Efficacy of an electronic reminder for HIV screening in primary healthcare based on indicator conditions in Catalonia (Spain). HIV Med. 2022;23:868–79. doi: 10.1111/hiv.13270

102 Joore IK, Geerlings SE, Brinkman K, et al. The importance of registration of sexual orientation and recognition of indicator conditions for an adequate HIV risk-assessment. BMC Infect Dis. 2017;17:178. doi: 10.1186/s12879-017-2279-y

103 Jordans CCE, Vasylyev M, Rae C, et al. National medical specialty guidelines of HIV indicator conditions in Europe lack adequate HIV testing recommendations: a systematic guideline review. Euro Surveill. 2022;27:2200338. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2022.27.48.2200338

104 Champenois K, Papot E, Deuffic-Burban S, et al. Indication de dépistage du VIH dans les recommandations françaises des spécialités médicales relatives aux maladies évocatrices du VIH. AfraVIH conference 2022. Marseille, France

105 Raben D, Sullivan AK, Mocroft A, et al. Improving the evidence for indicator condition guided HIV testing in Europe: Results from the HIDES II Study – 2012 – 2015. Plos One. 2019;14:e0220108. doi: 10.1371/journal.pone.0220108

106 Gauthier R, Livrozet J-M, Prevoteau du Clary F, et al. Feasibility and acceptability of rapid HIV test screening (DEPIVIH) by French family physicians. Med Mal Infect. 2012;42:553–60. doi: 10.1016/j.medmal.2012.08.005

107 Papadima D, Gauthier R, Prévoteau du Clary F, et al. DEPIVIH 2: Use of three HIV testing methods in French primary care settings - ELISA laboratory screening versus two rapid point-of-care HIV tests. Med Mal Infect. 2018;48:122–9. doi: 10.1016/j.medmal.2017.11.005

108 Demorat H, Lopes A, Chopin D, et al. Acceptability and feasibility of HIV testing in general medicine by ELISA or rapid test from finger-stick whole blood. Presse Med. 2018;47:e15–23. doi: 10.1016/j.lpm.2017.11.022

109 Fraisse T, Fourcade C, Brazes-Sanz J, et al. A cross sectional survey of the barriers for implementing rapid HIV testing among French general practitioners. Int J STD AIDS. 2016;27:1005–12. doi: 10.1177/0956462415605413

110 Agustí C, Fernàndez-López L, Mascort J, et al. Acceptability of rapid HIV diagnosis technology among primary healthcare practitioners in Spain. AIDS Care. 2013;25:544–9. doi: 10.1080/09540121.2012.726339

111 Tran T-C, Pillonel J, Cazein F, et al. Antenatal HIV screening: results from the National Perinatal Survey, France, 2016. Euro Surveill. 2019;24:1800573. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.40.1800573

112 Favarato G, Bailey H, Burns F, et al. Migrant women living with HIV in Europe: are they facing inequalities in the prevention of mother-to-child-transmission of HIV?: The European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) study group in EuroCoord. Eur J Public Health. 2018;28:55–60. doi: 10.1093/eurpub/ckx048

113 Nachega JB, Uthman OA, Anderson J, et al. Adherence to antiretroviral therapy during and after pregnancy in low-income, middle-income, and high-income countries: a systematic review and meta-analysis. AIDS. 2012;26:2039–52. doi: 10.1097/QAD.0b013e328359590f

114 Omonaiye O, Kusljic S, Nicholson P, et al. Medication adherence in pregnant women with human immunodeficiency virus receiving antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa: a systematic review. BMC Public Health. 2018;18:805. doi: 10.1186/s12889-018-5651-y

115 Penot P. Acceptabilité et faisabilité d'une consultation prénatale de prévention dédiée aux pères d'enfants à naître dans une maternité de Seine-Saint-Denis : résultats de l'étude ANRS-MIE PARTAGE. Congrès de la SFLS 2022. Saint-Denis, France.

116 Penot P, Jacob G, Guerizec A, et al. Implementing a prenatal health screening intervention for future fathers in Montreuil, France: most users are immigrants facing hardship. BMC Public Health. 2024:In press.

117 White DAE, Tran T, Dideum PJ, et al. Physician-initiated rapid HIV testing in an urban emergency department: comparison of testing using a point-of-care versus a laboratory model. Ann Emerg Med. 2011;58:S53-59. doi: 10.1016/j.annemergmed.2011.03.025

118 Casalino E, Bernot B, Bouchaud O, et al. Twelve months of routine HIV screening in 6 emergency departments in the Paris area: results from the ANRS URDEP study. PloS One. 2012;7:e46437. doi: 10.1371/journal.pone.0046437

119 d'Almeida KW, Kierzek G, de Truchis P, et al. Modest public health impact of nontargeted human immunodeficiency virus screening in 29 emergency departments. Arch Intern Med. 2012;172:12–20. doi: 10.1001/archinternmed.2011.535

120 Haukoos JS, Hopkins E, Bender B, et al. Comparison of enhanced targeted rapid HIV screening using the Denver HIV risk score to nontargeted rapid HIV screening in the emergency department. Ann Emerg Med. 2013;61:353–61. doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.10.031

121 Leblanc J, Hejblum G, Costagliola D, et al. Targeted HIV Screening in Eight Emergency Departments: The DICI-VIH Cluster-Randomized Two-Period Crossover Trial. Ann Emerg Med. 2018;72:41-53.e9. doi: 10.1016/j.annemergmed.2017.09.011

122 Tan R, Hugli O, Cavassini M, et al. Non-targeted HIV testing in the emergency department: not just how but where. Expert Rev Anti Infect Ther. 2018;16:893–905. doi: 10.1080/14787210.2018.1545575

123 Spagnolello O, Reed MJ. Targeted HIV screening in the emergency department. Intern Emerg Med. 2021;16:1273–87. doi: 10.1007/s11739-021-02648-5

124 Leblanc J, Burnet E, D'Almeida KW, et al. The role of nurses in HIV screening in health care facilities: A systematic review. Int J Nurs Stud. 2015;52:1495–513. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.04.007

125 Leblanc J, Côté J, Pagé MG, et al. Implementation of Nurse-Driven HIV Screening Targeting Key Populations in Emergency Departments: A Multilevel Analysis From the DICI-VIH Trial. Worldviews Evid Based Nurs. 2019;16:444–53. doi: 10.1111/wvn.12393

126 Cour des comptes. La prévention sanitaire (art. L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières). 2011. https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prevention-sanitaire

127 Ong JJ, Coulthard K, Quinn C, et al. Risk-Based Screening Tools to Optimise HIV Testing Services: a Systematic Review. Curr HIV/AIDS Rep. 2022;19:154–65. doi: 10.1007/s11904-022-00601-5

128 Haukoos JS, Lyons MS, Rothman RE, et al. Comparison of HIV Screening Strategies in the Emergency Department: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2021;4:e2117763. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.17763

129 Martel-Laferriere V, Baril J-G, Alarie I, et al. Opt-out universal HCV and HIV screening in a Canadian emergency room: a cross-sectional study. BMJ Open. 2022;12:e048748. doi: 10.1136/bmjopen-2021-048748

130 Bradshaw D, Rae C, Rayment M, et al. HIV/HCV/HBV testing in the emergency department: a feasibility and seroprevalence study. HIV Med. 2018;19 Suppl 1:52–7. doi: 10.1111/hiv.12590

131 Harmon J, Kelley MMG, Heath SL, et al. Characteristics of HIV Seroconverters Identified in an Emergency Department HIV Screening Program. AIDS Patient Care STDs. 2021;35:255–62. doi: 10.1089/apc.2021.0031

132 Menon AA, Nganga-Good C, Martis M, et al. Linkage to Care Methods and Rates in U.S. Emergency Department-Based HIV Testing Programs – A Systematic Literature Review Brief Report. Acad Emerg Med. 2016;23:835–42. doi: 10.1111/acem.12987

133 Direction générale de la santé. Enquête PREVACAR. Volet offre de soins VIH, hépatites et traitements de substitution en milieu carcéral. 2011. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4-aHDkOKDAxWGRqQEHcS3BXEQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fsante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fenquete_prevacar_-_volet_offre_de_soins_-_vih_hepatites_et_traitements_de_substitution_en_milieu_c

134 Chiron E, Jauffret-Roustide M, Le Strat Y, et al. Prévalence de l'infection par le VIH et le virus de l'hépatite C chez les personnes détenues en France. Résultats de l'enquête Prévacar 2010. Bull Épidémiologique Hebd. 2013;35–36:445–50.

135 Ministère de la justice, Ministère des solidarités et de la santé. Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice. Guide méthodologique. 2019. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodo_2019_ppsmj.pdf

136 Conseil National du Sida. Avis suivi de recommandations et Rapport sur la prévention, le dépistage et le traitement de l'hépatite C chez les personnes détenues. 2019. https://cns.sante.fr/rapports-et-avis/avis-prisons-2019/

137 Abel S, Cuzin L, Da Cunha S, et al. Reaching the WHO target of testing persons in jails in prisons will need diverse efforts and resources. PloS One. 2018;13:e0202985. doi: 10.1371/journal.pone.0202985

138 Delmas G, Ndeikoundam N, Brouard C, et al. Surveillance SURCEGIDD : dépistage et diagnostic du VIH, des hépatites B et C et des IST bactériennes en CeGIDD en 2020. Bull Épidémiologique Hebd. 2021;20–21:401–12.

139 Champenois K, Annequin M, Ngoh P, et al. Profils des usagers du programme « Au labo sans ordo », dépistage du VIH sans ordonnance et sans frais en laboratoire de biologie médicale. Bull Épidémiologique Hebd. 2020;33–34.

140 Haute Autorité de Santé. Avis n° 2021.0053/AC/SBP du 15 juillet 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de

coopération national « Consultation de santé sexuelle par l'infirmier (ère) en CeGIDD, CPEF et centre de santé sexuelle, en lieu et place du médecin ». 2021. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/ac_2021_0053_pcn_01_cegidd_cd_2021_07_15_vd.pdf

141 Inspection générale des affaires sociales. Organisation des structures de prévention et de prise en charge en santé sexuelle. 2023. https://igas.gouv.fr/organisation-des-structures-de-prevention-et-de-prise-en-charge-en-sante-sexuellehttps://igas.gouv.fr/organisation-des-structures-de-prevention-et-de-prise-en-charge-en-sante-sexuelle

142 Champenois K, Sawras V, Ngoh P, et al. Facilitating the access to HIV testing at lower costs: "To the laboratory without prescription" (ALSO), a pilot intervention to expand HIV testing through medical laboratories in France. PloS One. 2024;19:e0309754. doi: 10.1371/journal.pone.0309754

143 Sawras V, Gatseva Y, Deuffic-Burban S, et al. Evaluation médico-économique de quatre offres de dépistage du VIH en France. AfraVIH conference 2022. Marseille, France

144 Cazein F. Montée en charge du dispositif VIHTEST. Journées thématiques IST, PrEP, santé sexuelle 2023. Paris, France.

145 Klepser DG, Klepser ME, Peters PJ, et al. Implementation and Evaluation of a Collaborative, Pharmacy-Based Hepatitis C and HIV Screening Program. Prev Chronic Dis. 2022;19:E83. doi: 10.5888/pcd19.220129

146 Collins B, Bronson H, Elamin F, et al. The 'No Wrong Door' Approach to HIV Testing: Results From a Statewide Retail Pharmacy-Based HIV Testing Program in Virginia, 2014-2016. Public Health Rep. 2018;133:34S-42S. doi: 10.1177/0033354918801026

147 Darin KM, Klepser ME, Klepser DE, et al. Pharmacist-provided rapid HIV testing in two community pharmacies. J Am Pharm Assoc. 2015;55:81–8. doi: 10.1331/JAPhA.2015.14070

148 Kelly DV, Kielly J, Hughes C, et al. Expanding access to HIV testing through Canadian community pharmacies: findings from the APPROACH study. BMC Public Health. 2020;20:639. doi: 10.1186/s12889-020-08719-0

149 Kielly J, Kelly DV, Hughes C, et al. Adaptation of POCT for pharmacies to reduce risk and optimize access to care in HIV, the APPROACH study protocol: examining acceptability and feasibility. Pilot Feasibility Stud. 2018;4:59. doi: 10.1186/s40814-018-0252-1

150 Fernández-Balbuena S, Belza MJ, Zulaica D, et al. Widening the Access to HIV Testing: The Contribution of Three In-Pharmacy Testing Programmes in Spain. PloS One. 2015;10:e0134631. doi: 10.1371/journal.pone.0134631

151 Ryder PT, Meyerson BE, Coy KC, et al. Pharmacists' perspectives on HIV testing in community pharmacies. J Am Pharm Assoc. 2013;53:595–600. doi: 10.1331/JAPhA.2013.12240

152 Fernández-Balbuena S, Marcos H, Pérez-Rubio A, et al. The rapid test in Spanish pharmacies: a novel programme to reach heterosexual men? HIV Med. 2015;16:362–9. doi: 10.1111/hiv.12224

153 Amesty S, Crawford ND, Nandi V, et al. Evaluation of Pharmacy-Based HIV Testing in a High-Risk New York City Community. AIDS Patient Care STDs. 2015;29:437–44. doi: 10.1089/apc.2015.0017

154 So E, Brands M, Suomala E, et al. Pharmacists' Opinions on the Implementation of HIV and HepC Point-of-Care-Testing in a U.S. Pharmacy Chain. Innov Pharm. 2019;10. doi: 10.24926/iip.v10i1.1425

155 Gauly J, Ross J, Hall I, et al. Pharmacy-based sexual health services: a systematic review of experiences and attitudes of pharmacy users and pharmacy staff. Sex Transm Infect. 2019;95:488–95. doi: 10.1136/sextrans-2019-054096

156 McKeirnan K, Kherghehpoush S, Gladchuk A, et al. Addressing Barriers to HIV Point-of-Care Testing in Community Pharmacies. Pharm. 2021;9:84. doi: 10.3390/pharmacy9020084

157 Mital S, Kelly D, Hughes C, et al. Estimated cost-effectiveness of point-of-care testing in community pharmacies vs. self-testing and standard laboratory testing for HIV. AIDS. 2023;37:1125–35. doi: 10.1097/QAD.0000000000003526

158 Meyerson BE, Emetu RE, Sanders SA, et al. Preferences of Gay and Bisexual Men for Pharmacy-Based HIV Testing and Over-the-Counter HIV Tests. LGBT Health. 2014;1:225–8. doi: 10.1089/lgbt.2014.0010

159 Ministère des solidarités et de la santé. Arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043684636

160 Bougnoux J, Piaton A, Barbier F, et al. Expérimentation du TROD VIH/syphilis par des acteurs-rices communautaires à AIDES. Congrès de la SFLS 2023. Tours, France

161 Haute Autorité de Santé. Autotests de dépistage du VIH. Information à l'intention des professionnels de santé et des associations. Recommandation en santé

publique. 2015. https://www.has-sante.fr/jcms/c_1768844/fr/autotests-de-depistage-du-vih

162 Krause J, Subklew-Sehume F, Kenyon C, et al. Acceptability of HIV self-testing: a systematic literature review. BMC Public Health. 2013;13:735. doi: 10.1186/1471-2458-13-735

163 Pant Pai N, Sharma J, Shivkumar S, et al. Supervised and unsupervised self-testing for HIV in high- and low-risk populations: a systematic review. PLoS Med. 2013;10:e1001414. doi: 10.1371/journal.pmed.1001414

164 Johnson CC, Kennedy C, Fonner V, et al. Examining the effects of HIV self-testing compared to standard HIV testing services: a systematic review and meta-analysis. J Int AIDS Soc. 2017;20:21594. doi: 10.7448/IAS.20.1.21594

165 Figueroa C, Johnson C, Verster A, et al. Attitudes and Acceptability on HIV Self-testing Among Key Populations: A Literature Review. AIDS Behav. 2015;19:1949–65. doi: 10.1007/s10461-015-1097-8

166 Lydié N, Duchesne L, Velter A. Qui sont les utilisateurs de l'autotest VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en France ? Résultats de l'Enquête Rapport Au Sexe 2017. Bull Épidémiologique Hebd. 2018;40–41:799–804.

167 Bil JP, Prins M, Stolte IG, et al. Usage of purchased self-tests for HIV and sexually transmitted infections in Amsterdam, the Netherlands: results of population-based and serial cross-sectional studies among the general population and sexual risk groups. BMJ Open. 2017;7:e016609. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016609

168 Nunn A, Brinkley-Rubinstein L, Rose J, et al. Latent class analysis of acceptability and willingness to pay for self-HIV testing in a United States urban neighbourhood with high rates of HIV infection. J Int AIDS Soc. 2017;20:21290. doi: 10.7448/IAS.20.1.21290

169 Guerras J-M, Hoyos J, de la Fuente L, et al. Awareness and Use of HIV Self-Testing Among Men Who Have Sex With Men Remains Low in Spain 2 Years After Its Authorization. Front Public Health. 2022;10:888059. doi: 10.3389/fpubh.2022.888059

170 Greacen T, Simon A, Troisoeufs A, et al. [Pharmacists' and key populations' points of view on HIV self-test dispensation in pharmacies in France]. Sante Publique. 2020;32:229–37. doi: 10.3917/spub.202.0229

171 Huang E, Marlin RW, Young SD, et al. Using Grindr, a Smartphone Social-Networking Application, to Increase HIV Self-Testing Among Black and Latino Men Who Have Sex With Men in Los Angeles, 2014. AIDS Educ Prev. 2016;28:341–50. doi: 10.1521/aeap.2016.28.4.341

172 Bacon A, Wang W, Lee H, et al. Review of HIV Self Testing Technologies and Promising Approaches for the Next Generation. Biosensors. 2023;13:298. doi: 10.3390/bios13020298

173 Champenois K, Coquelin V, Supervie V, et al. Profile and motivations of people who are using the HIV self-test. Results from the "VIH: Teste-Toi Toi-même" study in France. International AIDS Conference 2018. Amstersam, Netherland.

174 Udeagu C-CN, Shah S, Molochevski M. Men Who Have Sex With Men Seek Timely Human Immunodeficiency Virus Confirmation and Care After Rapid Human Immunodeficiency Virus Self-Test: Data From Partner Services Program, New York City. Sex Transm Dis. 2017;44:608–12. doi: 10.1097/OLQ.0000000000000648

175 Rahib D. Place de l'auto-prélèvement à domicile dans les stratégies de dépistages du VIH et des autres IST chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en France. 2022. https://theses.hal.science/tel-03922076

176 Witzel TC, Rodger AJ, Burns FM, et al. HIV Self-Testing among Men Who Have Sex with Men (MSM) in the UK: A Qualitative Study of Barriers and Facilitators, Intervention Preferences and Perceived Impacts. PloS One. 2016;11:e0162713. doi: 10.1371/journal.pone.0162713

177 Witzel TC, Bourne A, Burns FM, et al. HIV self-testing intervention experiences and kit usability: results from a qualitative study among men who have sex with men in the SELPHI (Self-Testing Public Health Intervention) randomized controlled trial in England and Wales. HIV Med. 2020;21:189–97. doi: 10.1111/hiv.12818

178 Witzel TC, Weatherburn P, Bourne A, et al. Exploring Mechanisms of Action: Using a Testing Typology to Understand Intervention Performance in an HIV Self-Testing RCT in England and Wales. Int J Environ Res Public Health. 2020;17:466. doi: 10.3390/ijerph17020466

179 Ministère des affaires sociales et de la santé. Arrêté du 18 août 2016 fixant les conditions particulières de délivrance de l'autotest de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les modalités d'information et d'accompagnement de la personne en application de l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique. 2016. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033052984

180 Rodger AJ, McCabe L, Phillips AN, et al. Free HIV self-test for identification and linkage to care of previously undetected HIV infection in men who have sex with men in England and Wales (SELPHI): an open-label, internet-based, randomised controlled trial. Lancet HIV. 2022;9:e838–47. doi: 10.1016/S2352-3018(22)00266-1

181 Public Health England. National HIV Self-sampling service, two year service report. 2018. London. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c9b5284e5274a528429803f/HIV_self_sampling__service_2_year_service_report.pdf

182 Hsieh Y-H, Jett-Goheen M, Dize L, et al. P02.07 Utilisation of risk score tool of internet i want the kit (iwtk) home self-collection program for sexually transmitted infections (stis) in males. Sex Transm Infect. 2015;91:A85–6. doi: 10.1136/sextrans-2015-052270.228

183 Gaydos CA, Dwyer K, Barnes M, et al. Internet-based screening for Chlamydia trachomatis to reach non-clinic populations with mailed self-administered vaginal swabs. Sex Transm Dis. 2006;33:451–7. doi: 10.1097/01.olq.0000200497.14326.fb

184 Kersaudy-Rahib D, Lydié N, Leroy C, et al. Chlamyweb Study II: a randomised controlled trial (RCT) of an online offer of home-based Chlamydia trachomatis sampling in France. Sex Transm Infect. 2017;93:188–95. doi: 10.1136/sextrans-2015-052510

185 Lydié N, de Barbeyrac B, Bluzat L, et al. Chlamyweb Study I: rationale, design and acceptability of an internet-based chlamydia testing intervention. Sex Transm Infect. 2017;93:179–87. doi: 10.1136/sextrans-2015-052511

186 Lydié N, Saboni L, Gautier A, et al. Innovative Approach for Enhancing Testing of HIV, Hepatitis B, and Hepatitis C in the General Population: Protocol for an Acceptability and Feasibility Study (BaroTest 2016). JMIR Res Protoc. 2018;7:e180. doi: 10.2196/resprot.9797

187 Brouard C, Saboni L, Gautier A, et al. HCV and HBV prevalence based on home blood self-sampling and screening history in the general population in 2016: contribution to the new French screening strategy. BMC Infect Dis. 2019;19:896. doi: 10.1186/s12879-019-4493-2

188 Rahib D, Delagreverie H, Gabassi A, et al. Online self-sampling kits to screen multipartner MSM for HIV and other STIs: participant characteristics and factors associated with kit use in the first 3 months of the MemoDepistages programme, France, 2018. Sex Transm Infect. 2021;97:134–40. doi: 10.1136/sextrans-2020-054790

189 van Loo IHM, Dukers-Muijrers NHTM, Heuts R, et al. Screening for HIV, hepatitis B and syphilis on dried blood spots: A promising method to better reach hidden high-risk populations with self-collected sampling. PloS One. 2017;12:e0186722. doi: 10.1371/journal.pone.0186722

190 Norelli J, Zlotorzynska M, Sanchez T, et al. Scaling Up CareKit: Lessons Learned from Expansion of a Centralized Home HIV and Sexually Transmitted Infection Testing Program. Sex Transm Dis. 2021;48:S66–70. doi: 10.1097/OLQ.0000000000001473

191 Lunny C, Taylor D, Hoang L, et al. Self-Collected versus Clinician-Collected Sampling for Chlamydia and Gonorrhea Screening: A Systemic Review and Meta-Analysis. PloS One. 2015;10:e0132776. doi: 10.1371/journal.pone.0132776

192 Ogale Y, Yeh PT, Kennedy CE, et al. Self-collection of samples as an additional approach to deliver testing services for sexually transmitted infections: a systematic review and meta-analysis. BMJ Glob Health. 2019;4:e001349. doi: 10.1136/bmjgh-2018-001349

193 Chow EPF, Bradshaw CS, Williamson DA, et al. Changing from Clinician-Collected to Self-Collected Throat Swabs for Oropharyngeal Gonorrhea and Chlamydia Screening among Men Who Have Sex with Men. J Clin Microbiol. 2020;58:e01215-20. doi: 10.1128/JCM.01215-20

194 Holzmayer V, Taylor R, Kuhns MC, et al. Evaluation of hepatitis C virus antibody assay using dried blood spot samples. Sci Rep. 2022;12:3763. doi: 10.1038/s41598-022-07821-0

195 Yamamoto C, Nagashima S, Isomura M, et al. Evaluation of the efficiency of dried blood spot-based measurement of hepatitis B and hepatitis C virus seromarkers. Sci Rep. 2020;10:3857. doi: 10.1038/s41598-020-60703-1

196 Rahib D, Bercot B, Delagreverie H, et al. Online self-sampling kits for human immunodeficiency virus and other sexually transmitted infections: Feasibility, positivity rates, and factors associated with infections in France. Int J STD AIDS. 2022;33:355–62. doi: 10.1177/09564624211066447

197 Rahib D, Lydié N. Effect of a HIV screening program offering reminders and at home solutions in French men who have sex with men. IUSTI conference 2022. Victoria falls, Zimbabwe.

198 Haute Autorité de Santé. La notification au(x) partenaire(s). Recommandation. 2023. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3187510/fr/la-notification-au-x-partenaire-s

199 Conseil National Sida. Avis suivi de recommandations sur la notification formalisée aux partenaires. 2018. https://cns.sante.fr/actualites/notification-formalisee-aux-partenaires-nouvel-avis-cns/

200 European Centre for Disease Prevention and Control. ECDC report: Public health benefits of partner notification for sexually transmitted infections and HIV. 2013. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/Partner-notification-for-HIV-STI-June-2013.pdf

201 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Recommendations for partner services programs for HIV infection, syphilis, gonorrhea, and chlamydial infection. MMWR Recomm Rep Morb Mortal Wkly Rep Recomm Rep. 2008;57:1–4.

202 Society of sexual health Advisers. Guidance on Partner Notification. 2015. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjXrNySiuqDAxUNUqQEHZ8rBdwQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fssha.info%2Fwp-content%2Fuploads%2Fssha-guidance-on-partner-notification-aug-2015.pdf&usg=AOvVaw3zqfGtmWLjtcmTmmBQrOJQ&opi=899

203 Dalal S, Johnson C, Fonner V, et al. Improving HIV test uptake and case finding with assisted partner notification services. AIDS. 2017;31:1867–1876.

204 Kerani RP, Fleming M, Golden MR. Acceptability and intention to seek medical care after hypothetical receipt of patient-delivered partner therapy or electronic partner notification postcards among men who have sex with men: the partner's perspective. Sex Transm Dis. 2013;40:179–185.

205 Champenois K, Sawras V, Hoyer M, et al. La notification des IST aux partenaires : que font les usagers des centres de dépistage sans intervention ? Congrès de la SFLS 2023. Tours, France.

206 Atramont A, Le Vu S. Analyse du public touché lors de l'opération Flash Test 2013 de dépistage rapide du VIH dans quatre régions françaises. Bull Epidémiologique Hebd. 2014;32–33.

207 Raben D, Kahama CB, Combs L, et al. The use and impact of European Testing Week regional awareness campaigns to increase HIV and viral hepatitis testing coverage. HIV Med. 2024;25:154–60. doi: 10.1111/hiv.13544

208 Gasbarrini N, Dubravić D, Combs L, et al. Increasing integrated testing in community settings through interventions for change, including the Spring European Testing Week. BMC Infect Dis. 2021;21:874. doi: 10.1186/s12879-021-06555-0

209 den Daas C, Meddens EM, van Bergen J, et al. Increasing awareness and prompting HIV testing: Contributions of Amsterdam HIV Testing Week 2016. Int J STD AIDS. 2018;29:1057–65. doi: 10.1177/0956462418770014

210 Bartelsman M, Joore IK, van Bergen JE, et al. HIV testing week 2015: lowering barriers for HIV testing among high-risk groups in Amsterdam. BMC Infect Dis. 2017;17:529. doi: 10.1186/s12879-017-2617-0

211 Soh QR, Oh LYJ, Chow EPF, et al. HIV Testing Uptake According to Opt-In, Opt-Out or Risk-Based Testing Approaches: a Systematic Review and Meta-Analysis. Curr HIV/AIDS Rep. 2022;19:375–83. doi: 10.1007/s11904-022-00614-0

212 The Lancet HIV editorial. Opt-out HIV testing in the UK. Lancet HIV. 2023;10:e351. doi: 10.1016/S2352-3018(23)00117-0

213 Hutchinson AB, Corbie-Smith G, Thomas SB, et al. Understanding the patient's perspective on rapid and routine HIV testing in an inner-city urgent care center. AIDS Educ Prev. 2004;16:101–14. doi: 10.1521/aeap.16.2.101.29394

214 Henriquez-Camacho C, Villafuerte-Gutierrez P, Pérez-Molina JA, et al. Opt-out screening strategy for HIV infection among patients attending emergency departments: systematic review and meta-analysis. HIV Med. 2017;18:419–29. doi: 10.1111/hiv.12474

215 Sanders EJ, Agutu C, van der Elst E, et al. Effect of an opt-out point-of-care HIV-1 nucleic acid testing intervention to detect acute and prevalent HIV infection in symptomatic adult outpatients and reduce HIV transmission in Kenya: a randomized controlled trial. HIV Med. 2022;23:16–28. doi: 10.1111/hiv.13157

216 Branson B, Handsfield H, Lampe M, et al. Revised Recommendations for HIV Testing of Adults, Adolescents, and Pregnant Women in Health-Care Settings. MMWR Recomm Rep Morb Mortal Wkly Rep Recomm Rep. 2006;55:1–17.

217 World Health Organization. Guidance on Provider-initiated HIV Testing and Counselling in Health Facilities. 2007. https://digitallibrary.un.org/record/3964908?ln=fr

218 Spielberg F, Kurth A, Gorbach PM, et al. Moving from apprehension to action: HIV counseling and testing preferences in three at-risk populations. AIDS Educ Prev. 2001;13:524–40. doi: 10.1521/aeap.13.6.524.21436

219 Deblonde J, De Koker P, Hamers FF, et al. Barriers to HIV testing in Europe: a systematic review. Eur J Public Health. 2010;20:422–32. doi: 10.1093/eurpub/ckp231

220 Bell S, Delpech V, Raben D, et al. HIV pre-test information, discussion or counselling? A review of guidance relevant to the WHO European Region. Int J STD AIDS. ;27:97–104.

221 Das S, Huengsberg M, Radcliffe K. Impact of information leaflets on HIV test uptake amongst GUM clinic attendees: an update. Int J STD AIDS. 2004;15:422–3. doi: 10.1258/095646204774195308

222 Croxford S, Yin Z, Burns F, et al. Linkage to HIV care following diagnosis in the WHO European Region: A systematic review and meta-analysis, 2006-2017. PloS One. 2018;13:e0192403. doi: 10.1371/journal.pone.0192403

223 Cuzin L, Cotte L, Delpierre C, et al. Too fast to stay on track? Shorter time to first anti-retroviral regimen is not associated with better retention in care in the French Dat'AIDS cohort. PloS One.

2019;14:e0222067. doi: 10.1371/journal.pone.0222067

224 Bouchaud O, Hamel E, Soleymani D. La médiation en santé : un nouveau métier pour lever les obstacles aux parcours de soin et de prévention. Santé En Action. 2022;460.

225 Caisse Nationale d'assurance maladie. Cartographie des pathologies et des dépenses de l'Assurance Maladie. Personnes prises en charge pour infection par le VIH en 2022. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/cartographie-fiche-vih-sida

226 Santé publique France. Bulletin de santé publique VIH-IST. Novembre 2023. https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-vih-ist.-decembre-2023

227 Institut de veille sanitaire. Surveillance du sida en France. Situation au 30 septembre 2001. Bull Epidémiologique Hebd. 2002;47. https://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2001/47/index.html

228 Jauffret-Roustide M, Pillonel J, Lot F, et al. Critical situation concerning HIV exposure among people who inject drugs in France: results from ANRS-Coquelicot surveys and HIV monitoring system. IAS conference 2017. Paris, France

229 Gosselin A, Carillon S, Coulibaly K, et al. Participatory development and pilot testing of the Makasi intervention: a community-based outreach intervention to improve sub-Saharan and Caribbean immigrants' empowerment in sexual health. BMC Public Health. 2019;19:1646. doi: 10.1186/s12889-019-7943-2

230 Mitjà O, Padovese V, Folch C, et al. Epidemiology and determinants of reemerging bacterial sexually transmitted infections (STIs) and emerging STIs in Europe. Lancet Reg Heal. 2023;34.

231 Mangin F, Sulli L, Matra R, et al. Dépistage du VIH, des hépatites et des IST chez les personnes migrantes primo-arrivantes au Caso de Médecins du Monde de Saint-Denis, de 2012 à 2016. Bull Épidémiologique Hebd. 2018;40–41:12.

232 Bonneton M, Surgers L, Lalande V, et al. Chlamydia trachomatis devrait-il faire l'objet d'un dépistage systématique chez les migrants? Médecine Mal Infect. 2020;50:S141.

233 Arnaud Alessandrin, Anastasia Medaini, Jean-Pierre Droz. Participatory development and pilot testing of the Makasi intervention: a community-based outreach intervention to improve sub-Saharan and Caribbean immigrants' empowerment in sexual health. Bull Cancer. 2023;110:6.

234 Cosne M. Santé des personnes transgenres 2021. Étude quantitative explorant la santé, l'accès aux soins et les discriminations vécues par les personnes transgenres en France en 2021. Médecine Humaine et Pathologie. 2022.

235 Peitzmeier S, M R, S. L, et al. Female-to-male patients have high prevalence of unsatisfactory Paps compared to non-transgender females: implications for cervical cancer screening. J Gen Intern Med. 2014;29:6.

236 Weyers S, Garland SM, Cruickshank M, et al. Cervical cancer prevention in transgender men: a review. BJOG. 2021;128:822–6.

237 van der Sluis WB, Buncamper ME, Bouman M-B, et al. Symptomatic HPV-related neovaginal lesions in transgender women: case series and review of literature. Sex Transm Infect. 2016 ;92(7):499-501. doi: 10.1136/sextrans-2015-052456

238 Haute Autorité de Santé. Etat de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et facteurs de vulnérabilité sanitaire. Saint Denis: HAS 2016. https://www.has-sante.fr/jcms/c_2615057/fr/etat-de-sante-des-personnes-en-situation-de-prostitution-et-des-travailleurs-du-sexe-et-identification-des-facteurs-de-vulnerabilite-sanitaire

239 Piron P, Shelly M, Peltier A, et al. Des actions de dépistage hors les murs pour aller vers les populations les plus à risque: bilan d'un CeGIDD parisien en 2017. Rev Epidémiol Santé Publique. 2018;66:S51.

240 Grisélidis. Rapport d'activité 2022. Toulouse: Grisélidis 2023. https://griselidis.com/node/14

241 van Rooijen MS, van der Loeff MFS, van Kempen L, et al. Sexually transmitted infection positivity rate and treatment uptake among female and male sexual assault victims attending the Amsterdam STI clinic between 2005 and 2016. Sex Transm Dis. 2018;45:534.

242 Jauréguy F, Chariot P, Vessières A, et al. Prevalence of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae infections detected by real-time PCR among individuals reporting sexual assaults in the Paris, France area. Forensic Sci Int. 2016;266:130–3.

243 Scannell-Tocci M, Reynolds R. A review of sexual transmitted infection rates among sexually assaulted patients that present for care. J Forensic Leg Med. 2022;88:102352.

Participants

Coordination

Pr Pierre Delobel, infectiologue, CHU de Toulouse

Groupe de travail

Groupe de travail « Epidémiologie, prévention, dépistage et déterminants sociaux de l'infection VIH en France » sous la direction du Dr Karen Champenois (épidémiologiste, IAME, Inserm UMR1137, Paris) et du Dr Cyrille Delpierre (épidémiologiste, Inserm U1295, Toulouse) :

Sous-groupe de travail « Prévention de l'infection VIH » sous la direction du Dr Bruno Spire (médecin, chercheur en santé publique, SeSSTIM, Inserm U1252, Marseille & association AIDES) :

Dr Arnaud Blanc, médecin généraliste, Morangis, AP-HP Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

Dr Karen Champenois, épidémiologiste, IAME Inserm UMR1137, Paris

Dr Lise Cuzin, médecin de santé publique, CHU de la Martinique

Mr Hugues Fischer, représentant associatif, Act-Up Paris, TRT-5 CHV

Dr Mojgan Hessamfar, médecin de santé publique, COREVIH Nouvelle Aquitaine, CHU de Bordeaux, Bordeaux

Mme Diane Leriche, représentante associatif, coordinatrice, TRT-5 CHV

Dr Romain Palich, infectiologue, AP-HP Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Sous-groupe de travail « Dépistage de l'infection VIH » sous la direction du Dr Karen Champenois (épidémiologiste, IAME Inserm UMR1137, Paris) :

Dr Arnaud Blanc, médecin généraliste, Morangis, AP-HP Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

Dr Marie-Laure Chaix, virologue, CNR du VIH, AP-HP Hôpital Saint-Louis, Paris

Dr Lise Cuzin, médecin de santé publique, CHU de la Martinique

Dr Cyrille Delpierre, épidémiologiste, Inserm U1295, Toulouse

Dr Annabel Desgrees Du Lou, démographe, de la santé, CEPED, IRD, Paris

Mr Hugues Fischer, représentant associatif, Act-Up Paris, TRT-5 CHV

Dr Sophie Grabar, médecin de santé publique, IPLESP Inserm UMR1136 et AP-HP Hôpital Saint-Antoine, Paris

Dr Mojgan Hessamfar, médecin de santé publique, COREVIH Nouvelle Aquitaine, CHU de Bordeaux, Bordeaux

Mme Diane Leriche, représentante associatif, coordinatrice, TRT-5 CHV

Dr Florence Lot, médecin de santé publique, direction des maladies infectieuses, Santé publique France

Dr Romain Palich, infectiologue, AP-HP Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Dr Bruno Spire, médecin, chercheur en santé publique, SeSSTIM, Inserm U1252, Marseille & association AIDES

Avec la participation du Dr Delphine Rahib, épidémiologiste, Santé publique France (groupe de travail « Epidémiologie des IST »)

Groupe de lecture

Dr Julien Artigny, médecin généraliste, Toulouse

Dr Cédric Arvieux, infectiologue, COREVIH Bretagne, CHU de Rennes

Mme Catherine Aumond, représentante associative, AIDES, Tours

Mr Franck Barbier, représentant associatif, AIDES, Paris

Dr Michel Bourrelly, pharmacien, SeSSTIM, Inserm U1252, Marseille

Dr Agnès Certain, pharmacienne, AP-HP Hôpital Bichat, Paris

Dr Marie Chauveau, médecin généraliste, Tournefeuille

Dr Dominique Costagliola, épidémiologiste, IPLESP Inserm UMR1136, Paris

Pr Constance Delaugerre, virologue, AP-HP Hôpital Saint-Louis, Paris

Pr Olivier Epaulard, infectiologue, CHU de Grenoble

Dr Gabriel Girard, sociologue, SeSSTIM, Inserm U1252, Marseille

Dr Thibaut Jedrzejewski, médecin généraliste, centre de santé sexuelle - Le 190, Paris

Mr Franck Marcé, Sida Info Service, Montpellier

Pr Laurence Meyer, médecin de santé publique, Inserm SC10, AP-HP Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

Mme Céline Offerlé, représentante associatif, directrice, TRT-5 CHV

Pr Gilles Pialoux, infectiologue, AP-HP Hôpital Tenon, Paris

Dr Pascal Pugliese, médecin, COREVIH PACA-Est, CHU de Nice

Dr Delphine Rahib, épidémiologiste, Santé publique France

Dr Stéphanie Vandentorren, épidémiologiste, Santé publique France

Dr Annie Velter, socio-démographe, Santé publique France

Groupe transversal de synthèse des recommandations VIH

Dr Fanny Alby-Laurent, pédiatre, AP-HP Hôpital Trousseau, Paris

Dr Cédric Arvieux, infectiologue, CHU de Rennes

Pr Véronique Avettand-Fenoël, virologue, CHU d'Orléans

Pr Fabrice Bonnet, interniste, CHU de Bordeaux

Dr Julie Bottero, infectiologue, AP-HP Hôpital Avicenne, Bobigny

Pr Olivier Bouchaud, infectiologue, AP-HP Hôpital Avicenne, Bobigny

Pr André Cabie, infectiologue, CHU de la Martinique

Dr Karen Champenois, épidémiologiste, Inserm, Paris

Pr Antoine Cheret, infectiologue, CHU de la Guadeloupe

Dr Guillaume Conort, médecin généraliste, Penne-d'Agenais

Dr Cyrille Delpierre, épidémiologiste, Inserm, Toulouse

Dr Catherine Dollfus, pédiatre, AP-HP Hôpital Trousseau, Paris (jusqu'au 19/03/2024)

Pr Albert Faye, pédiatre, AP-HP Hôpital Robert Debré, Paris

Mr Hugues Fischer, représentant associatif, Act Up Paris, TRT-5 CHV

Pr Cécile Goujard, interniste, AP-HP Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

Dr Christine Jacomet, infectiologue, CHU de Clermont-Ferrand (jusqu'au 01/12/2022)

Dr Marie Lachatre, infectiologue, AP-HP Hôpital Cochin et Hôpital Necker, Paris

Pr Fanny Lanternier, infectiologue, AP-HP Hôpital Necker, Paris

Mme Marianne L'Henaff, représentante associatif, Arcat, TRT-5 CHV

Dr Florence Lot, épidémiologiste, Santé publique France

Pr Alain Makinson, infectiologue, CHU de Montpellier

Pr Laurent Mandelbrot, gynécologue-obstétricien, AP-HP Hôpital Louis-Mourier, Colombes

Pr Sophie Matheron, infectiologue, AP-HP Hôpital Bichat, Paris

Dr Olivier Paccoud, infectiologue, AP-HP Hôpital Necker, Paris

Mme Hélène Pollard, représentante associatif, Sol En Si, TRT-5 CHV

Dr David Rey, infectiologue, CHU de Strasbourg

Dr Quentin Richier, infectiologue, AP-HP Hôpital Saint-Antoine, Paris

Pr Caroline Solas, pharmacologue, AP-HM Hôpital de la Timone Marseille

Dr Cathia Soulie, virologue, AP-HP Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Dr Roland Tubiana, infectiologue, AP-HP Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Dr Stéphane Tuffier, médecin de santé publique, Copenhague, Danemark

Remerciements

Le CNS et l'ANRS-MIE tiennent à remercier l'ensemble des participants cités ci-dessus.

Table des figures

Figure 1: Algorithme de dépistage de l'infection VIH **27**

Abréviations et acronymes

ADVIH	Autotest de dépistage du VIH
ALSO	Au labo sans ordo
AMM	Autorisation de mise sur le marché
ANRS | MIE	Agence nationale de recherches sur le SIDA et les hépatites virales | Maladies infectieuses émergentes
ARN	Acide ribonucléique
ARS	Agence régionale de santé
ARV	Antirétroviraux
CAARUD	Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
CeGIDD	Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
CNAM	Caisse nationale d'assurance maladie
CPAM	Caisse primaire d'assurance maladie
CNS	Conseil national du SIDA et des hépatites virales
CORESS	Comité de coordination régionale de la santé sexuelle
COREVIH	Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH
CPEF	Centre de planification ou d'éducation familiale
CSAPA	Centres de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie
CSSAC	Centre de santé sexuelle d'approche communautaire
CT	*Chlamydia trachomatis*
DFA	Départements français d'Amérique
DGS	Direction générale de la santé
ECDC	European centre for diseases prevention and control
ELISA	Enzyme linked immuno-sorbent assay
ERAS	Enquête Rapport au sexe
FSF	Femme ayant des rapports sexuels avec les femmes
FTC	emtricitabine
HAS	Haute autorité de santé
HPV	Human papillomavirus
HSH	Homme ayant des rapports sexuels avec les hommes
IGAS	Inspection générale des affaires sociales
IST	Infection sexuellement transmissible
IUSTI	International union against sexually transmitted infections
LBM	Laboratoire de biologie médicale
LGV	Lympho-granulomatose vénérienne
Mpox	Virus monkeypox

NG	*Neisseria gonorrhoeae*
NPS	Nouveaux produits de synthèse
OFDT	Observatoire français des drogues et des toxicomanies
OMS	Organisation mondiale de la santé
PASS	Permanence d'accès aux soins de santé
PrEP	Prophylaxie pré-exposition
PVVIH	Personne vivant avec le VIH
QALY	Année de vie gagnée ajustée sur la qualité de vie
ROSP	Rémunération sur objectifs de santé publique
SIDA	Syndrome d'immunodéficience acquise
SMIT	Service des maladies infectieuses et tropicales
SNDS	Système national des données de santé
SNSS	Stratégie nationale de santé sexuelle
TasP	Treatment as Prevention
TDF	Tenofovir disoproxyl fumarate
TFA	Territoire français d'Amérique
TPE	Traitement post-exposition
TROD	Test rapide d'orientation diagnostique
UDI	Usager de drogue intraveineuse
VHA	Virus de l'hépatite A
VHB	Virus de l'hépatite B
VHC	Virus de l'hépatite C
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine

Annexe

Tableau récapitulatif des évènements classant sida et des autres maladies ou conditions évocatrices du VIH (tableau issu des recherches HIDES 2 [105] et OptTest [103])

Maladies classant SIDA	Autres conditions évocatrices du VIH
Cancer du col de l'utérus	Pneumonie communautaire
Lymphome non-hodgkinien	Infection invasive à pneumocoque
Sarcome de Kaposi	Méningite lymphocytaire
Lymphome cérébral primaire	Syndrome de Guillain-Barré
Tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire	Démence subcorticale
Infection à Mycobacterium avium, kansasii, xenopi ou autre atypique, disséminée ou extra pulmonaire	Neuropathie périphérique
Pneumonie récurrente (≥2 épisodes / 12 mois)	Lésion cérébrale primaire
Septicémie récidivante à Salmonella non Typhi	Mononévrite
Rétinite à cytomégalovirus	Syndrome multi sclérosant
Autre infection à cytomégalovirus (sauf foie, rate et ganglions)	Abcès cérébral
Infection à Herpès simplex virus (cutanéo-muqueuse ulcérée > 1 mois, bronchique, pulmonaire ou oesophagienne)	Zona (< 65 ans)
Leucoencéphalite multifocale progressive	Dermite séborrhéique ou exanthème
Toxoplasmose cérébrale	Psoriasis sévère ou atypique
Cryptosporidiose (diarrhée > 1 mois)	Hépatite A
Isosporose (diarrhée > 1 mois)	Hépatite B (aigue ou chronique)
Pneumocystose	Hépatite C (aigue ou chronique)
Candidose œsophagienne	Perte de poids inexpliquée
Candidose bronchique, trachéale, pulmonaire	Candidose orale inexpliquée
Cryptococcose extra-pulmonaire	Diarrhées chroniques inexpliquées
Histoplasmose disséminée ou extra-pulmonaire	Leucoplasie chevelue
Coccidiodomycose disséminée ou extra-pulmonaire	Syndrome néphrotique idiopathique
	Lymphome malin ou lymphome Hodgkinien
	Leucocytopénie ou thrombocytopénie > 4 semaines inexpliquée
	Purpura thrombocytopénique idiopathique ou thrombotique
	Cancer primaire du poumon
	Cancer ou displasie anale
	Dysplasie cervicale

	Maladie de Castleman
	Infection de la rétine à Herpès simplex virus ou Toxoplasma
	Grossesse
	Infection sexuellement transmissible
	Fièvre inexpliquée
	Lymphadénopathie inexpliquée
	Syndrome mononucléosique
	Candidémie
	Leishmaniose viscérale
	Candidose
	Condition requérant une thérapie immunosuppressive agressive (hors cancer)
	Leishmaniose atypique disséminée
	Trypanosomiase (méningoencéphalite ou myocardite)
	Infection à penicillium disséminée

L'ANRS Maladie infectieuses émergentes et le CNS, ont été missionnés par le ministre chargé de la santé pour conduire une actualisation des recommandations françaises de prise en charge du VIH, des hépatites virales, et des IST.

L'actualisation des recommandations est placée sous la responsabilité du Pr. Pierre Delobel.

Les travaux sont réalisés sous l'égide de l'ANRS | MIE et du CNS, et de la HAS pour les chapitres ayant trait aux aspects de thérapeutique anti-infectieuse, curative et préventive.

Retrouvez tous les chapitres sur
www.cns.sante.fr et www.anrs.fr

CNS
Conseil national du sida
et des hépatites virales

anrs
MALADIES INFECTIEUSES ÉMERGENTES
Inserm